

*Buku Referensi*

# **KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN**

**Dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional**

Yupi Supartini • Sondang Manurung  
Nevi Kuspiana Lesmana • Emi Pebriani • Eliza • Sarwoko



# **BUKU REFERENSI**

## **KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN**

### **KEPERAWATAN DALAM TRANSFORMASI**

### **SISTEM KESEHATAN NASIONAL**

#### **Penulis**

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.  
Sondang Manurung, S.Kp., M.Kep.  
Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.  
Ns. Emi Pebriani, S.Kep., M.Kep.  
Eliza, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kep.  
Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.



**Buku Referensi : Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan Dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional**

**Penulis:**

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.  
Sondang Manurung, S.Kp., M.Kep.  
Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.  
Ns. Emi Pebriani, S.Kep., M.Kep.  
Eliza, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kep.  
Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano

**Penata Letak:** Khoirul Anam

**ISBN:** 978-634-7756-25-1

**Cetakan Pertama:** Mei, 2026

Hak Cipta 2026

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2026**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan  
Jakarta Barat

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul *Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dan praktis dalam memperkaya literatur keperawatan, khususnya dalam bidang kepemimpinan dan manajemen yang semakin relevan di tengah dinamika transformasi sistem kesehatan nasional.

Transformasi sistem kesehatan nasional menuntut perubahan yang komprehensif, tidak hanya pada aspek kebijakan dan tata kelola, tetapi juga pada kapasitas kepemimpinan dan manajerial tenaga kesehatan, terutama perawat sebagai garda terdepan pelayanan. Perawat memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta keberlanjutan sistem layanan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan kompetensi kepemimpinan dan manajemen keperawatan menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan perubahan, perkembangan teknologi, serta kompleksitas kebutuhan masyarakat.

Buku ini mengawali pembahasan dengan teori kepemimpinan dalam keperawatan yang menjadi landasan konseptual bagi praktik kepemimpinan profesional. Berbagai pendekatan dan model kepemimpinan dikaji secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemimpin keperawatan dalam berbagai konteks layanan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia keperawatan menyoroti perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, serta evaluasi kinerja perawat sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas dan kualitas layanan. Aspek ini menjadi krusial dalam memastikan distribusi tenaga yang efektif dan berkelanjutan.

Bab mengenai mutu pelayanan dan keselamatan pasien menguraikan prinsip-prinsip peningkatan mutu, manajemen risiko, serta budaya keselamatan yang harus dibangun dalam organisasi pelayanan kesehatan. Hal ini diperkuat dengan pembahasan tentang akreditasi rumah sakit dan standar praktik keperawatan, yang menempatkan perawat sebagai aktor penting dalam pemenuhan standar nasional maupun internasional.

Selain itu, buku ini juga membahas manajemen konflik dan komunikasi organisasi, sebagai keterampilan esensial dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan profesional. Tantangan psikososial dalam praktik keperawatan turut diangkat melalui pembahasan mengenai burnout dan kesejahteraan perawat, yang menjadi isu strategis dalam menjaga keberlanjutan tenaga keperawatan.



Sebagai respons terhadap dinamika global dan krisis kesehatan, buku ini menekankan pentingnya transformational leadership dalam menghadapi krisis kesehatan. Pendekatan kepemimpinan transformatif diharapkan mampu mendorong inovasi, adaptasi, serta ketahanan organisasi dalam situasi darurat dan perubahan sistemik.

Buku referensi ini disusun dengan pendekatan ilmiah, sistematis, dan aplikatif agar dapat digunakan oleh mahasiswa keperawatan, dosen, peneliti, manajer keperawatan, serta praktisi layanan kesehatan. Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam mengembangkan kepemimpinan keperawatan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada mutu.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi selanjutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan peran keperawatan dalam transformasi sistem kesehatan nasional.

Mei, 2026

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PRAKATA.....</b>                                                                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                  | <b>v</b>   |
| <br>                                                                                                    |            |
| <b>BAB 1 TEORI KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN.....</b>                                                  | <b>1</b>   |
| A.    Pendahuluan.....                                                                                  | 1          |
| B.    Dasar-Dasar Teori Kepemimpinan.....                                                               | 2          |
| C.    Evolusi Teori Kepemimpinan: Dari Teori Trait hingga Teori Kontekstual .....                       | 3          |
| D.    Teori Kepemimpinan Transformasional: Fondasi Perubahan di Keperawatan .....                       | 5          |
| E.    Teori Kepemimpinan Transaksional: Keseimbangan dengan Pendekatan<br>Reward-Punishment.....        | 6          |
| F.    Kepemimpinan Pelayan dan Kepemimpinan Otentik: Humanisasi dalam<br>Konteks Budaya Indonesia.....  | 8          |
| G.    Kepemimpinan Situasional dan Kepemimpinan Adaptif: Respons Dinamis<br>terhadap Transformasi ..... | 10         |
| H.    Integrasi Teori Kepemimpinan dengan Transformasi Sistem Kesehatan<br>Nasional.....                | 13         |
| I.    Penutup .....                                                                                     | 16         |
| <b>Referensi .....</b>                                                                                  | <b>18</b>  |
| <br>                                                                                                    |            |
| <b>BAB 2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA KEPERAWATAN .....</b>                                           | <b>20</b>  |
| A.    Pendahuluan.....                                                                                  | 20         |
| B.    Manajemen Sumber Daya Manusia Keperawatan .....                                                   | 21         |
| C.    Perencanaan Sumber Daya Manusia Keperawatan .....                                                 | 23         |
| C.    Rekrutmen dan Seleksi Perawat.....                                                                | 25         |
| D.    Orientasi dan Induksi Tenaga Keperawatan.....                                                     | 27         |
| E.    Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan.....                                         | 29         |
| F.    Penutup .....                                                                                     | 31         |
| <b>Referensi .....</b>                                                                                  | <b>33</b>  |
| <b>Glosarium.....</b>                                                                                   | <b>34</b>  |

**BAB 3 MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN ..... 36**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| A. Pendahuluan.....                                     | 36        |
| B. Konsep Mutu Pelayanan.....                           | 36        |
| C. Dimensi Mutu Pelayanan.....                          | 37        |
| D. Standar Mutu Pelayanan .....                         | 38        |
| E. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan .....        | 38        |
| F. Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan .....            | 39        |
| G. Penilaian Mutu Pelayanan.....                        | 39        |
| H. Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan .....         | 40        |
| I. Konsep Keselamatan Pasien.....                       | 40        |
| J. Sasaran Keselamatan Pasien .....                     | 41        |
| K. Standar Keselamatan Pasien3.....                     | 41        |
| L. Budaya Keselamatan Pasien.....                       | 42        |
| M. Ciri-ciri Budaya Keselamatan Pasien .....            | 42        |
| N. Jenis Insiden Keselamatan Pasien .....               | 43        |
| O. Faktor Risiko Keselamatan Pasien.....                | 43        |
| P. Strategi dan Intervensi Keselamatan Pasien.....      | 43        |
| Q. Kepemimpinan dan Budaya Keselamatan.....             | 44        |
| R. Sistem Pelaporan dan Manajemen Resiko.....           | 45        |
| S. Teknologi dan Inovasi dalam Keselamatan Pasien ..... | 46        |
| T. Hubungan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien ..... | 46        |
| U. Penutup .....                                        | 47        |
| <b>Referensi .....</b>                                  | <b>49</b> |
| <b>Glosarium.....</b>                                   | <b>51</b> |

**BAB 4 MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMUNIKASI ORGANISASI ..... 56**

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Pendahuluan.....                                                                              | 56        |
| B. Konsep Manajemen dan Manajemen Keperawatan Dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional ..... | 56        |
| C. Komunikasi Efektif dalam Manajemen Keperawatan.....                                           | 57        |
| D. Manajemen Konflik dan Komunikasi Organisasi .....                                             | 60        |
| E. Strategi Manajemen Konflik dalam Organisasi .....                                             | 62        |
| F. Penutup .....                                                                                 | 65        |
| <b>Referensi .....</b>                                                                           | <b>66</b> |
| <b>Glosarium.....</b>                                                                            | <b>69</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 5 BURNOUT DAN KESEJAHTERAAN PERAWAT .....</b>         | <b>71</b> |
| A. Pendahuluan .....                                         | 71        |
| B. Konsep Dasar Burnout .....                                | 71        |
| C. Profesi Perawat dan Risiko Burnout .....                  | 73        |
| D. Dampak Burnout pada Profesi Perawat .....                 | 75        |
| E. Kesejahteraan Perawat .....                               | 76        |
| F. Strategi Penanganan Burnout .....                         | 76        |
| G. Konsep Kesejahteraan Perawat .....                        | 77        |
| H. Hubungan Burnout dengan Kesejahteraan Perawat .....       | 80        |
| I. Intervensi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perawat ..... | 82        |
| J. Implikasi Kebijakan dan Manajemen Rumah Sakit .....       | 85        |
| K. Penutup .....                                             | 85        |
| <b>Referensi .....</b>                                       | <b>87</b> |
| <b>Glosarium .....</b>                                       | <b>88</b> |

## **BAB 6 TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DALAM MENGHADAPI KRISIS**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KESEHATAN .....</b>                                                     | <b>91</b>  |
| A. Pendahuluan .....                                                       | 91         |
| B. Kepemimpinan Transformasional .....                                     | 91         |
| C. Krisis Kesehatan dan Dampaknya pada Praktik Keperawatan .....           | 111        |
| D. Peran dan Kompetensi Pemimpin Transformasional dalam Krisis .....       | 112        |
| E. Dimensi Kepemimpinan Transformasional dalam Krisis .....                | 113        |
| F. Strategi Implementasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....            | 114        |
| G. Pengembangan Kapasitas dan Pendidikan Kepemimpinan .....                | 115        |
| H. Studi Kasus Penerapan di Indonesia .....                                | 115        |
| I. Strategi dan Indikator Kepemimpinan Transformasional dalam Krisis ..... | 116        |
| J. Penutup .....                                                           | 117        |
| <b>Referensi .....</b>                                                     | <b>119</b> |
| <b>Glosarium .....</b>                                                     | <b>122</b> |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>PROFIL PENULIS .....</b> | <b>123</b> |
|-----------------------------|------------|





# BAB 1

## TEORI KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN

### A. Pendahuluan

---

Sementara dunia kesehatan modern semakin berkembang pesat, isu kepemimpinan dalam keperawatan juga semakin berkembang dari konsep pengawasan klinis yang tradisional menjadi sebuah disiplin ilmu yang semakin rumit dan canggih yang sekarang ini berfokus pada konsep modal manusia (human capital) (Yakusheva et al., 2024) dan transformasi menyeluruh (Yakusheva et al., 2024). Kepemimpinan keperawatan tidak lagi hanya didefinisikan sebagai kebutuhan administratif melainkan menjadi sebagai proses pengaruh yang dinamis yang secara langsung mempengaruhi keselamatan pasien (Lee et al., 2023), budaya organisasi (Xenikou & Furnham, 2022), dan keberlanjutan tenaga kerja kesehatan (de-Diego-Cordero et al., 2025). Sebagai garda depan dalam dunia pelayanan kesehatan, para pemimpin perawat menempati posisi penting dan unik yang meminta mereka untuk dapat menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan di tingkat tinggi dan realitas yang nyata di ruang pasien. Tanggung jawab ganda ini memerlukan penguasaan berbagai teori kepemimpinan yang dapat disesuaikan dengan tuntutan yang berubah-ubah dari lingkungan pelayanan kesehatan.

Kepemimpinan keperawatan bukan hanya sekadar sebuah jabatan atau posisi. Hal ini merupakan sebuah seni yang menggabungkan keterampilan, empati, dan keilmuan yang dapat menciptakan dampak positif (Zivkovic, 2022). Di tengah dinamika yang terus berubah dalam dunia kesehatan, pemimpin keperawatan harus siap menghadapi berbagai tantangan. Definisi menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama (Orukwogu, 2022). Dalam dunia keperawatan, pengaruh ini sangat berharga, terutama dalam mendorong perubahan yang diperlukan untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Oleh karenanya, seiring waktu teori-teori kepemimpinan telah berkembang, mencerminkan perubahan dalam sistem kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, ahli lain menekankan bahwa kepemimpinan dalam keperawatan tidak hanya tentang bagaimana mengelola tim, tetapi juga tentang pengembangan diri dan peningkatan keterampilan (Giltinane, 2020). Oleh karenanya, pemimpin perawat diharapkan

menjadi agen perubahan yang responsif, mampu menanggapi kebutuhan pasien dan tantangan yang semakin kompleks pada sistem kesehatan.

Bab ini akan menyajikan berbagai teori kepemimpinan yang relevan dengan praktik keperawatan, mulai dari teori kontingensi hingga transformasi kepemimpinan keperawatan dalam konteks Indonesia. Memahami teori-teori ini tidak hanya membantu pemimpin keperawatan dalam mengelola tim secara efektif, tetapi juga memberi mereka kemampuan untuk menginspirasi dan memberdayakan anggota tim. Secara teoritis, peneliti kepemimpinan menyatakan bahwa pemimpin yang efektif dalam keperawatan tidak hanya mengarahkan, tetapi juga memberdayakan tim untuk berkontribusi secara optimal (Hall et al., 2022). Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori kepemimpinan yang relevan dalam keperawatan, serta bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks sistem kesehatan nasional. Dengan pemahaman ini, para profesional keperawatan akan dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan serta memberikan kontribusi yang lebih baik dalam transformasi sistem kesehatan secara berkesinambungan.

## **B. Dasar-Dasar Teori Kepemimpinan**

---

Kepemimpinan dalam keperawatan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tim dalam memberikan perawatan yang berkualitas kepada pasien. Ini bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi lebih kepada menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Kepemimpinan dalam keperawatan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi orang lain, membangun tim yang solid, dan menciptakan visi yang jelas untuk masa depan (Yoder-Wise & Sportsman, 2022). Kepemimpinan yang efektif dalam keperawatan juga melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik. Pemimpin perawat yang baik adalah mereka yang dapat memahami dan menjembatani peran anggota tim perawat sebagai penyedia layanan dengan kebutuhan pasien sebagai pengguna jasa, serta menjadi penghubung antara manajemen dan staf, memastikan bahwa semua suara dapat didengar dan dihargai.

Teori kepemimpinan telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya, fokus utama adalah pada karakteristik individu pemimpin, dengan banyak penelitian menunjukkan bahwa sifat tertentu, seperti kecerdasan dan kepribadian, mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Seiring waktu, pendekatan ini mulai berubah. Teori kontingensi muncul pada tahun 1960-an dan menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi (Deckard, 2009).

Efektivitas kepemimpinan tergantung pada konteks dan karakteristik anggota tim. Pendekatan ini sangat relevan dalam keperawatan, di mana situasi sering berubah cepat dan memerlukan fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan. Pada tahun 1970-an, teori transformasional mulai mendapatkan perhatian (Hutchinson & Jackson, 2013). Teori ini berfokus pada pemimpin yang mampu menginspirasi dan memberdayakan pengikut untuk mencapai tujuan lebih tinggi. Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga berusaha membangun hubungan kuat dengan anggota tim, menciptakan rasa saling percaya dan komitmen. Di era modern, teori kepemimpinan semakin dinamis dengan banyaknya teori kepemimpinan baru muncul, seperti kepemimpinan distribusi dan situasional, yang semakin menekankan kolaborasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa model kepemimpinan inklusif dan kolaboratif lebih efektif dalam meningkatkan kualitas perawatan di rumah sakit.

### **C. Evolusi Teori Kepemimpinan: Dari Teori Trait hingga Teori Kontekstual**

---

Pemahaman tentang apa yang membuat seorang pemimpin keperawatan efektif tidak pernah statis. Pemahaman ini bagaikan sungai yang mengalir, berubah bentuk dan arusnya mengikuti aliran zaman dengan kompleksitas tantangan kesehatan yang semakin rumit. Di masa awal perkembangan profesi, sekitar awal abad ke-20, paradigma yang mendominasi adalah Teori Trait (Taylor, 2009). Teori ini meyakini bahwa pemimpin itu terlahir secara alami, dan bukan dibuat atau dipelajari. Fokusnya tertuju pada atribut-atribut personal seperti karisma yang memikat, tingkat intelegensia yang tinggi, atau dominasi fisik tertentu. Teori ini memang memberikan fondasi awal tentang pentingnya kualitas individu, namun seiring waktu, para peneliti dan praktisi keperawatan di Indonesia mulai menyadari adanya keganjilan pada teori ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia rumah sakit besar yang super sibuk atau puskesmas di pelosok dengan keterbatasan akses dan keberagaman budaya, ternyata hanya mengandalkan bakat bawaan saja tidak pernah cukup.

Menyadari keterbatasan tersebut, dunia kepemimpinan keperawatan mengalami pergeseran besar pada dekade 1950-an dan 1960-an dengan munculnya Teori Behavioral (Bole, 1987). Aliran ini menggeser fokus dari "siapa pemimpin itu" menjadi "apa yang dilakukan pemimpin itu." Dua orientasi utama mulai dikenali: task-oriented (fokus pada penyelesaian tugas dan prosedur) dan relationship-oriented (fokus pada hubungan interpersonal dan kesejahteraan tim) (Kamali & Atashinsadaf, 2025). Para pemimpin keperawatan di era pasca-pandemi, misalnya, tidak cukup hanya pandai mengatur jadwal dinas (task). Mereka juga harus memiliki

empati budaya yang tinggi untuk mendengarkan keluhan perawat yang kelelahan secara mental. Sebuah riset mendalam yang dilakukan di sejumlah rumah sakit Indonesia pada tahun 2022 membuktikan hal ini secara empiris; penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan perilaku kepemimpinan yang suportif dan penuh empati mampu meningkatkan retensi atau angka bertahanannya perawat di tempat kerja hingga mencapai 25% (Sari & Pratiwi, 2022). Ini adalah bukti nyata bahwa cara seorang pemimpin bersikap menentukan bertahan atau tidaknya sumber daya perawat di garda terdepan.

Selanjutnya, arus evolusi berlanjut ke babak yang lebih kompleks di era 1970-an, yaitu lahirnya Teori Kontingensi (Deckard, 2009). Tokoh seperti Fiedler memperkenalkan ide revolusioner: tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk segala situasi. Efektivitas seorang pemimpin sangat tergantung pada kecocokan antara gayanya dengan situasi yang dihadapi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa teori ini cocok dengan konteks transformasi sistem kesehatan nasional di Indonesia, khususnya dengan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinamis. Seorang Kepala Ruang di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang selalu berhadapan dengan situasi krisis dan tekanan waktu, akan terbukti paling efektif jika menerapkan gaya *task-oriented* yang tegas, terstruktur, dan cepat. Di lain pihak, layanan kesehatan primer seperti Puskesmas, di mana fokusnya adalah pada promosi kesehatan, pendampingan lansia, serta membangun kepercayaan jangka panjang dengan masyarakat, pemimpin dengan gaya kepemimpinan *relation-oriented* cenderung lebih berhasil menciptakan kolaborasi. Oleh karenanya, fleksibilitas untuk menyesuaikan gaya adalah kunci sukses di lingkungan kesehatan yang beragam.

Puncak dari perjalanan evolusi ini adalah lahirnya teori-teori mutakhir, seperti Kepemimpinan Adaptif (Adaptive Leadership) (Corazzini et al., 2015) dan Kepemimpinan Transformasional (Hutchinson & Jackson, 2013). Teori ini sangat kental dengan semangat abad ke-21 yang penuh ketidakpastian (*VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Kepemimpinan adaptif mendorong perawat untuk tidak hanya menjadi manajer ruangan yang baik, tetapi menjadi agen perubahan yang mampu membaca situasi, belajar dari pengalaman, dan memobilisasi tim untuk menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya.

#### **D. Teori Kepemimpinan Transformasional: Fondasi Perubahan di Keperawatan**

---

Kepemimpinan transformasional (Hutchinson & Jackson, 2013) secara luas dianggap sebagai landasan manajemen keperawatan modern karena kepemimpinan ini bergerak dari pengawasan tradisional yang berorientasi pada tugas menuju kepemimpinan yang fokus pada inspirasi profesional dan perubahan yang menyeluruh. Dalam lingkungan perawatan kesehatan yang penuh tekanan, teori ini berfungsi dengan menyelaraskan nilai-nilai pribadi staf keperawatan dengan visi kolektif untuk keunggulan dalam perawatan pasien. Dengan memanfaatkan empat pilar yaitu pengaruh yang ideal, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual pemimpin perawat beralih dari sekadar manajer dan berubah menjadi mentor yang menumbuhkan kepercayaan dan integritas moral. Pendekatan ini mendorong perawat untuk melihat melampaui tuntutan langsung dari jam kerja mereka dan memandang diri mereka sebagai kontributor penting bagi misi yang lebih besar, yang sangat penting untuk mempertahankan idealisme di dunia keperawatan yang sering ditandai dengan tingkat kelelahan tinggi.

Penerapan praktis kepemimpinan transformasional berperan sebagai penggerak utama perubahan organisasi, terutama ketika menerapkan protokol klinis yang baru atau menghadapi perubahan teknologi. Karena para pemimpin ini mengutamakan stimulasi intelektual, mereka menciptakan budaya yang adil di mana staf didorong untuk menantang praktik yang sudah usang dan mengupayakan perbaikan berbasis bukti tanpa perlu merasa takut. Pemberdayaan ini menghasilkan tenaga kerja yang lebih tangguh dan gesit, di mana perawat di ranjang pasien merasa memiliki wewenang untuk mengambil alih inisiatif keselamatan pasien. Akibatnya, fondasi perubahan dibangun berdasarkan pendekatan dari bawah ke atas di mana inovasi tidak dipaksakan oleh administrasi tetapi justru dikembangkan secara alami melalui pertumbuhan profesional dan keterlibatan yang meningkat dari tim perawat.

Dampak positif gaya kepemimpinan ini dapat diukur melalui peningkatan besar pada hasil perawatan pasien dan kesejahteraan organisasi. Para pemimpin yang memperhatikan pertimbangan unik memastikan bahwa para profesional dan kebutuhan pertumbuhan spesifik setiap perawat terpenuhi. Hal ini berkorelasi langsung dengan kepuasan kerja yang lebih baik dan penurunan perpindahan karyawan. Stabilitas budaya tersebut memiliki efek lanjutan. Ketika perawat merasa didukung dan terlibat, kualitas perawatan meningkat. Ini menghasilkan lebih sedikit kesalahan klinis dan skor kepuasan pasien yang lebih baik. Kepemimpinan transformasional lebih dari sekadar teknik manajemen. Ia merupakan kondisi



penting bagi setiap organisasi layanan kesehatan yang ingin memberikan perawatan berkualitas tinggi dan berkelanjutan dalam lingkungan medis yang kompleks.

Esensi dasar kepemimpinan transformasional adalah tentang bagaimana membimbing perawat agar memusatkan motivasinya dari imbalan eksternal menuju pemenuhan internal. Kepemimpinan transformasional berbeda dari manajemen tradisional, yang menggunakan metode upah dan hukuman saat berhadapan dengan penyedia layanan perawatan langsung dengan memanfaatkan panggilan perawat atau identitas profesional yang sesungguhnya. Mengembangkan sebuah visi, di mana pekerjaan klinis harian keperawatan dihubungkan dengan tujuan moral yang lebih besar komitmen untuk memajukan kesetaraan kesehatan atau menghapuskan bahaya bagi pasien membuat para pemimpin mengubah pekerjaan keperawatan menjadi kontribusi yang bermakna. Pergeseran cara berpikir ini akan menjadi cara terbaik melawan kelelahan kerja karena dapat memberi perawat kekuatan internal dan alasan yang tidak dapat dipengaruhi oleh apa pun yang terjadi selama masa kerja.

Inovasi kepemimpinan ini adalah mesin keberlanjutan kepemimpinan pada dunia medis modern. Ketika perubahan dipaksakan oleh eksekutif rumah sakit, sering kali menghadapi kelelahan perubahan dan resistensi dari staf garis depan. Namun, ketika seorang pemimpin transformasional menumbuhkan budaya pemberdayaan, staf itu sendiri menjadi arsitek perubahan. Karena perawatlah yang menavigasi kompleksitas teknologi atau protokol baru, masukan mereka memastikan bahwa sistem baru tidak hanya secara teoretis tepat tetapi juga layak secara praktis. Hal ini menciptakan tenaga kerja yang tangkas yang dapat beradaptasi dengan cepat sebagai respons terhadap penelitian medis baru atau krisis kesehatan masyarakat tanpa kehilangan momentum operasional.

#### **E. Teori Kepemimpinan Transaksional: Keseimbangan dengan Pendekatan *Reward-Punishment***

---

Teori Kepemimpinan Transaksional (Park, 1997) menyimpang dari visi yang menjadi ciri kepemimpinan transformasional dengan berfokus pada transaksi dasar antara pemimpin dan pengikut. Dalam konteks keperawatan, model ini berfungsi dengan memperkuat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap protokol melalui serangkaian penghargaan dan tindakan korektif. Kontrak sosial ini memungkinkan pelaksanaan harian sebuah fasilitas layanan kesehatan menetapkan rasio staf terhadap pasien, memberikan obat, memelihara pencatatan dapat dilakukan secara akurat dan seragam. Pemimpin transaksional menetapkan ekspektasi yang jelas dan

memberlakukan konsekuensi untuk menciptakan organisasi yang stabil yang diperlukan agar lingkungan yang aman secara klinis dapat berkembang.

Pemimpin transaksional berfungsi sebagai mesin praktis di balik unit keperawatan, dengan fokus yang tegas pada persoalan operasional klinis “saat ini dan di sini”. Model transaksional menekankan laporan pergantian jaga, catatan pemberian obat, serta daftar staf yang harus segera dihubungi berbeda dengan teori-teori lain yang mungkin lebih menyoroti perubahan organisasi jangka panjang. Model ini didasarkan pada konsep resiprokal yang jelas, di mana hubungan antara staf dan manajer perawat dibentuk melalui transaksi tertentu yang bersifat fungsional. Dalam paradigma ini, perawat menyediakan tenaga kerja berkualitas tinggi dan kepatuhan terhadap kebijakan rumah sakit, sementara sebagai balasannya para pemimpin memberikan kompensasi finansial, jaminan keamanan kerja, serta insentif profesional. Tingkat kejelasan ini sangat penting dalam lingkungan berisiko tinggi dan dengan alur kerja berkecepatan tinggi, di mana ketidakpastian dapat menimbulkan kesalahan medis yang mematikan.

Teori ini memiliki komponen yang merupakan bagian penghargaan (secara formal disebut penghargaan bersyarat), yang merupakan gaya manajemen penting yang digunakan untuk memfasilitasi kinerja yang baik di tempat kerja. Pada titik ini, pemimpin dan staf keperawatan menyepakati tujuan konkrit dengan tolok ukur yang dapat diukur. Ketika tujuan-tujuan ini telah berhasil dicapai, pemimpin memberikan penghargaan yang sebelumnya telah disepakati, yang dapat mencakup insentif pembayaran yang nyata seperti bonus kinerja dan penjadwalan yang diutamakan serta pengakuan yang tidak nyata seperti pujian dalam evaluasi kinerja. Hal ini memotivasi perawat di seluruh departemen melalui keadilan, dengan memastikan bahwa setiap orang tahu persis apa yang diperlukan untuk berhasil di hadapan rekan-rekannya sebuah prinsip merit yang sering diabaikan.

Di sisi lain, komponen yang bersifat korektif termasuk dalam Manajemen dengan Pengecualian (*Management by Exception/MBE*) (Willis et al., 2017), yang menjamin tindakan cepat saat penyimpangan klinis terdeteksi. Mekanisme ini bisa aktif atau pasif. MBE Aktif menunjukkan para pemimpin yang memantau unit secara ketat untuk melihat kapan mereka melakukan kesalahan, sedangkan MBE Pasif hanya bekerja setelah standar tidak terpenuhi. Meski istilah hukuman terdengar tidak menyenangkan dalam bisnis, praktiknya lebih sering berupa rencana tindakan korektif, pelatihan remedial, dan peringatan tertulis. Intervensi ini tidak semata-mata untuk menghukum, melainkan berfungsi sebagai jaring pengaman agar profesi tidak gagal karena kecerobohan atau kurang pengawasan.

Teori transaksional dalam keperawatan memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang terorganisasi, aman, dan jelas. Para pemimpin seharusnya memuji

dan memberikan dorongan untuk hal-hal yang baik sekaligus membetulkan kesalahan agar setiap orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien. Pendekatan ini meyakinkan bahwa tugas-tugas perawatan dasar dilakukan dengan benar dalam industri yang diatur oleh undang-undang ketat dan protokol klinis. Selain itu, perawat didukung oleh kejelasan peran karena kinerja diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan jelas, yang berkontribusi pada penurunan stres yang timbul dari ketidakpastian terkait tugas.

Sementara kepemimpinan transaksional sangat penting untuk menjaga integritas struktural sebuah organisasi kesehatan, hal itu paling efektif ketika dipandang sebagai fondasi daripada batasan tertinggi. Keterbatasan utamanya adalah ketergantungan yang besar pada motivasi ekstrinsik melakukan tugas demi memperoleh hadiah yang mungkin tidak selalu menjawab hasrat intrinsik atau aspirasi profesional jangka panjang staf perawat. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang teori ini mengakui bahwa meskipun keseimbangan antara penghargaan dan hukuman menyediakan aturan dan protokol keselamatan yang diperlukan untuk operasi harian, potensinya baru tercapai sepenuhnya bila digunakan bersamaan dengan gaya kepemimpinan yang lebih berbasis hubungan untuk mendorong budaya keperawatan yang benar-benar holistik dan inspiratif.

#### **F. Kepemimpinan Pelayan dan Kepemimpinan Otentik: Humanisasi dalam Konteks Budaya Indonesia**

---

Kepemimpinan Pelayan (*servant leadership*) (Jackson, 2008) dan Kepemimpinan Otentik (Almutairi et al., 2025) adalah sistem manajemen spesialis yang relatif baru yang digunakan untuk menciptakan lingkungan klinis yang lebih manusiawi. Keduanya pendekatan ini menerapkan praktik profesional dengan nilai-nilai yang merupakan bagian dari budaya layanan kesehatan Indonesia. Teori-teori ini selaras dengan nilai gotong royong (kerja sama timbal balik) dan kekeluargaan (semangat kekerabatan atau rasa kekeluargaan) yang diekspresikan oleh masyarakat Indonesia. Ini berbeda dari banyak model manajemen rumah sakit di Barat, yang lebih menekankan aspek rasional atau objektif, atau hasil klinis. Model kepemimpinan ini tidak memandang perawat semata-mata melalui lensa fungsional. Model ini menganjurkan membangun ruang di mana empati, semangat, dan kebaikan bersama menjadi bahan bakar yang mendorong pemberian layanan. Dengan cara ini, manajemen dapat membangun lingkungan kerja yang berkelanjutan.

Kepemimpinan pelayanan membalikkan hierarki kekuasaan tradisional dengan mendorong para pemimpin melayani staf mereka. Konsep ini sesuai dengan nilai-

nilai di Indonesia. Pemimpin perawat bertanggung jawab menyediakan sumber daya emosional, fisik, dan teknis yang dibutuhkan tim agar dapat memberikan perawatan pasien berkualitas. Pemimpin yang mengutamakan pertumbuhan dan kesejahteraan perawat tahu bahwa ketika staf merasa didukung dan diperhatikan, mereka lebih mampu menunjukkan kasih sayang kepada pasien. Hal ini membuat pelayanan lebih manusiawi.

Melengkapi hal ini adalah Kepemimpinan Otentik (Almutairi et al., 2025), yang dibangun atas transparansi dan kompas moral internal yang kuat, mencerminkan kebajikan lokal seperti keikhlasan dan kejujuran. Pemimpin perawat yang otentik tidak bersembunyi di balik jabatan atau pangkat administratif mereka; sebaliknya, mereka memimpin melalui kesadaran diri dan transparansi dalam hubungan. Dengan mengakui kesalahan dan membagikan alasan di balik keputusan yang sulit, mereka menghancurkan hambatan formal yang kaku yang sering ditemukan dalam hierarki tradisional Indonesia. Keterbukaan ini mendorong budaya berbicara di mana perawat merasa aman melaporkan masalah klinis, yang sangat penting untuk menjaga standar keselamatan pasien yang tinggi.

Aspek negatif dari penerapan teori-teori ini di Indonesia adalah adanya evolusi ABS ("Asal Bapak Senang") kecenderungan budaya untuk memandang pemimpin sebagai figur paternal atau maternal. Namun gaya kepemimpinan pelayan dan autentik memodernisasi sifat budaya ini dengan mempertahankan kehangatan dan perlindungan pemimpin sebagai orang tua (Ibu atau Bapak dari lingkungan kerja) sambil menghilangkan tuntutan historis untuk ketaatan buta dan otoriter. Hal ini menciptakan dinamika keluarga profesional di mana rasa hormat diperoleh melalui pelayanan yang konsisten dan perilaku etis, bukan semata-mata diberikan berdasarkan posisi seseorang dalam bagan organisasi.

Humanisasi perawatan melalui model ini berarti mengakui bahwa kinerja profesional perawat terkait erat dengan kehidupan keluarga dan identitas spiritual mereka. Dalam masyarakat Indonesia, hal ini merupakan pilar utama keberadaan. Pemimpin yang menghormati batasan ini lebih mungkin mendapatkan loyalitas staf jangka panjang dan mengurangi kelelahan kerja. Dengan mendorong pendekatan holistik dalam manajemen staf, pemimpin yang melayani dan autentik memastikan lingkungan klinis terasa akrab secara budaya dan aman. Hal ini akhirnya berimbas pada pengalaman pasien di tempat tidur mereka.

Integrasi teori kepemimpinan ini ke dalam sistem keperawatan Indonesia menciptakan lingkungan kerja penuh kepercayaan. Ini sangat penting untuk menavigasi lanskap pelayanan kesehatan yang kompleks dan multikultural. Ketika pemimpin memimpin dengan ketulusan dan hati untuk melayani, mereka menciptakan budaya yang menghargai elemen manusia daripada pelaksanaan

tugas secara mekanis. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan retensi kerja perawat, tetapi juga menghasilkan pengalaman perawatan yang lebih penuh belas kasih dan peka terhadap budaya. Ini sangat sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan.

### **G. Kepemimpinan Situasional dan Kepemimpinan Adaptif: Respons Dinamis terhadap Transformasi**

---

Teori Kepemimpinan Situasional (Wang et al., 2024) dan Kepemimpinan Adaptif (Corazzini et al., 2015) sangat penting dalam keperawatan karena mengakui bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang efektif dalam setiap skenario klinis. Di lingkungan rumah sakit yang volatile, seorang pemimpin harus mampu mendiagnosis kebutuhan spesifik dari suatu situasi dan menyesuaikan perilakunya sesuai kebutuhan. Kepemimpinan situasional berfokus pada kesiapan staf menyeimbangkan pengarahan tinggi untuk perawat baru yang belum berpengalaman dengan delegasi tinggi untuk veteran yang sudah berpengalaman. Ini memastikan bahwa tingkat pengawasan sesuai dengan kompetensi dan kepercayaan diri tim, mencegah baik micromanagement terhadap para ahli maupun pengabaian terhadap pemula.

Kepemimpinan adaptif (Corazzini et al., 2015) membawa pendekatan dinamis ini selangkah lebih maju dengan berfokus pada bagaimana organisasi menavigasi tantangan adaptif yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan keahlian teknis. Sementara masalah teknis mungkin berupa ventilator yang rusak yang memerlukan seorang tukang perbaikan, tantangan adaptif adalah perubahan mendadak dalam kebijakan kesehatan atau pandemi global yang memerlukan perubahan dalam seluruh budaya dan pola pikir unit. Pemimpin adaptif tidak memberikan semua jawaban; sebaliknya, mereka mengatur tekanan tim mereka, membantu perawat untuk menghadapi ketidaknyamanan perubahan sambil menjaga stabilitas yang cukup untuk terus memberikan perawatan pasien yang aman.

Komponen inti teori-teori ini adalah kemampuan pemimpin untuk naik ke balkon, sebuah metafora menjauh dari kekacauan di lantai klinik untuk mendapatkan perspektif lebih luas. Dengan mengamati pola kerja dan keadaan emosional staf dari jarak jauh, pemimpin dapat mengidentifikasi apakah konflik hanya salah paham sederhana atau masalah sistemik yang lebih dalam. Pandangan dari atas ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih strategis. Ini memastikan pemimpin tidak hanya bereaksi terhadap masalah tetapi juga membimbing tim secara proaktif melalui kompleksitas mendasar transformasi.

Pemimpin adaptif berada pada posisi yang baik untuk merespons kemajuan teknologi dan praktik berbasis bukti dalam profesi keperawatan kontemporer. Para pemimpin perlu secara aktif terlibat dalam pelatihan untuk sistem dokumentasi digital yang baru, serta bekerja bersama staf saat mereka beradaptasi dari waktu ke waktu. Cara ini sangat berguna untuk mengatasi berbagai kendala teknis yang disebabkan oleh kepemimpinan yang kuat. Dengan demikian, unit-unit keperawatan akan berkembang secara bersamaan seiring dengan pengetahuan medis dan manajemen rumah sakit.

Gaya kepemimpinan ini juga mendorong keselamatan psikologis, yang merupakan prasyarat untuk setiap perubahan organisasi yang berhasil. Dengan mengakui bahwa jalur ke depan tidak pasti dan bahwa tim harus belajar menemukan solusi bersama-sama, pemimpin adaptif mengurangi rasa takut akan kegagalan. Mereka mendorong solusi berbasis kerja di mana perawat di tempat tidur diajak untuk bereksperimen dengan perbaikan alur kerja. Semangat kolaboratif ini mengubah unit keperawatan menjadi organisasi pembelajar, di mana adaptasi dilihat bukan sebagai kejadian sekali saja tetapi sebagai respons yang terus-menerus dan sehat terhadap tuntutan sektor kesehatan yang terus berubah.

Keterampilan kepemimpinan situasional dan adaptif membantu manajer perawat tetap berpijak pada kenyataan dalam lingkungan yang penuh gejolak. Para pemimpin memiliki beragam gaya melalui pengarahan, pelatihan, dukungan, dan pendelegasian sesuai dengan kebutuhan yang tepat pada waktu yang tepat. Staf keperawatan seperti ini adaptif dan tangguh selama proses transformasi. Meskipun ada beberapa gangguan, gangguan tersebut bersifat kecil jika dibandingkan dengan upaya mengatasi perubahan sistemik dengan fokus yang lebih luas pada metode penyampaian yang paling efektif untuk perawatan pasien yang berkualitas, aman, dan penuh perhatian.

Kepemimpinan situasional dan adaptif tidak boleh dipahami sebagai dua teori yang terpisah, melainkan sebagai suatu kontinum kemampuan yang saling memperkuat. Dalam lanskap layanan kesehatan yang bergerak cepat, pemimpin keperawatan kontemporer perlu menguasai apa yang oleh studi terbaru disebut sebagai *managerial agility* kemampuan yang mencakup kemahiran manajemen krisis, pandangan jauh ke depan yang proaktif, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, fleksibilitas sumber daya, serta pemecahan masalah yang inovatif. Konsep ini menjembatani kedua teori: jika kepemimpinan situasional menyediakan mekanisme diagnostik untuk menilai kesiapan individu atau tim, maka kelincahan manajerial (*managerial agility*) memberdayakan pemimpin untuk mengeksekusi transisi gaya secara mulus, mulai dari pengarahan (*directing*) hingga pendelegasian, tanpa menimbulkan friksi dalam alur kerja klinis.

Dimensi yang kurang dieksplorasi dalam pembahasan sebelumnya adalah bagaimana para pemimpin mempersiapkan tim mereka menghadapi tantangan yang *unknown unknowns* situasi yang tidak dapat diprediksi bahkan oleh model situasional yang paling canggih sekalipun. Di sinilah integrasi dengan *complex adaptive leadership* (CAL) menjadi esensial. Kerangka CAL memperlakukan unit keperawatan sebagai *complex adaptive system*, mengakui bahwa perubahan tidak bersifat linear dan sering kali muncul dari interaksi spontan di antara staf. Alih-alih mencoba mengontrol setiap variabel, pemimpin adaptif merangkul ketidakpastian dan menciptakan apa yang disebut sebagai *enabling constraints* batasan yang justru membebaskan kreativitas dalam batas-batas keselamatan klinis (Hancock et al., 2025). Pendekatan ini terbukti memberdayakan perawat di lini depan untuk mengambil keputusan otonom, meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap hasil pasien, dan pada akhirnya memperbaiki capaian klinis

Walau demikian, efektivitas kepemimpinan adaptif sangat bergantung pada fondasi keselamatan psikologis yang kokoh. Studi longitudinal mutakhir menunjukkan bahwa ketika pemimpin keperawatan secara konsisten menerapkan strategi untuk meningkatkan keselamatan psikologis, terjadi penurunan signifikan dalam perilaku menarik diri (*withdrawal behavior*) dan peningkatan keterbukaan melaporkan nyaris cedera (*near misses*). Ini menandakan bahwa metafora "naik ke balkon" tidak cukup hanya untuk observasi; pemimpin juga harus turun kembali ke "lantai dansa" dengan pemahaman empatik yang lebih dalam. Pemimpin adaptif yang efektif menggunakan perspektif strategis dari balkon untuk mendiagnosis sumber kecemasan tim apakah berasal dari beban administratif, konflik interpersonal, atau ketidakjelasan peran lalu merancang intervensi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyentuh dimensi emosional.

Pada akhirnya, sintesis kepemimpinan situasional dan adaptif membentuk arsitektur kepemimpinan yang tangguh sekaligus lentur (*resilient and agile*). Model terintegrasi ini membekali manajer keperawatan untuk tidak sekadar merespons perubahan, tetapi secara proaktif membentuk masa depan praktik klinis. Dengan mendasarkan transisi gaya kepemimpinan pada diagnosis situasional yang presisi, menumbuhkan keselamatan psikologis, dan mengadopsi pola pikir sistem yang adaptif, para pemimpin ini memastikan bahwa unit keperawatan tidak hanya bertahan (*survive*) di tengah turbulensi sektor kesehatan, melainkan bertransformasi menjadi organisasi pembelajar yang terus berkembang (Watson, 2024).

## **H. Integrasi Teori Kepemimpinan dengan Transformasi Sistem Kesehatan Nasional**

---

Gambaran tentang bagaimana berbagai teori dan pendekatan dapat digabungkan penting untuk pengembangan sistem kesehatan nasional. Dengan adanya pergeseran menuju perawatan yang lebih terintegrasi, didukung oleh teknologi baru dan yang terpenting, diberikan sedekat mungkin kepada pasien, jelas bahwa tidak satu pun gaya kepemimpinan dapat secara memadai mengatasi kompleksitas perubahan ini. Model terintegrasi yang memadukan gaya kepemimpinan transformasional, transaksional, dan servant leadership dengan pendekatan holistik menyeimbangkan kebutuhan perubahan sistemik terhadap kestabilan operasional, sekaligus tetap peka terhadap kebutuhan integrasi budaya. Sintesis ini akan memastikan bahwa visi reformasi kesehatan nasional dapat diwujudkan pada tingkat pemberian layanan dengan cara yang lebih berkelanjutan, namun tetap menawarkan peluang bagi praktik keperawatan yang berpusat pada manusia dalam gambaran birokrasi yang besar.

Aspek transformasional dari integrasi ini memberikan visi yang diperlukan untuk menyelaraskan staf keperawatan dengan tujuan kesehatan nasional, seperti jaminan kesehatan universal dan transformasi kesehatan digital. Para pemimpin harus menginspirasi tim mereka untuk melihat melampaui tantangan lokal dari unit mereka masing-masing dan memahami peran mereka dalam misi nasional yang lebih luas. Dengan menumbuhkan rasa tujuan bersama, pemimpin perawat dapat mengubah kecemasan yang sering terkait dengan perubahan struktural berskala besar menjadi dorongan kolektif untuk keunggulan profesional. Panduan visioner ini adalah apa yang mencegah transformasi nasional menjadi sekadar mandat dari atas ke bawah, dan sebaliknya mengubahnya menjadi gerakan akar rumput untuk perbaikan klinis.

Meskipun unsur-unsur transaksional terus mendasari integrasi ini, pengelolaan tanpa struktur yang jelas dapat dengan mudah kehilangan arah dan tujuannya. Sebagai landasan, layanan kesehatan nasional bertumpu pada pengumpulan data dan plot kelangsungan hidup melalui pelaporan standar atas informasi dari praktik klinis yang saling terhubung; kebutuhan akan keselamatan yang sempurna selanjutnya dijamin dengan kepatuhan pada protokol yang dijelaskan (uji klinis). Kepemimpinan transaksional menawarkan kontrak sosial yang eksplisit dan mekanisme akuntabilitas untuk mencapai sasaran kinerja. Para pemimpin menjaga sistem kesehatan yang dibatasi aturan tetap terfokus selama setiap periode reformasi, dengan sistem penghargaan yang jelas yang telah diterapkan untuk memenuhi tolok ukur kualitas nasional dan tindakan cepat untuk mengekang



institusi yang membangkang ketika institusi tersebut melanggar standar keselamatan.

Selain itu, kombinasi kepemimpinan pelayan dan kepemimpinan autentik memberi wajah manusiawi bagi perubahan nasional dengan memastikan bahwa kebutuhan perawat dan pasien tidak hilang di tengah lautan data dan kebijakan. Ketika sistem nasional semakin tersentralisasi dan terkomputerisasi, praktik klinis kehilangan sisi kemanusiaannya. Risiko ini juga dapat dikurangi oleh pemimpin pelayan dalam organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan staf mereka, khususnya dalam mengatasi masalah seperti perawat yang kewalahan dengan tugas administratif akibat perubahan sistem. Dan dengan memimpin secara autentik dan tulus, mereka berhasil mempertahankan itikad baik para perawat, yaitu komoditas paling berharga bagi setiap negara yang mengejar strategi kesehatan.

Teori kepemimpinan adaptif dan situasional berfungsi sebagai penghubung dalam integrasi ini, memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk merespons tantangan cepat dari sistem yang sedang berubah. Karena reformasi kesehatan nasional sering diterapkan secara bertahap dan menghadapi hambatan lokal, pemimpin perawat harus mampu mengubah pendekatan mereka berdasarkan kesiapan spesifik unit mereka dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Kelincahan ini memungkinkan respons yang dinamis, di mana pemimpin dapat beralih dari sikap direktif selama peluncuran sistem teknis menjadi peran pelatih ketika staf mulai menguasai alur kerja baru. Hal ini memastikan bahwa transformasi bukanlah sebuah peristiwa statis tetapi proses evolusi yang terus-menerus dan dapat dikelola.

Integrasi yang berhasil dari teori-teori kepemimpinan ini menciptakan kerangka kepemimpinan keperawatan yang tangguh dan mampu memelihara sistem kesehatan nasional jangka panjang. Dengan menyeimbangkan visi dengan pragmatisme dan aspek struktural dengan aspek manusia, pemimpin perawat menjadi agen perubahan utama yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan tingkat tinggi dan perawatan di ranjang pasien. Pendekatan multi-teoritis ini memastikan bahwa transformasi Sistem Kesehatan Nasional menghasilkan lingkungan layanan kesehatan yang lebih efisien, adil, dan penuh empati, di mana profesi keperawatan tetap menjadi dasar keunggulan klinis dan kesejahteraan masyarakat.

Kompleksitas reformasi sistem kesehatan nasional yang ditandai oleh pergeseran menuju perawatan terintegrasi, percepatan digitalisasi, dan tuntutan pelayanan yang berpusat pada pasien telah melampaui kapasitas satu pun gaya kepemimpinan tunggal. Tidak ada satu pendekatan yang secara memadai dapat mengatasi ketegangan antara perubahan transformatif dan kestabilan operasional sekaligus menjaga kepekaan terhadap kebutuhan integrasi budaya. Model integratif

yang memadukan kepemimpinan transformasional, transaksional, pelayan (*servant leadership*), dan kepemimpinan autentik dengan pendekatan adaptif dan situasional menawarkan kerangka yang lebih tangguh dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi reformasi kesehatan nasional hingga ke tingkat pemberian layanan (Hersey et al., 2012; Wheatley et al., 2017).

Secara spesifik, dimensi transformasional dalam sintesis ini membekali pemimpin keperawatan dengan kapasitas visioner yang diperlukan untuk menyelaraskan staf dengan tujuan nasional seperti Jaminan Kesehatan Universal (*Universal Health Coverage*) dan transformasi kesehatan digital. Berbagai bukti menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional secara konsisten mendorong budaya keselamatan yang lebih kuat, kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan angka pergantian perawat yang lebih rendah, yang semuanya dimediasi oleh pemberdayaan dan budaya keselamatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun menekankan bahwa kepemimpinan perawat dan bidan sangat krusial untuk mendukung transformasi digital dan pencapaian cakupan kesehatan universal. Para pemimpin transformasional menginspirasi tim mereka untuk melihat melampaui tantangan lokal unit masing-masing dan memahami peran mereka dalam misi nasional yang lebih luas, sehingga mengubah kecemasan akan perubahan struktural menjadi dorongan kolektif demi keunggulan profesional.

Sementara itu, elemen transaksional menyediakan fondasi struktural yang tak terpisahkan. Tanpa kejelasan peran, kontrak sosial yang eksplisit, dan mekanisme akuntabilitas, pengelolaan sistem berskala nasional akan kehilangan arah. Kepemimpinan transaksional menawarkan kerangka yang terukur melalui sistem penghargaan terdefinisi untuk pemenuhan tolok ukur kualitas, serta tindakan korektif cepat bagi penyimpangan standar keselamatan yang menjaga sistem kesehatan berbasis aturan tetap fokus selama periode reformasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks; tinjauan sistematis menunjukkan bahwa *contingent reward*, komponen transaksional inti, hanya memberikan manfaat terbatas pada situasi spesifik, dan gaya *laissez-faire* justru bersifat merugikan. Namun demikian, tanpa elemen ini, transformasi berisiko menjadi kekacauan yang tak terkelola.

Pada saat yang sama, dimensi kepemimpinan pelayan dan autentik memberikan wajah manusiawi bagi perubahan nasional, memastikan bahwa kebutuhan perawat dan pasien tidak terserap dalam lautan data dan kebijakan. Riset kontemporer menunjukkan bahwa *servant leadership* dapat memoderasi dampak buruk supervisi yang merugikan serta mengurangi beban psikologis yang diakibatkan oleh kelelahan emosional, yang pada gilirannya melindungi kesejahteraan dan kinerja perawat. Temuan ini selaras dengan argumen bahwa pemimpin pelayan dalam

organisasi kesehatan berperan penting memperjuangkan kesejahteraan staf, terutama ketika perawat semakin terbebani tugas administratif akibat perubahan sistem. Kepemimpinan autentik sendiri berkontribusi memperkuat kepercayaan (*trust*), yang merupakan prediktor signifikan bagi komitmen organisasional dan retensi perawat.

## **I. Penutup**

---

Evolusi teori kepemimpinan dalam profesi keperawatan menunjukkan pergeseran dari manajemen yang kaku dan transaksional menuju pendekatan holistik dan multidimensional yang memprioritaskan baik keunggulan klinis maupun hubungan manusia. Seperti yang dibahas sepanjang bab ini, pemimpin perawat modern harus menjadi poliglot teoretis, mampu beralih dengan lancar antara berbagai gaya kepemimpinan tergantung pada lingkungan klinis, tingkat kematangan staf mereka, dan kebutuhan spesifik pasien. Dengan menguasai inspirasi visioner dari kepemimpinan transformasional bersamaan dengan disiplin struktural dari model transaksional, para pemimpin menciptakan lingkungan di mana standar tinggi tidak hanya terpenuhi, tetapi diterima sebagai misi profesional yang dibagikan.

Dalam konteks spesifik lanskap kesehatan Indonesia, integrasi kepemimpinan pelayan dan otentik berfungsi sebagai jembatan penting antara manajemen modern dan warisan budaya. Humanisasi kepemimpinan yang berakar pada ketulusan, kerendahan hati, dan semangat Kekeluargaan memastikan bahwa tenaga perawat tetap tangguh dan terlibat. Penyesuaian budaya ini bukan sekadar keterampilan; ini merupakan kebutuhan strategis yang mencegah kelelahan dan mendorong kepercayaan mendalam yang diperlukan untuk mengelola kompleksitas sistem medis yang beragam dan cepat berubah.

Selain itu, kapasitas kepemimpinan situasional dan adaptif juga membantu unit keperawatan untuk bertahan dan beradaptasi secara efektif selama masa perubahan organisasi yang intensif. Pemimpin yang matang dapat mendiagnosis situasi, memperoleh perspektif yang lebih luas daripada titik buta tim manajemen puncak. Pemimpin yang fleksibel memastikan tim keperawatan siap menghadapi perubahan pada saat integrasi teknologi dan kebijakan kesehatan baru berubah dengan cepat. Mereka melihat perubahan bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai katalis untuk pengembangan profesional berkelanjutan dan peningkatan advokasi bagi pasien.

Transformasi Sistem Kesehatan Nasional memberikan tantangan sekaligus peluang unik bagi pemimpin perawat untuk menegaskan peran mereka sebagai

agen perubahan utama. Dengan menyelaraskan praktik kepemimpinan individu dengan tujuan kesehatan nasional, perawat dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan tingkat tinggi dan realitas perawatan di samping tempat tidur pasien. Penyelarasan ini memastikan bahwa reformasi berskala besar seperti transformasi kesehatan digital dan cakupan universal dilaksanakan dengan fokus pada kesetaraan, keselamatan, dan pelestarian hubungan perawat-pasien, yang tetap menjadi denyut nadi sistem kesehatan.

Kepemimpinan keperawatan adalah sebuah perjalanan dalam pengembangan profesional dan pribadi yang berkelanjutan. Ini adalah proses yang menuntut keteguhan dalam karakter moral, pendidikan berkelanjutan, serta keberanian untuk mengangkat orang lain. Teori-teori yang dibahas dalam bab ini menawarkan kerangka yang kokoh untuk mengelola ketidakpastian seiring lanskap layanan kesehatan yang terus berkembang. Para pemimpin yang mampu menyeimbangkan visi dengan sikap pragmatis, serta kemahiran teknis dengan kepekaan emosional, akan berada pada posisi terbaik untuk membawa profesi kita menuju masa depan yang lebih minim pemborosan, lebih adil, dan yang terpenting lebih manusiawi.

## Referensi

- Almutairi, M., Timmins, F., Wise, P. Y., Stokes, D., & Alharbi, T. A. F. (2025). Authentic leadership—A concept analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 81(4), 1775–1793.
- Bole, E. H. (1987). Nursing leaders' use of humanistic behavioral and motivational leadership theories.
- Corazzini, K., Twersky, J., White, H. K., Buhr, G. T., McConnell, E. S., Weiner, M., & Colón-Emeric, C. S. (2015). Implementing culture change in nursing homes: An adaptive leadership framework. *The Gerontologist*, 55(4), 616–627.
- de-Diego-Cordero, R., Pérez-Jiménez, J. M., Rivero-Marin, S., Lucchetti, G., & Badanta, B. (2025). Sustainability and nursing: an integrative literature review. *Journal of Research in Nursing*, 30(7-8), 714–730.
- Deckard, G. J. (2009). Contingency theories of leadership. *Organizational behavior in health care*, 2, 191–208.
- Giltinane, C. (2020). Leadership Theories for Career Growth. *Indeed Career Guide*.
- Hall, V. P., White, K. M., & Morrison, J. (2022). The influence of leadership style and nurse empowerment on burnout. *Nursing Clinics*, 57(1), 131–141.
- Hancock, B. J., Porter-O'Grady, T., & Start, R. E. (2025). Transforming the full scope of leadership in complex adaptive systems. *Nursing Management*, \*56\*(6), 24–29.
- Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2012). *Management of organizational behavior: Leading human resources*. Pearson Education
- Hutchinson, M., & Jackson, D. (2013). Transformational leadership in nursing: towards a more critical interpretation. *Nursing inquiry*, 20(1), 11–22.
- Jackson, D. (2008). Servant leadership in nursing: A framework for developing sustainable research capacity in nursing. *Collegian*, 15(1), 27–33.
- Kamali, M., & Atashinsadaf, A. (2025). Task-Oriented Leadership as an Unfavorable Style: Examining the Relationship between Head Nurses' Leadership Styles and Nursing Staff Satisfaction in a Comparative Study of Specialized and General Wards.
- Lee, S. E., Hyunje, L., & Sang, S. (2023). Nurse managers' leadership, patient safety, and quality of care: a systematic review. *Western Journal of Nursing Research*, 45(2), 176–185.

- Orukwogu, U. (2022). Nursing leadership in healthcare: the impact of effective nurse leadership on quality healthcare outcomes. *IPS Interdisciplinary Journal of Social Sciences*, 1(1), 1–6.
- Park, H. T. (1997). Transformational and transactional leadership styles of the nurse administrators and job satisfaction, organizational commitment in nursing service. *The Journal of Nurses Academic Society*, 27(1), 228–241.
- Taylor, R. (2009). Leadership theories and the development of nurses in primary health care. *Primary Health Care*, 19(9).
- Wang, X., Liu, Y., Peng, Z., Li, B., Liang, Q., Liao, S., & Liu, M. (2024). Situational leadership theory in nursing management: a scoping review. *BMC nursing*, 23(1), 930.
- Watson, J. (2024). A new paradigm for nurse leader decision-making within complex adaptive systems. *Nursing Administration Quarterly*, 48\*(3), 207–208
- Willis, S., Clarke, S., & O'Connor, E. (2017). Contextualizing leadership: Transformational leadership and Management-By-Exception-Active in safety-critical contexts. *Journal of occupational and organizational psychology*, 90(3), 281–305.
- Xenikou, A., & Furnham, A. (2022). Leadership and organizational culture. *Handbook of research methods for organisational culture*, 23–38.
- Yakusheva, O., Lee, K. A., & Weiss, M. (2024). The nursing human capital value model. *International journal of nursing studies*, 160, 104890.
- Yoder-Wise, P. S., & Sportsman, S. (2022). *Leading and Managing in Nursing E-Book: Leading and Managing in Nursing E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Zivkovic, S. (2022). Empathy in leadership: how it enhances effectiveness. *Economic and social development: Book of proceedings*, 454–467.

# BAB 2

## MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA KEPERAWATAN

### A. Pendahuluan

---

Manajemen sumber daya manusia (SDM) keperawatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berperan strategis dalam menentukan kualitas layanan kepada pasien. Perawat sebagai tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkesinambungan, holistik, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Potter et al., 2021). Oleh karena itu, pengelolaan SDM keperawatan yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan utama dalam mencapai tujuan organisasi pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, manajemen SDM keperawatan tidak hanya berfokus pada pengelolaan tenaga kerja secara administratif, tetapi juga mencakup aspek pengembangan profesional, peningkatan kompetensi, serta pembinaan hubungan kerja yang harmonis. Kompleksitas pelayanan kesehatan yang terus berkembang menuntut adanya sistem manajemen SDM yang adaptif, responsif, dan berbasis pada kebutuhan pasien serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan (Gunawan, Aungsueroch, & Fisher, 2019).

Perubahan dinamika pelayanan kesehatan, seperti meningkatnya kompleksitas penyakit, tuntutan mutu pelayanan, serta perkembangan teknologi medis, memberikan dampak signifikan terhadap kebutuhan tenaga keperawatan. Kondisi ini menuntut perencanaan SDM yang matang, rekrutmen yang selektif, serta pengembangan kompetensi yang berkelanjutan agar tenaga perawat mampu menghadapi tantangan tersebut secara profesional dan kompeten (World Health Organization, 2020).

Selain itu, keberhasilan manajemen SDM keperawatan juga sangat dipengaruhi oleh faktor motivasi, kepuasan kerja, dan retensi tenaga perawat. Lingkungan kerja yang kondusif, kepemimpinan yang efektif, serta sistem penghargaan yang adil akan mendorong perawat untuk bekerja secara optimal dan meningkatkan loyalitas terhadap organisasi. Sebaliknya, pengelolaan SDM yang kurang baik dapat berdampak pada rendahnya kinerja, tingginya tingkat turnover, serta menurunnya kualitas pelayanan keperawatan (Rivai, 2016).

Manajemen konflik dan hubungan kerja juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan SDM keperawatan. Interaksi yang intensif antara perawat dengan tenaga kesehatan lain, pasien, dan keluarga pasien berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan komunikasi yang efektif serta strategi penyelesaian konflik yang tepat untuk menjaga keharmonisan tim dan kualitas pelayanan (Shirey, 2013).

Akhirnya, evaluasi dan monitoring manajemen SDM keperawatan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan SDM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan SDM, serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen SDM keperawatan yang efektif diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Almasri, 2016).

## **B. Manajemen Sumber Daya Manusia Keperawatan**

---

### **1. Defenisi**

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu manajemen yang fokus pada pengaturan peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pelayanan kesehatan dan keperawatan, MSDM tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek strategis yang mendukung keberhasilan pelayanan klinis dan mutu asuhan keperawatan (Almasri, 2016).

Menurut kajian global, *human resource management* dalam organisasi layanan kesehatan merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengoordinasikan dan memaksimalkan kinerja individu dan tim agar selaras dengan tujuan strategis organisasi pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit dan unit-unit keperawatan.

Secara spesifik dalam keperawatan, MSDM mencakup proses penempatan, pengembangan, evaluasi, pemeliharaan, dan pengelolaan tenaga keperawatan untuk mendukung pemberian asuhan keperawatan yang bermutu, aman, dan sesuai standar etika profesi (Gunawan, et al., 2019). Dalam literatur kompetensi berbasis MSDM keperawatan, konsep ini mencakup aktivitas seperti rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, sistem penghargaan, serta perencanaan karier bagi perawat.



Secara ringkas, Manajemen Sumber Daya Manusia Keperawatan dapat didefinisikan sebagai: Suatu proses strategis dan terintegrasi dalam organisasi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memperoleh, menempatkan, mengembangkan, memelihara, menilai, dan memotivasi perawat secara efektif sehingga kontribusi mereka mendukung pencapaian tujuan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

## 2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia Keperawatan

Tujuan MSDM keperawatan berakar dari tujuan umum MSDM, yaitu untuk memastikan bahwa *right people are in the right place at the right time* (manusia yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat) sehingga dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Tujuan khusus MSDM keperawatan meliputi:

- a. Menjamin Ketersediaan dan Alokasi Tenaga Perawat yang Tepat memastikan jumlah dan kompetensi perawat sesuai kebutuhan layanan keperawatan.
- b. Mengembangkan Kompetensi dan Profesionalisme Perawat melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis.
- c. Meningkatkan Kepuasan Kerja dan Retensi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung agar perawat tetap termotivasi serta berkomitmen pada organisasi.
- d. Mendukung Mutu dan Keamanan Pelayanan Keperawatan melalui pengelolaan tenaga kerja yang efektif yang berdampak pada keselamatan pasien dan kualitas hasil asuhan keperawatan.

## 3. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia Keperawatan

Ruang lingkup MSDM keperawatan mencakup berbagai kegiatan strategis dan operasional yang berkaitan dengan tenaga perawat mulai dari perencanaan hingga evaluasi, antara lain:

- a. Perencanaan Tenaga Keperawatan  
Merupakan proses menentukan jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan berdasarkan profil pasien, beban kerja klinis, serta tujuan layanan kesehatan.
- b. Rekrutmen dan Seleksi  
Mengidentifikasi, menarik, dan memilih calon perawat yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
- c. Orientasi dan Pelatihan Pengembangan  
Proses pengenalan kerja untuk perawat baru serta program pendidikan lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional perawat.

d. Penilaian Kinerja dan Perencanaan Karier

Evaluasi kontribusi perawat terhadap tujuan organisasi untuk memberi umpan balik, penghargaan, serta perencanaan pengembangan karier.

e. Kompensasi dan Retensi

Penentuan sistem penghargaan, insentif, dan fasilitas kerja yang adil untuk meningkatkan kepuasan kerja dan retensi perawat.

f. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Proses memastikan lingkungan kerja aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan perawat agar mereka dapat bekerja secara produktif dan meminimalkan risiko kerja.

g. Hubungan Kerja dan Kepatuhan Regulasi

Manajemen hubungan antara perawat dan organisasi, termasuk hubungan industrial, etika profesional, kepatuhan terhadap standar hukum dan peraturan keperawatan serta pengembangan budaya organisasi yang positif.

h. Evaluasi dan Peningkatan Mutu SDM

Meninjau kembali proses MSDM secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan serta inovasi dalam pengembangan SDM keperawatan yang adaptif terhadap tantangan sistem kesehatan.

## **C. Perencanaan Sumber Daya Manusia Keperawatan**

---

### **1. Definisi**

Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan adalah proses strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga perawat yang tepat jumlah, tepat kompetensi, dan tepat waktu sesuai kebutuhan organisasi pelayanan kesehatan. Proses ini mencakup analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan, serta penyusunan strategi pengadaan dan pengembangan tenaga perawat agar kualitas pelayanan tetap terjaga (Almasri, 2016; Gunawan, Aungsueroch, & Fisher, 2019).

Dengan kata lain, perencanaan SDM keperawatan adalah upaya untuk menyeimbangkan antara permintaan pelayanan keperawatan dan ketersediaan perawat, sehingga organisasi dapat beroperasi secara efektif tanpa kelebihan atau kekurangan tenaga kerja.

### **2. Tujuan Perencanaan SDM Keperawatan**

Tujuan perencanaan SDM keperawatan adalah:

- a. Menjamin ketersediaan tenaga perawat yang cukup dan kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasien dan pelayanan klinis.

- b. Mengoptimalkan distribusi dan alokasi perawat sesuai dengan kebutuhan spesifik unit kerja (misal ICU, UGD, rawat inap).
  - c. Memprediksi kebutuhan jangka panjang sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan jumlah pasien, kompleksitas kasus, dan tren pelayanan kesehatan.
  - d. Mendukung pengembangan profesional dan karier perawat, melalui identifikasi kompetensi yang perlu ditingkatkan sesuai proyeksi kebutuhan organisasi.
  - e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya (Keliat, 2003).
3. Ruang Lingkup Perencanaan SDM Keperawatan
- Perencanaan SDM keperawatan mencakup beberapa aktivitas penting, antara lain:
- a. Analisis Beban Kerja
 

Menghitung jumlah pasien, jenis layanan, dan kompleksitas kasus untuk menentukan jumlah perawat yang diperlukan di setiap unit layanan. Contohnya, rasio perawat terhadap pasien di ICU biasanya lebih rendah dibandingkan dengan ruang rawat inap biasa karena kebutuhan intensitas asuhan yang lebih tinggi (Gunawan et al., 2019).
  - b. Proyeksi Kebutuhan SDM
 

Melakukan prediksi jumlah perawat yang dibutuhkan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan tren pasien, pembukaan unit baru, dan pengembangan layanan.
  - c. Inventarisasi SDM yang Ada
 

Memetakan jumlah, kompetensi, pengalaman, dan distribusi perawat saat ini untuk melihat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan.
  - d. Identifikasi Kesenjangan Kompetensi
 

Mengevaluasi apakah kompetensi perawat saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan, dan merencanakan pelatihan atau pengembangan jika ada kesenjangan.
  - e. Strategi Rekrutmen dan Retensi
 

Menentukan strategi untuk mengisi kekurangan tenaga perawat dan menjaga agar perawat tetap bekerja di organisasi, termasuk program motivasi, kompensasi, dan pengembangan karier.
  - f. Evaluasi dan Pemantauan
 

Memonitor dan mengevaluasi perencanaan SDM secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara proyeksi kebutuhan dan realisasi di lapangan, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kondisi (Almasri, 2016).

4. Strategi Efektif dalam Perencanaan SDM Keperawatan
  - a. Pendekatan Data-Driven : Menggunakan data jumlah pasien, jenis layanan, dan tingkat kompleksitas kasus untuk perencanaan kebutuhan tenaga perawat.
  - b. Konsultasi dengan Kepala Unit dan Tim Keperawatan : Memastikan perencanaan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
  - c. Fleksibilitas Perencanaan : Menyediakan tenaga cadangan atau sistem shift fleksibel untuk menghadapi perubahan jumlah pasien secara mendadak.
  - d. Integrasi dengan Pengembangan Kompetensi : Menggabungkan perencanaan dengan strategi pelatihan agar kompetensi perawat selalu sesuai kebutuhan layanan.
5. Contoh Implementasi Perencanaan SDM Keperawatan
  - a. Rumah Sakit Pendidikan: Melakukan analisis rasio perawat terhadap pasien untuk unit rawat inap, ICU, dan UGD, kemudian menyesuaikan jadwal kerja dan rekrutmen perawat sesuai hasil analisis.
  - b. Fasilitas Kesehatan Komunitas: Mengidentifikasi jumlah perawat komunitas yang dibutuhkan untuk pelayanan lansia, imunisasi, dan home care, sehingga SDM tersedia sesuai jadwal program kesehatan masyarakat.

### **C. Rekrutmen dan Seleksi Perawat**

---

#### **1. Definisi**

Rekrutmen dan seleksi perawat adalah rangkaian proses sistematis untuk menarik, menilai, dan memilih calon perawat yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi pelayanan kesehatan. Rekrutmen berfokus pada menarik kandidat yang potensial untuk mengisi posisi perawat, sedangkan seleksi adalah proses evaluasi dan pemilihan kandidat terbaik untuk ditempatkan di unit layanan yang sesuai (Almasri, 2016; Gunawan, Aungsucho, & Fisher, 2019).

Dalam konteks keperawatan, proses ini bukan hanya soal memenuhi jumlah tenaga perawat, tetapi juga memastikan kualitas profesionalisme, keterampilan klinis, etika, dan kemampuan interpersonal agar pelayanan keperawatan aman, efektif, dan bermutu tinggi.

#### **2. Tujuan Rekrutmen dan Seleksi Perawat**

- a. Memastikan Ketersediaan Perawat Kompeten : Memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi perawat sesuai standar pelayanan kesehatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan : Dengan menempatkan perawat yang tepat pada posisi yang sesuai, pelayanan pasien menjadi lebih aman dan efektif.

- c. Mengurangi Turnover dan Kesalahan Klinis : Seleksi yang tepat mengurangi risiko ketidakcocokan antara perawat dan lingkungan kerja.
  - d. Mendukung Pengembangan Karier Perawat : Memilih perawat yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tenaga profesional yang lebih tinggi atau pemimpin unit keperawatan (Keliat, 2003).
3. Proses Rekrutmen Perawat
- a. Perencanaan Rekrutmen  
Langkah pertama adalah merencanakan kebutuhan rekrutmen berdasarkan hasil perencanaan SDM. Hal ini mencakup jumlah perawat yang dibutuhkan, spesialisasi atau kompetensi khusus, dan unit penempatan.
  - b. Sumber Rekrutmen
    - 1) Internal : Promosi, rotasi antar-unit, atau rekrutmen dari perawat kontrak di organisasi yang sama.
    - 2) Eksternal : Lowongan kerja di media cetak, online, kampus keperawatan, atau kerjasama dengan lembaga pendidikan keperawatan.
  - c. Promosi dan Penawaran Posisi  
Mempublikasikan lowongan dengan deskripsi pekerjaan, persyaratan kompetensi, serta fasilitas dan kompensasi yang menarik bagi calon perawat.
4. Proses Seleksi Perawat
- Seleksi bertujuan menilai kualitas kandidat agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan standar profesi keperawatan. Tahapan seleksi biasanya meliputi:
- a. Seleksi Administratif : Memeriksa dokumen pelamar, seperti ijazah, sertifikasi profesi, pengalaman kerja, dan dokumen pendukung lainnya.
  - b. Tes Kompetensi dan Keterampilan Klinis : Menilai kemampuan klinis perawat sesuai standar kompetensi yang berlaku.
  - c. Wawancara : Menggali motivasi, sikap, etika, dan kemampuan interpersonal kandidat.
  - d. Uji Psikometri (Opsional) : Menilai kepribadian, daya tahan stres, kemampuan beradaptasi, dan kompetensi psikososial.
  - e. Keputusan Seleksi : Memilih kandidat yang paling sesuai dan menyiapkan penawaran kerja.
5. Strategi Efektif Rekrutmen dan Seleksi Perawat
- a. Employer Branding : Menunjukkan reputasi organisasi sebagai tempat kerja yang profesional dan mendukung pengembangan karier perawat.
  - b. Kolaborasi dengan Pendidikan Keperawatan : Membina hubungan dengan sekolah atau akademi keperawatan untuk mendapatkan lulusan berkualitas.
  - c. Digital Recruitment : Menggunakan platform online, media sosial, dan portal pekerjaan untuk menjangkau kandidat lebih luas.

- d. Evaluasi Berkelanjutan : Mengevaluasi efektivitas proses seleksi untuk memastikan kandidat yang diterima berkinerja baik di tempat kerja.
- 6. Tantangan Rekrutmen dan Seleksi Perawat
    - a. Kekurangan Tenaga Perawat Terampil : Persaingan dengan rumah sakit lain atau lembaga kesehatan lain untuk mendapatkan perawat berkualitas.
    - b. Kecocokan Budaya dan Etika Kerja : Kandidat memiliki keterampilan klinis tetapi tidak cocok dengan budaya organisasi atau tim keperawatan.
    - c. Retensi Pasca Rekrutmen : Perlu strategi agar perawat baru tetap bertahan di organisasi dan termotivasi.
  - 7. Contoh Implementasi
    - a. Rumah Sakit Pendidikan : Mengadakan tes kompetensi klinis dan wawancara berbasis skenario untuk calon perawat baru.
    - b. Fasilitas Kesehatan Komunitas : Melakukan rekrutmen dari alumni akademi keperawatan lokal dan menyesuaikan kebutuhan kompetensi dengan layanan kesehatan masyarakat seperti home care dan imunisasi.

#### **D. Orientasi dan Induksi Tenaga Keperawatan**

---

##### **1. Definisi**

Orientasi dan induksi adalah proses sistematis yang diberikan kepada perawat baru untuk membantu mereka memahami lingkungan kerja, budaya organisasi, prosedur operasional, dan peran serta tanggung jawab mereka di unit pelayanan. Orientasi lebih fokus pada pengenalan awal, sedangkan induksi mencakup pembekalan lebih mendalam agar perawat dapat bekerja secara efektif dan aman sesuai standar profesi (Gunawan, Aungsuroch, & Fisher, 2019).

Orientasi dan induksi merupakan bagian penting dari manajemen SDM keperawatan karena dapat menentukan seberapa cepat perawat baru beradaptasi, menguasai keterampilan, dan memberikan kontribusi pada pelayanan pasien.

##### **2. Tujuan Orientasi dan Induksi Perawat**

- a. Memperkenalkan Budaya Organisasi : Membiasakan perawat baru dengan nilai, etika, dan budaya kerja di institusi kesehatan.
- b. Menjelaskan Peran dan Tanggung Jawab : Memberikan pemahaman jelas tentang tugas perawat di unit kerja masing-masing.
- c. Meningkatkan Kesiapan Klinis : Memberikan informasi dan keterampilan yang diperlukan agar perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.

- d. Mendorong Integrasi Sosial dan Tim : Membantu perawat baru membangun hubungan profesional dengan rekan sejawat dan supervisor.
  - e. Mengurangi Stress dan Turnover : Orientasi dan induksi yang baik membantu perawat menyesuaikan diri lebih cepat, sehingga risiko kelelahan dan keluar dari organisasi berkurang (Almasri, 2016).
3. Ruang Lingkup Orientasi dan Induksi
- Ruang lingkup orientasi dan induksi meliputi beberapa komponen penting:
- a. Pengenalan Organisasi
    - 1) Visi, misi, dan nilai-nilai rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
    - 2) Struktur organisasi, jalur komunikasi, dan peraturan internal.
  - b. Pengenalan Unit Kerja
    - 1) Fungsi unit, prosedur standar operasional (SOP), dan protokol keselamatan pasien.
    - 2) Penugasan tugas harian dan peran dalam tim keperawatan.
  - c. Pengenalan Kebijakan Klinis dan Etika Profesi
    - 1) Standar asuhan keperawatan.
    - 2) Etika profesi, hak dan kewajiban perawat, serta peraturan terkait keselamatan pasien.
  - d. Pelatihan Keterampilan Praktis
    - 1) Demonstrasi dan praktik keterampilan klinis yang relevan.
    - 2) Penggunaan peralatan medis dan teknologi kesehatan yang digunakan di unit.
  - e. Pendampingan dan Supervisi
    - 1) Mentor atau preceptor yang membimbing perawat baru selama periode orientasi.
    - 2) Penilaian kemajuan adaptasi dan keterampilan secara berkala.
4. Proses Orientasi dan Induksi Perawat
- a. Persiapan Sebelum Kedatangan : Menyediakan materi orientasi, jadwal, dan mentor yang akan mendampingi.
  - b. Orientasi Awal : Pengenalan fasilitas, aturan rumah sakit, unit kerja, dan tim.
  - c. Induksi Klinis : Pembekalan mendalam terkait prosedur klinis, SOP, protokol keselamatan, dan keterampilan khusus.
  - d. Evaluasi dan Umpan Balik : Menilai adaptasi perawat baru, memberi saran, dan memastikan kesiapan klinis untuk bekerja secara mandiri.
  - e. Pemantauan Lanjutan : Mentor memantau performa perawat selama 1–3 bulan pertama untuk memastikan integrasi sukses ke tim dan lingkungan kerja.

5. Strategi Efektif Orientasi dan Induksi
  - a. Program Preceptorship : Setiap perawat baru dibimbing oleh mentor berpengalaman agar belajar secara langsung di lapangan.
  - b. Modular Learning : Materi orientasi dan induksi disusun dalam modul yang mencakup teori, praktik, dan simulasi klinis.
  - c. Evaluasi Berbasis Kompetensi : Menggunakan checklist kompetensi klinis dan penilaian perilaku profesional.
  - d. Fleksibilitas dan Kustomisasi : Menyesuaikan program dengan kebutuhan individu dan spesialisasi unit kerja.
  - e. Feedback Dua Arah : Perawat baru diberi kesempatan menyampaikan pengalaman orientasi untuk meningkatkan program di masa depan.
6. Manfaat Orientasi dan Induksi yang Efektif
  - a. Mempercepat adaptasi perawat baru di lingkungan kerja.
  - b. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.
  - c. Mengurangi risiko kesalahan klinis dan masalah keselamatan pasien.
  - d. Meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas perawat baru.
  - e. Menciptakan budaya kerja yang profesional, aman, dan kolaboratif.

## **E. Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan**

---

### **1. Definisi**

Pengembangan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional perawat agar selalu sesuai dengan standar praktik keperawatan terkini, perkembangan ilmu kesehatan, dan kebutuhan pelayanan pasien (Gunawan, Aungsueroch, & Fisher, 2019).

Pendidikan berkelanjutan dalam keperawatan mencakup berbagai program seperti workshop, pelatihan klinis, kursus, seminar, dan program sertifikasi profesional. Tujuannya adalah untuk menjaga kompetensi perawat agar tidak usang seiring perkembangan teknologi, standar keselamatan pasien, dan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*).

### **2. Tujuan Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan**

- a. Meningkatkan Kualitas Asuhan Keperawatan : Perawat yang terlatih dengan kompetensi terbaru dapat memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi.
- b. Memperkuat Profesionalisme : Mengembangkan sikap etis, tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi profesional.



- c. Menjaga Kesesuaian Kompetensi dengan Standar Profesi : Memastikan setiap perawat memenuhi kompetensi minimum yang ditetapkan oleh badan akreditasi dan organisasi profesi.
  - d. Mendukung Pengembangan Karier Perawat : Memberikan peluang bagi perawat untuk naik jenjang karier atau menjadi spesialis.
  - e. Meningkatkan Retensi dan Kepuasan Kerja : Perawat yang diberi kesempatan belajar dan berkembang cenderung lebih termotivasi dan loyal (Almasri, 2016).
3. Ruang Lingkup Pengembangan Kompetensi
- Ruang lingkup pengembangan kompetensi perawat meliputi:
- a. Pendidikan Klinis
    - 1) Pelatihan keterampilan prosedur keperawatan.
    - 2) Simulasi kasus klinis untuk meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata.
  - b. Pendidikan Non-Klinis
    - 1) Kepemimpinan, manajemen, komunikasi efektif, dan pengembangan soft skills.
    - 2) Pendidikan tentang etika profesi, keselamatan pasien, dan kebijakan kesehatan.
  - c. Pendidikan Formal dan Sertifikasi
 

Pendidikan lanjutan seperti spesialis keperawatan, magister, atau sertifikasi profesi tertentu.
  - d. Pelatihan Berbasis Teknologi
 

E-learning, webinar, dan modul digital untuk meningkatkan akses pendidikan berkelanjutan.
  - e. Evaluasi Kompetensi
 

Penilaian berkala melalui uji kompetensi, penilaian kinerja, atau praktik berbasis bukti untuk memastikan kompetensi tetap relevan.
4. Proses Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan
- a. Analisis Kebutuhan Kompetensi : Mengidentifikasi gap kompetensi perawat berdasarkan standar praktik dan kebutuhan unit kerja.
  - b. Perencanaan Program Pendidikan : Menyusun jadwal pelatihan, seminar, workshop, dan kursus sesuai prioritas kompetensi yang diperlukan.
  - c. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan : Memberikan program pengembangan sesuai modul dan metode pembelajaran yang efektif.
  - d. Monitoring dan Evaluasi : Menilai efektivitas program pendidikan, ketercapaian kompetensi, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan keperawatan.
  - e. Peningkatan Berkelanjutan : Memperbarui program pendidikan berdasarkan evaluasi dan perkembangan ilmu serta teknologi kesehatan.

5. Strategi Efektif Pengembangan Kompetensi
  - a. Pendekatan Kompetensi Berbasis Praktik : Fokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk praktik klinis nyata.
  - b. Program Mentoring dan Preceptorship : Perawat berpengalaman membimbing perawat baru untuk transfer pengetahuan dan keterampilan.
  - c. Integrasi Pendidikan dengan Karier : Mengaitkan pengembangan kompetensi dengan peluang promosi atau spesialisasi.
  - d. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan : Kerjasama dengan universitas, akademi keperawatan, atau lembaga pelatihan profesional.
  - e. Pemanfaatan Teknologi : E-learning dan modul digital untuk pelatihan jarak jauh dan fleksibel.
6. Manfaat Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan
  - a. Peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien.
  - b. Perawat lebih percaya diri dan mampu menghadapi kasus klinis kompleks.
  - c. Menurunkan kesalahan klinis dan meningkatkan kepuasan pasien.
  - d. Meningkatkan motivasi, retensi, dan loyalitas perawat.
  - e. Memastikan organisasi memenuhi standar akreditasi dan regulasi profesi.

## **F. Penutup**

---

Manajemen sumber daya manusia (SDM) keperawatan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga perawat untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan pasien yang berkualitas. Tujuan utama manajemen SDM adalah memastikan tersedianya tenaga perawat yang kompeten, termotivasi, dan siap menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan. Ruang lingkupnya mencakup seluruh siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, orientasi, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, motivasi, manajemen konflik, hingga evaluasi dan monitoring kinerja (Gunawan, Aungsuroch, & Fisher, 2019; Almasri, 2016).

Perencanaan SDM keperawatan merupakan tahap strategis yang menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi perawat sesuai kebutuhan organisasi. Proses ini meliputi analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan perawat di masa depan, dan strategi untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan tenaga. Perencanaan yang baik membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan SDM dan menjaga kesinambungan pelayanan pasien dengan memastikan ketersediaan perawat yang tepat, pada waktu dan tempat yang dibutuhkan.

Rekrutmen dan seleksi perawat adalah proses menarik, menilai, dan memilih calon perawat yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi profesional. Proses ini

menggunakan metode seperti deskripsi pekerjaan yang jelas, wawancara berbasis kompetensi, uji keterampilan klinis, dan pengecekan referensi. Tujuannya adalah mendapatkan tenaga perawat yang berkualitas sehingga mampu mendukung pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berstandar tinggi.

Orientasi dan induksi adalah proses memperkenalkan perawat baru pada budaya organisasi, prosedur kerja, dan peran mereka dalam tim keperawatan. Proses ini bertujuan mempercepat adaptasi perawat baru, meminimalkan kesalahan klinis, dan meningkatkan kesiapan kerja. Strategi orientasi biasanya meliputi program preceptorship, modul orientasi, supervisi langsung, dan evaluasi kompetensi awal agar perawat dapat berfungsi secara optimal dalam lingkungan kerja.

Pengembangan kompetensi dan pendidikan berkelanjutan adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perawat agar selalu sesuai dengan standar praktik terbaru. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung perkembangan karier, dan memastikan kompetensi perawat tetap relevan dengan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan. Strategi pengembangan meliputi pelatihan klinis, pendidikan formal, e-learning, mentoring, sertifikasi profesional, dan program pendidikan berkelanjutan lainnya.

## Referensi

- Almasri, M. N. (2016). *Manajemen sumber daya manusia* (pdf). UIN SUSKA.  
<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/2547/1612>
- Gunawan, J., Aunguroch, Y., & Fisher, M. L. (2019). Competence-based human resource management in nursing: A literature review. *Nursing Forum*, 54(1), 91-101.  
[https://www.researchgate.net/publication/328646198\\_Competencebased\\_human\\_resource\\_management\\_in\\_nursing\\_A\\_literature\\_review](https://www.researchgate.net/publication/328646198_Competencebased_human_resource_management_in_nursing_A_literature_review)
- Human resource management research in healthcare: a big data bibliometric study. (2023). *Human Resources for Health*, [pmc.ncbi.nlm.nih.gov](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/).
- Keliat, B. A. (2003). *Manajemen sumber daya manusia keperawatan* (Tugas Akhir). Universitas Indonesia.  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20363686&lokasi=lokal>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rivai, V. (2016). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Shirey, M. R. (2013). *Leadership and nursing care management* (5th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2020). *Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025*. WHO.

## Glosarium

### A

---

Adaptasi: Proses penyesuaian perawat baru terhadap lingkungan kerja, budaya organisasi, dan sistem pelayanan kesehatan.

### D

---

Deskripsi Pekerjaan (Job Description): Dokumen yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam suatu posisi.

### I

---

Induksi: Proses pembekalan lanjutan bagi perawat baru untuk memahami tugas, tanggung jawab, serta standar kerja di unit pelayanan.

### K

---

Kompetensi Perawat: Kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang harus dimiliki perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.

### M

---

Manajemen SDM Keperawatan: Proses pengelolaan tenaga perawat secara sistematis melalui perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

### O

---

Orientasi: Program pengenalan awal bagi perawat baru mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan lingkungan kerja.

### P

---

Pendidikan Berkelanjutan: Proses pembelajaran terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi perawat sesuai perkembangan ilmu dan praktik keperawatan.

Pelatihan: Kegiatan terstruktur untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis perawat.

Perencanaan SDM Keperawatan: Proses menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi perawat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.

### R

---

Rekrutmen Perawat: Proses menarik calon perawat yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi yang tersedia.

Retensi Perawat: Upaya mempertahankan perawat agar tetap bekerja dalam organisasi dalam jangka waktu tertentu.

## S

---

Seleksi Perawat: Proses menilai dan memilih calon perawat berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi.

Standar Kompetensi: Kriteria minimal kemampuan yang harus dimiliki perawat dalam menjalankan praktik keperawatan.

## T

---

Tenaga Keperawatan: Individu yang memiliki pendidikan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.

## W

---

Workshop Keperawatan: Kegiatan pelatihan berbasis praktik untuk meningkatkan keterampilan klinis dan profesional perawat

# BAB 3

## MUTU PELAYANAN DAN KESELAMATAN PASIEN

### A. Pendahuluan

---

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien merupakan dua elemen kunci dari pelayanan kesehatan yang berkualitas. Mutu pelayanan mencakup kemampuan dari fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan yang aman, efektif, efisien, tepat waktu, berfokus pada pasien serta meningkatkan kepuasan pasien. Sebagai bagian dari mutu pelayanan, keselamatan pasien menjadi fokus penting, karena tanpa adanya perlindungan dari risiko atau kesalahan, kualitas pelayanan tidak dapat tercapai dengan optimal. Keselamatan pasien merupakan bagian integral dari mutu pelayanan, karena tanpa upaya untuk melindungi pasien dari risiko atau kesalahan, kualitas layanan tidak akan tercapai secara maksimal. Aspek keselamatan ini menekankan penerapan budaya keselamatan, prosedur berbasis bukti, partisipasi pasien dalam perawatan, serta sistem pelaporan dan mitigasi risiko yang efektif.

Dengan demikian, mutu pelayanan dan keselamatan pasien saling terkait dan saling memperkuat, menjadi dasar bagi layanan kesehatan yang profesional, aman, dan responsif. Pendekatan sistemik yang melibatkan tenaga kesehatan, manajemen, dan pasien sangat penting untuk memastikan layanan yang bermutu, aman, dan berkelanjutan.

### B. Konsep Mutu Pelayanan

---

Mutu pelayanan dalam kesehatan adalah kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan layanan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, adil, terintegrasi, dan efisien, sehingga secara nyata meningkatkan kemungkinan hasil kesehatan yang diinginkan dan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini. Mutu layanan ini tidak hanya mencakup proses klinis yang benar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, preferensi, serta pengalaman pasien dalam setiap tahap pelayanan. Pelayanan yang bermutu merupakan elemen penting dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage), karena mampu mencegah masalah kesehatan yang tidak perlu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan (WHO, 2023).

Mutu pelayanan kesehatan dapat dikaji melalui tiga pendekatan utama yaitu struktur, proses, dan outcome. Struktur mencakup sumber daya yang tersedia

seperti tenaga kesehatan, fasilitas, dan peralatan. Proses berkaitan dengan bagaimana pelayanan diberikan kepada pasien, termasuk ketepatan diagnosis dan tindakan medis. Sedangkan outcome merupakan hasil dari pelayanan tersebut, seperti tingkat kesembuhan, kepuasan pasien, dan keselamatan pasien. Konsep mutu pelayanan juga erat kaitannya dengan dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, yaitu *reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles*. Kelima dimensi ini menggambarkan bagaimana pelayanan harus diberikan secara andal, cepat tanggap, memberikan jaminan, menunjukkan kepedulian, serta didukung oleh fasilitas yang memadai.

Mutu pelayanan juga sangat berhubungan dengan keselamatan pasien (patient safety). Pelayanan yang bermutu harus mampu meminimalkan risiko kesalahan medis dan memberikan perlindungan maksimal kepada pasien. Oleh karena itu, penerapan sistem manajemen risiko dan budaya keselamatan menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan merupakan konsep yang multidimensional dan dinamis, yang menuntut keterlibatan seluruh elemen organisasi. Upaya peningkatan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi, inovasi, serta komitmen terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.

### **C. Dimensi Mutu Pelayanan**

---

Dimensi mutu pelayanan merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk menilai kualitas suatu layanan kesehatan dari perspektif pasien. Salah satu model yang paling banyak digunakan adalah SERVQUAL, yang meliputi lima dimensi utama, yaitu bukti fisik (*tangibles*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*) (Suwandi et al, 2024). Dimensi ini menggambarkan bagaimana layanan diberikan secara nyata, konsisten, cepat, terpercaya, serta memperhatikan kebutuhan pasien secara individual. Secara keseluruhan, dimensi mutu pelayanan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas layanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan kepuasan dan pengalaman pasien. Pelayanan yang memenuhi kelima dimensi tersebut cenderung menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi serta meningkatkan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan (Supiana, N.,et al, 2024).

Menurut Lewia 1993 dalam (Alamgir, 2023) Dimensi mutu layanan menggambarkan bagaimana interaksi antara perusahaan jasa dan pelanggannya. Hal tersebut digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dimensi teknis yang merupakan hasil dari proses layanan yang mencakup sistem dan teknologi. Contohnya sistem informasi rumah sakit dan beberapa teknologi radiologi dalam penegakan diagnosis medis.



2. Dimensi fungsional yang menggambarkan tentang bagaimana cara layanan diberikan yang mencakup antar pribadi antar karyawan dan pelanggan, penampilan dan kepribadian pegawai dan pelanggan, serta keluhan layanan.
3. Dimensi citra perusahaan yang menggambarkan hasil bagaimana pelanggan perusahaan, dan dibangun oleh kualitas teknis dan fungsional layanannya, dan pada akhirnya akan mempengaruhi layanan.

#### **D. Standar Mutu Pelayanan**

---

Standar mutu pelayanan merupakan pedoman atau tolok ukur yang digunakan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara aman, efektif, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Standar ini mencakup aspek pelayanan minimal, kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, serta prosedur pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap fasilitas kesehatan. Dengan adanya standar mutu, pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin kualitas layanan yang optimal. Standar mutu pelayanan juga berfungsi sebagai dasar dalam evaluasi dan peningkatan kualitas layanan, sehingga setiap fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang setara, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat (Kementrian Kesehatan RI, 2024).

##### **Komponen Standar Mutu Pelayanan**

1. Standar Input (Struktur) berupa : jumlah dan kualifikasi Tenaga Kesehatan, adanya sasaran dan prasarana, dan peralatan medis yang digunakan.
2. Standar Proses berupa : Adanya Prosedur Pelayanan (SOP), Alur pelayanan pasien dan komunikasi tenaga kesehatan.
3. Standar Output (Hasil) berupa : Tingkat kesembuhan, kepuasan pasien, dan angk kejadian insiden

#### **E. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan**

---

Mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem pelayanan, maupun lingkungan kerja. Faktor utama yang berperan antara lain kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas dan sarana, sistem manajemen, serta sikap dan komunikasi petugas. Selain itu, kemudahan akses layanan dan kondisi sosial pasien juga ikut memengaruhi penilaian terhadap mutu pelayanan yang diterima (Fitria, E., et al.2024).

Secara umum, mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh cara pelayanan diberikan secara efektif, tanggap, dan sesuai dengan

kebutuhan pasien. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan memerlukan pengelolaan yang menyeluruh dan terintegrasi agar tercapai pelayanan yang berkualitas, optimal, dan berkesinambungan (Lismawati, L., et al.2024).

## **F. Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan**

---

Strategi dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan melalui upaya yang terencana, terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan layanan yang aman, efektif, dan berkualitas. Pendekatan utama meliputi penguatan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta penerapan evaluasi dan perbaikan mutu secara terus-menerus. Selain itu, penting juga dilakukan pengukuran indikator mutu, pelaporan kepuasan pasien, dan manajemen risiko sebagai dasar perbaikan layanan (Kementrian Kesehatan RI, 2024).

Peningkatan mutu pelayanan juga memerlukan penguatan sistem kesehatan primer, pemerataan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan agar pelayanan tetap konsisten dan merata bagi masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, serta kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh (WHO & Kemenkes RI, 2024).

## **G. Penilaian Mutu Pelayanan**

---

Penilaian mutu pelayanan kesehatan merupakan proses yang sistematis guna mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian ini dilakukan melalui berbagai aspek, seperti kepuasan pasien, efektivitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepatuhan terhadap standar dan prosedur. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat pencapaian mutu serta sebagai acuan dalam melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan (Kemenkes RI, 2024).

Secara umum, penilaian mutu pelayanan bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai standar, memenuhi kebutuhan pasien, serta mampu meningkatkan kualitas dan kinerja fasilitas kesehatan secara konsisten. Oleh karena itu, penggunaan indikator mutu dan sistem monitoring yang terstruktur menjadi bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Suwandi, 2024).

## H. Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan

---

Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan merupakan kegiatan berkelanjutan untuk memantau, menilai, dan meningkatkan kualitas layanan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara rutin untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan dan pencapaian indikator mutu, sedangkan evaluasi bertujuan menilai kinerja serta mengidentifikasi masalah yang perlu diperbaiki (WHO, 2024).

Proses ini meliputi pengukuran indikator mutu, kepatuhan terhadap standar, dan analisis hasil pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dengan monitoring dan evaluasi yang terstruktur, fasilitas kesehatan dapat memastikan pelayanan tetap aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasien (Kemenkes RI, 2024).

Tujuan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi :

1. Untuk menilai kesesuaian pelayanan dan standar
2. Mengidentifikasi masalah atau penyimpangan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan
4. Mendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data
5. Menjamin keselamatan pasien

## I. Konsep Keselamatan Pasien

---

Keselamatan pasien merupakan bagian penting dari mutu pelayanan kesehatan yang berfokus pada upaya mencegah dan mengurangi risiko, kesalahan, atau bahaya yang dapat terjadi selama proses perawatan. Konsep ini melibatkan pembentukan budaya keselamatan, pengembangan prosedur berbasis bukti, serta keterlibatan tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi bahaya dengan efektif. Dalam praktiknya, keselamatan pasien mencakup serangkaian mekanisme yang terorganisir untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak buruk dari pelayanan kesehatan dan meningkatkan hasil perawatan secara berkelanjutan (WHO, 2025).

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Keselamatan Pasien merupakan suatu sistem yang mengarahkan untuk asuhan yang diberikan ke pasien agar lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Nurprilinda *et al.*, 2024).

## **J. Sasaran Keselamatan Pasien**

---

Sasaran keselamatan pasien adalah tujuan spesifik yang dirancang untuk mengurangi risiko dan mencegah kesalahan atau bahaya yang dapat dihindari selama pelayanan kesehatan. Sasaran ini membantu fasilitas kesehatan fokus pada area yang paling berisiko dan penting bagi keselamatan pasien. Beberapa sasaran utama meliputi:

1. SKP 1 : Identifikasi pasien yang tepat dan benar (Memastikan pasien yang menerima perawatan sesuai dengan identitas mereka).
2. SKP 2 : Komunikasi efektif antar tenaga kesehatan (Menjamin informasi klinis disampaikan dengan jelas dan akurat).
3. SKP 3 : Penggunaan obat yang aman (Mengurangi risiko kesalahan pemberian obat).
4. SKP 4 : Pencegahan infeksi terkait pelayanan kesehatan (Menjaga kebersihan dan prosedur aseptik).
5. SKP 5 : Keselamatan prosedur medis dan bedah (Meminimalkan risiko komplikasi atau kejadian tidak diinginkan selama tindakan medis).
6. SKP 6 : Pengurangan risiko jatuh pasien dan cedera lainnya (menciptakan lingkungan yang aman untuk pasien).

Penerapan sasaran ini dilakukan melalui budaya keselamatan pasien, prosedur berbasis bukti, pelaporan insiden, dan keterlibatan pasien dalam proses perawatan (WHO, 2024).

## **K. Standar Keselamatan Pasien<sup>3</sup>**

---

Standar merupakan kriteria ideal yang diinginkan, disusun oleh seseorang yang memiliki wewenang serta dikomunikasikan kepada orang yang dipengaruhi oleh standar tersebut (Bustami, 2011; Marquis & Houston, 2012;). Standar keselamatan pasien tersebut mengacu kepada Permenkes RI No. 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu: (Rachmawati *et al.*, 2023)

1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
7. Komunikasi, merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

## **L. Budaya Keselamatan Pasien**

---

Permasalahan penyakit tidak menular dan kronis seperti hipertensi cukup tinggi di Indonesia. Hal ini memerlukan penanganan yang mendalam dalam upaya pencapaian target ketiga SDGs untuk pencapaian Kesehatan baik dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, permasalahan hipertensi ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia melalui pelayanan penyakit tidak menular dalam kerangka kerja PIS-PK dan memerlukan peranan perawat komunitas dalam pelayanan asuhan keperawatan pada aggregate berisiko dan rentan di komunitas.

## **M. Ciri-ciri Budaya Keselamatan Pasien**

---

Ciri dari Budaya Keselamatan Pasien yaitu:

### **1. Komitmen Kepemimpinan**

Pimpinan fasilitas kesehatan menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan pasien melalui kebijakan, dukungan sumber daya, dan pengawasan implementasi standar keselamatan.

### **2. Pelaporan dan Pembelajaran dari Insiden**

Terjadi sistem pelaporan kejadian yang aman dan tanpa hukuman, sehingga tenaga kesehatan terdorong melaporkan kesalahan atau hampir celaka (*near miss*) untuk pembelajaran.

### **3. Transparansi dan Komunikasi Terbuka**

Informasi kritis tentang risiko dan keselamatan pasien disampaikan secara jelas, baik antar tenaga kesehatan maupun kepada pasien dan keluarga.

### **4. Kolaborasi Tim**

Tenaga kesehatan bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin untuk mencegah kesalahan dan meningkatkan kualitas perawatan.

### **5. Fokus pada Pasien**

Pasien dan keluarganya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, edukasi, dan pencegahan risiko selama perawatan.

### **6. Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan**

Terdapat mekanisme evaluasi, audit, dan peningkatan mutu secara rutin untuk memperkuat budaya keselamatan.

### **7. Kesadaran terhadap Risiko dan Pencegahan**

Tenaga kesehatan memiliki kesadaran tinggi terhadap potensi bahaya dan secara proaktif melakukan tindakan pencegahan.

## **N. Jenis Insiden Keselamatan Pasien**

---

1. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) Insiden yang menyebabkan cedera pada pasien
2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) Hampir terjadi cedera, tetapi dapat dicegah
3. Kejadian Tidak Cedera (KTC) Insiden terjadi, tetapi tidak menimbulkan cedera
4. Kondisi Potensial Cedera (KPC) Situasi berisiko tinggi yang bisa menyebabkan insiden

## **O. Faktor Risiko Keselamatan Pasien**

---

Keselamatan pasien dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari : sistem pelayanan, tenaga kesehatan, pasien, lingkungan, maupun teknologi yang digunakan. Faktor sistem meliputi prosedur yang tidak standar, kurangnya protokol keselamatan, serta keterbatasan sarana dan fasilitas. Faktor tenaga kesehatan mencakup kompetensi yang belum memadai, beban kerja yang tinggi, dan komunikasi yang kurang efektif antar staf (Kementrian Kesehatan RI, 2022).

Di sisi pasien, risiko muncul dari kondisi kesehatan yang kompleks, usia ekstrem, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur perawatan. Lingkungan pelayanan yang tidak aman atau kurang higienis juga berpotensi meningkatkan risiko keselamatan, termasuk risiko infeksi. Selain itu, penggunaan obat atau alat medis yang salah atau rusak menjadi faktor tambahan yang dapat menimbulkan kejadian yang merugikan pasien.

Memahami faktor-faktor risiko ini sangat penting agar fasilitas kesehatan dapat merancang strategi pencegahan, memperkuat protokol keselamatan, dan menciptakan lingkungan pelayanan yang aman bagi semua pasien.

## **P. Strategi dan Intervensi Keselamatan Pasien**

---

Keselamatan pasien dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi dan intervensi yang sistematis dan berfokus pada pencegahan risiko serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Strategi utama mencakup pembentukan budaya keselamatan yang mendorong pelaporan insiden tanpa hukuman, kolaborasi tim, dan kesadaran bersama tentang risiko pasien. Selain itu, penerapan protokol dan standar operasional berbasis bukti sangat penting untuk tindakan medis, pemberian obat, serta pencegahan infeksi, sehingga risiko kejadian merugikan dapat diminimalkan. Identifikasi dan manajemen risiko dilakukan secara rutin untuk mengenali potensi bahaya dan menetapkan langkah mitigasi sebelum insiden terjadi.

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan simulasi praktis juga menjadi intervensi kunci, sementara keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan meningkatkan kepatuhan, pemahaman, dan keamanan. Selanjutnya, monitoring, evaluasi, dan audit terhadap indikator keselamatan pasien memastikan perbaikan yang berkesinambungan. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi seperti *electronic medical records* dan barcode obat turut mendukung pengurangan kesalahan dan peningkatan akurasi pelayanan. Dengan menerapkan strategi dan intervensi ini secara konsisten, fasilitas kesehatan dapat menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih aman, mengurangi insiden berbahaya, dan meningkatkan kualitas perawatan pasien (Kementrian Kesehatan RI, 2022).

## **Q. Kepemimpinan dan Budaya Keselamatan**

---

Peran kepemimpinan sangat penting dalam membangun dan memelihara budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya menetapkan kebijakan dan standar keselamatan, tetapi juga mendorong komitmen staf, kerja sama tim, dan pelaporan insiden tanpa sanksi. Hal ini memungkinkan tenaga kesehatan melaporkan kesalahan atau hampir terjadi insiden sehingga pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dapat terlaksana. Budaya keselamatan pasien meliputi kesadaran kolektif terhadap risiko, penerapan prosedur berbasis bukti, komunikasi terbuka antar tenaga kesehatan, serta keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang konsisten memastikan bahwa budaya keselamatan bukan sekadar aturan formal, tetapi diterapkan secara nyata dalam praktik pelayanan sehari-hari, sehingga kualitas layanan meningkat dan risiko bahaya terhadap pasien diminimalkan. kepemimpinan yang kuat dan budaya keselamatan yang matang saling mendukung; kepemimpinan yang visioner dan proaktif menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan pelayanan yang aman, profesional, dan berfokus pada kebutuhan pasien.

Karakteristik Budaya Keselamatan yang Baik

1. *Just Culture* : Berfokus pada sistem, bukan menyalahkan individu
2. *Open Communication* : Staf bebas menyampaikan masalah tanpa takut
3. *Learning Organization* : Setiap insiden dijadikan pembelajaran
4. *Teamwork* : Kolaborasi antar tenaga kesehatan
5. *Awareness* (Kesadaran Risiko) : Semua staf memahami potensi bahaya

Strategi dalam meningkatkan kepemimpinan dan budaya keselamatan :

- a. Pelatihan dan Edukasi (Melakukan training keselamatan pasien secara rutin)
- b. Sistem pelaporan yang mudah (Pelaporan dapat menggunakan Digital & anonim)
- c. Feedback & Transparansi (Adanya hasil laporan disampaikan kembali ke staf)
- d. Safety Walkround (Pimpinan turun langsung ke lapangan)
- e. Penguatan Tim Keselamatan (Tim khusus yang aktif memonitor dan evaluasi)

## **R. Sistem Pelaporan dan Manajemen Resiko**

---

Sistem pelaporan dan manajemen risiko merupakan bagian penting untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Sistem pelaporan kejadian keselamatan pasien dirancang untuk menangkap informasi secara terstruktur mengenai insiden, kesalahan, atau hampir terjadi insiden (*near miss*), sehingga data tersebut dapat dianalisis dan digunakan untuk belajar serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Sistem ini tidak hanya mencatat kejadian, tetapi juga mendukung pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan data yang terkumpul.

Di sisi lain, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya yang bisa berdampak pada keselamatan pasien selama proses pelayanan kesehatan. Langkah-langkah manajemen risiko mencakup identifikasi risiko, analisis tingkat bahaya, tindakan mitigasi untuk mencegah dampak negatif, serta evaluasi berkala untuk memastikan strategi pengendalian risiko efektif. Dengan menerapkan kedua sistem ini secara konsisten, fasilitas kesehatan dapat mengurangi jumlah kejadian merugikan, meningkatkan kualitas perawatan, dan menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih aman bagi pasien dan tenaga kesehatan.

Adapun alur sistem pelaporan dalam keselamatan pasien :

1. Identifikasi Insiden : Melakukan identifikasi insiden yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter, perawat, dll) contohnya kesalahan dalam pemberian obat.
2. Pelaporan : Mencatat dalam sistem (manual/digital) pencatatan dilakukan secara cepat, jujur tanpa menyalahkan individu
3. Analisis : Dalam melakukan analisis metode yang sering digunakan adalah : *Root Cause Analysis* (RCA) dengan mencari akar masalah, dan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) yaitu dengan mencegah potensi kegagalan.
4. Tindak Lanjut / Mitigasi : Perbaikan SOP, Pelatihan staf, Perbaikan sistem (misalnya barcode obat)
5. Monitoring dan Evaluasi : Melakukan audit secara berkala, review tren insiden, feedback ke unit terkait



## **S. Teknologi dan Inovasi dalam Keselamatan Pasien**

---

Perkembangan teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. Teknologi dapat membantu mencegah kesalahan medis, memantau kondisi pasien secara real-time, dan meningkatkan akurasi prosedur klinis. Contohnya penggunaan *electronic medical records (EMR)* untuk memastikan catatan pasien lengkap dan akurat, serta sistem *barcode* pada pemberian obat untuk meminimalkan kesalahan dosis atau obat yang salah. Inovasi lain meliputi alarm system, telemonitoring, aplikasi pemantauan risiko, dan simulasi klinis digital yang membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selain itu, teknologi juga memungkinkan analisis data besar (*big data analytics*) dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi pola risiko, mencegah insiden berulang, serta meningkatkan kualitas perawatan secara proaktif. Penerapan teknologi dan inovasi ini tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien, tetapi juga mempermudah koordinasi antar tenaga kesehatan, mempercepat respons terhadap kondisi kritis, dan mendukung budaya keselamatan berbasis data. Dengan demikian, inovasi teknologi menjadi bagian penting dari strategi keselamatan pasien modern.

## **T. Hubungan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien**

---

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan mencakup kemampuan fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, tepat waktu, berpusat pada pasien, aman, dan adil. Sedangkan keselamatan pasien menekankan perlindungan pasien dari risiko, kesalahan medis, atau kejadian merugikan selama proses pelayanan. Hubungan keduanya sangat erat karena keselamatan pasien adalah komponen penting dari mutu pelayanan. Tanpa adanya perlindungan dari risiko dan kejadian merugikan, kualitas layanan tidak dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, peningkatan mutu pelayanan yang komprehensif, termasuk prosedur berbasis bukti, standar operasional, komunikasi yang baik, dan keterlibatan pasien akan meningkatkan keselamatan pasien. Dengan kata lain, mutu pelayanan yang tinggi tidak hanya terlihat dari hasil klinis yang baik, tetapi juga dari rendahnya insiden keselamatan pasien. Peningkatan kedua aspek ini memerlukan pendekatan sistemik, melibatkan tenaga kesehatan, manajemen fasilitas, dan pasien, sehingga tercipta layanan yang aman, profesional, dan berkelanjutan.

Hasil penelitian Nugraha dkk (2026) dalam Penelitian *systematic literature review* menunjukkan bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari

mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penerapan keselamatan pasien secara konsisten dan peningkatan mutu pelayanan berkelanjutan berkaitan dengan penurunan kesalahan medis, kejadian tidak diharapkan, dan cedera pasien, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan hasil kesehatan pasien secara optimal. Penelitian kuantitatif di RS Mitra Husada Pringsewu–Lampung menemukan bahwa keselamatan pasien berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu pelayanan secara langsung dan melalui kepuasan pasien sebagai variabel intervening. Hubungan antar variabel ini sangat kuat (koefisien korelasi tinggi), menunjukkan bahwa peningkatan keselamatan pasien terbukti berkaitan erat dengan mutu pelayanan yang dinilai baik oleh responden (Dianvayani, et al 2024).

Penelitian di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus menemukan bahwa dukungan manajemen keperawatan berkorelasi kuat dan signifikan dengan mutu pelayanan keselamatan pasien. Ini menunjukkan peran penting manajemen dalam menjembatani keselamatan pasien dengan mutu pelayanan secara langsung (Mustika, 2021).

## **U. Penutup**

---

Mutu pelayanan dan keselamatan pasien merupakan dua komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Keduanya saling berkaitan erat, di mana keselamatan pasien menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari keberhasilan hasil klinis, tetapi juga dari kemampuan dalam meminimalkan risiko, kesalahan, serta kejadian yang dapat merugikan pasien selama proses pelayanan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini meliputi penerapan standar pelayanan yang berbasis bukti, penguatan budaya keselamatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pelayanan yang aman dan efektif. Selain itu, partisipasi aktif pasien dan keluarga juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien juga harus didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, termasuk adanya pelaporan insiden dan pengelolaan risiko yang efektif. Setiap kejadian yang terjadi dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran guna mencegah terulangnya kesalahan di masa mendatang. Dalam hal ini, kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat dibutuhkan untuk mendorong komitmen seluruh elemen organisasi dalam meningkatkan mutu

pelayanan dan keselamatan pasien. Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien akan berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kesehatan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang sinergis antara tenaga kesehatan, manajemen fasilitas, pembuat kebijakan, dan pasien untuk mewujudkan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan. Dengan demikian, mutu pelayanan dan keselamatan pasien harus senantiasa menjadi prioritas utama dalam setiap pengembangan sistem pelayanan kesehatan sebagai wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## Referensi

- Agency for Healthcare Research and Quality. (2023). *Patient Safety and Quality Improvement Tools*. <https://www.ahrq.gov/patient-safety/resources.html>
- Amin, M. A., et al. (2023). *Gambaran Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas*. Jurnal Mitrasehat.
- Dianvayani, G., Aripin, Z., Syahidin, R., Mariati Asnar, E. S., & Paramarta, V. (2024). *Analisis Mutu Pelayanan Melalui Keselamatan Pasien dan Kepuasan Pasien*. Innovative: Journal of Social Science Research.
- Elvina, M., et al. (2023). *Hubungan Mutu Pelayanan dengan Kepuasan Pasien*. Jurnal Kesehatan Tambusai.
- Ferial, L. & Wahyuni, N. (2022). *Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkat dengan Menerapkan Keselamatan Pasien di Puskesmas*. Journal of Baja Health Science.
- Istiqamah, N. F., & Muhtahidah. (2024). *Analisis Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Standar Mutu Pelayanan Kesehatan*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Keselamatan Pasien di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mustika, I. F., Martutik, Y., Rusnoto, R., & Supardi, S. (2021). *Hubungan Dukungan Manajemen Keperawatan dengan Mutu Pelayanan Patient Safety di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus*. Prosiding University Research Colloquium.
- Nugraha, A. et al. (2023). *Quality of Care dalam UU Kesehatan*
- Nugraha, A., Paramarta, V., Kosasih, K., & Yuliaty, F. (2026). *Analisis Kompetensi Tenaga Kesehatan dan Mutu Pelayanan terhadap Keselamatan Pasien: Systematic Literature Review*. Jurnal Ners.
- Rizqi, A., & Betsyliane, R. (2024). *Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien*. Innovative: Journal of Social Science Research.
- Siregar, M., et al. (2023). *Hubungan Mutu Pelayanan BPJS dengan Kepuasan Pasien*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia.
- Shojania, K. G., & Dixon-Woods, M. (2023). *Patient Safety: Current Challenges and Future Directions*. BMJ Quality & Safety.
- Syaputri, R., & Hartono, B. (2023). *Implementasi Mutu Pelayanan JKN*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia.

- Suwandi, et al (2024). *Mutu Pelayanan Keperawatan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Vincent, C., & Amalberti, R. (2022). *Safety in Healthcare: Theory and Practice*. Springer.
- World Health Organization. (2023). *Patient Safety: Making Health Care Safer*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Patient Safety Fact Sheet: Technology and Innovation*. <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/quality-of-care-and-patient-safety>

## Glosarium

### A

|                     |           |                                                                                  |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Assurance (Jaminan) |           | Kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan rasa percaya dan aman kepada pasien. |
| Akses Kesehatan     | Pelayanan | Kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan.         |

### B

|                         |             |                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budaya (Safety Culture) | Keselamatan | Nilai, sikap, dan perilaku organisasi yang mendukung terciptanya pelayanan yang aman dan meminimalkan risiko bagi pasien. |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### D

|                   |          |                                                                                              |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensi Pelayanan | Kualitas | Aspek-aspek yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan berdasarkan konsep dari Parasuraman. |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### E

|                  |  |                                                                                          |
|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektivitas      |  | Kemampuan pelayanan dalam mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan medis.     |
| Efisiensi        |  | Penggunaan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan dalam memberikan pelayanan.       |
| Empathy (Empati) |  | Perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan pasien secara individu.                      |
| Evaluasi Mutu    |  | Proses penilaian terhadap kualitas pelayanan untuk mengetahui kesesuaian dengan standar. |

### F

|                     |  |                                                                                                    |
|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasilitas Kesehatan |  | Sarana fisik yang digunakan untuk menunjang pelayanan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. |
|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### H

|                             |  |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hak Pasien (Patient Rights) |  | Hak yang dimiliki pasien dalam menerima pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan menghormati martabat serta privasi mereka. |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### I

|         |           |                                                                                |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Inovasi | Pelayanan | Upaya pembaruan atau perbaikan dalam sistem pelayanan untuk meningkatkan mutu. |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|

---

## K

|                                          |  |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepuasan Pasien                          |  | Tingkat perasaan pasien setelah membandingkan pelayanan yang diterima dengan harapannya.                                           |
| Kesalahan Medis                          |  | Tindakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian pada pasien.       |
| Keselamatan Pasien :<br>(Patient safety) |  | Upaya untuk melindungi pasien dari risiko, cedera, atau kesalahan selama proses pelayanan kesehatan                                |
| Kesalahan Medis (Medical Error)          |  | Tindakan yang tidak sesuai standar yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien.                          |
| Kejadian Insiden                         |  | Peristiwa yang tidak diharapkan dalam pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian pada pasien. |
| Kondisi Sosial Pasien                    |  | Latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya pasien yang dapat memengaruhi penerimaan layanan kesehatan.                             |
| Kualitas Pelayanan Optimal               |  | Tingkat pelayanan terbaik yang dapat dicapai sesuai standar dan kebutuhan pasien.                                                  |
| Kepuasan Pasien                          |  | Penilaian pasien terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan harapan dan pengalaman.                                              |
| Kepatuhan terhadap Standar               |  | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan prosedur dan pedoman yang berlaku.                                                 |
| Kualitas Pelayanan yang Konsisten        |  | Pelayanan yang selalu memenuhi standar dan ekspektasi pasien dari waktu ke waktu.                                                  |

---

## M

|                 |           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitigasi Risiko |           | Upaya untuk mengurangi atau mencegah dampak dari risiko yang mungkin terjadi.                                                                                                                     |
| Mutu Kesehatan  | Pelayanan | Kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan layanan yang aman, efektif, efisien, tepat waktu, adil, terintegrasi, dan berfokus pada pasien sehingga meningkatkan hasil kesehatan yang diharapkan. |

|                                                        |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manajemen Risiko                                       | Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam pelayanan kesehatan                               |
| Model SERVQUAL                                         | Model pengukuran kualitas layanan yang terdiri dari lima dimensi utama yang dikembangkan oleh Parasuraman dan timnya.                    |
| Monitoring dan Evaluasi (Monev)                        | Proses pemantauan dan penilaian secara berkala untuk memastikan mutu pelayanan tetap terjaga.                                            |
| Mekanisme Pencegahan Risiko                            | Langkah-langkah sistematis yang diterapkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak buruk dari pelayanan kesehatan.              |
| <hr/>                                                  |                                                                                                                                          |
| O                                                      |                                                                                                                                          |
| Outcome (Hasil)                                        | Dampak atau hasil dari pelayanan kesehatan, seperti tingkat kesembuhan, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien.                         |
| <hr/>                                                  |                                                                                                                                          |
| P                                                      |                                                                                                                                          |
| Pelayanan Berfokus pada Pasien (Patient-Centered Care) | Pendekatan pelayanan yang menghargai kebutuhan, preferensi, dan nilai pasien dalam setiap proses perawatan.                              |
| Prosedur Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)      | Tindakan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaik.                                                       |
| Proses (Process)                                       | Tahapan atau cara pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien, termasuk diagnosis, tindakan medis, dan interaksi pelayanan.              |
| Pelayanan Kesehatan Berkelanjutan                      | Pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus dengan peningkatan kualitas dari waktu ke waktu.                                           |
| Pendekatan Sistemik                                    | Pendekatan yang melibatkan seluruh komponen (tenaga kesehatan, manajemen, dan pasien) dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan. |
| Pelayanan Minimal                                      | Batas minimal jenis dan kualitas pelayanan yang harus tersedia di fasilitas kesehatan.                                                   |
| Prosedur Operasional Standar (SOP)                     | Panduan tertulis yang mengatur langkah-langkah dalam memberikan pelayanan agar berjalan konsisten dan sesuai standar.                    |



|                                                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelayanan Kesehatan Berkelanjutan                       | Upaya peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus.                                                                              |
| Peran Kepemimpinan (Leadership Role)                    | Keterlibatan pimpinan fasilitas kesehatan dalam membangun budaya keselamatan dan memastikan penerapan standar keselamatan pasien.                  |
| <hr/>                                                   |                                                                                                                                                    |
| R                                                       |                                                                                                                                                    |
| Risiko                                                  | Kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau cedera pada pasien.                                                           |
| Reliability (Keandalan)                                 | Kemampuan memberikan pelayanan yang akurat dan konsisten.                                                                                          |
| Responsiveness (Daya Tanggap)                           | Kesediaan dan kecepatan dalam membantu pasien serta memberikan pelayanan.                                                                          |
| <hr/>                                                   |                                                                                                                                                    |
| S                                                       |                                                                                                                                                    |
| Struktur (Structure)                                    | Komponen sumber daya dalam pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan, fasilitas, dan peralatan.                                                 |
| Sistem Pelaporan Insiden                                | Mekanisme untuk mencatat dan melaporkan kejadian yang berhubungan dengan keselamatan pasien.                                                       |
| Standar Pelayanan                                       | Pedoman atau kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan.                                                           |
| Sumber Daya Manusia (SDM)                               | Tenaga kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.                                                                              |
| Sistem Manajemen Pelayanan                              | Pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan.                                           |
| Sasaran Keselamatan Pasien (Patient Safety Goals / SKP) | Tujuan spesifik yang dirancang untuk mengurangi risiko dan mencegah kesalahan atau bahaya yang dapat dihindari selama pelayanan kesehatan.         |
| SKP 1 – Identifikasi Pasien yang Tepat                  | Upaya memastikan bahwa pasien yang menerima perawatan sesuai dengan identitas mereka, untuk menghindari kesalahan medis akibat salah identifikasi. |

|                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKP 2- Komunikasi Efektif Antar Tenaga Kesehatan     | Menjamin informasi klinis disampaikan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu antara tenaga kesehatan agar keputusan dan tindakan medis benar. |
| SKP 3-Penggunaan Obat yang Aman                      | Praktik pemberian obat yang mengurangi risiko kesalahan dosis, jenis obat, atau cara pemberian.                                              |
| SKP 4-Pencegahan Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan | Langkah-langkah menjaga kebersihan, sterilisasi, dan prosedur aseptik untuk mencegah infeksi nosokomial.                                     |
| SKP 5-Keselamatan Prosedur Medis dan Bedah           | Upaya meminimalkan risiko komplikasi atau kejadian tidak diinginkan selama tindakan medis atau operasi.                                      |
| SKP6-Pengurangan Risiko Jatuh dan Cedera Pasien      | Langkah-langkah menciptakan lingkungan aman bagi pasien untuk mencegah jatuh atau cedera lain selama perawatan.                              |
| <hr/>                                                |                                                                                                                                              |
| T                                                    |                                                                                                                                              |
| Tenaga Kesehatan                                     | Individu yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kepada pasien.                                                |
| Tangibles (Bukti Fisik)                              | Penampilan fasilitas, peralatan, dan sumber daya manusia dalam pelayanan.                                                                    |
| <hr/>                                                |                                                                                                                                              |
| U                                                    |                                                                                                                                              |
| Universal Health Coverage (UHC)                      | Sistem jaminan kesehatan yang memastikan semua individu mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial.   |
| <hr/>                                                |                                                                                                                                              |

# BAB 4

## MANAJEMEN KONFLIK DAN KOMUNIKASI ORGANISASI

### A. Pendahuluan

---

Manajemen merupakan suatu proses yang mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang menjalankan fungsi manajemen secara sistematis akan lebih mampu mencapai target layanan publik. Marry Parker Follet (1918) menjelaskan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara George R.Terry (1972) menjelaskan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sementara Stephen P.Robbins dan Mary Coulter (2016), menjelaskan bahwa manajemen adalah proses mengkordinasikan dan mengintegrasikan aktifitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain

Beberapa studi tentang efektifitas manajemen organisasi, menunjukkan Efektifitas Organisasi tidak ditentukan oleh banyaknya praktek manajemen saja, akan tetapi praktek yang tepat sasaran dan berfokus pada stakeholder kunci (Theresa Gehringer, 2024), dan organisasi yang menjalankan komunikasi efektif dapat meningkatkan kinerja tim, menyelaraskan tujuan organisasi serta memperkuat hubungan kerja, sehingga efektifitas organisasi sangat bergantung pada komunikasi kepemimpinan (Salsabila et.al, 2025). Permasalahan implementasi komunikasi organisasi inilah yang seringkali menyebabkan Konflik dalam Organisasi, yang menuntut penyelesaian dalam manajemen dengan berbagai strategi yang dapat dilakukan

### B. Konsep Manajemen dan Manajemen Keperawatan Dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional

---

Pelaksanaan manajemen keperawatan dalam sebuah Institusi sering menimbulkan permasalahan yang memerlukan penyelesaian, diantaranya konflik antar tim kesehatan, keterbatasan sumber daya, permasalahan komunikasi dan tekanan pekerjaan yang tinggi, untuk itu program pengembangan kapasitas yang dibuat bagi perawat melalui CPD (Continuing Professional Development) harus mencakup manajemen konflik (conflict management), ketrampilan negosiasi

(negociation skills, berfikir kritis (critical thinking skills) dan pengambilan keputusan (decision making skills) (Natalia R.D. dan Novita R.V.D., 2024)

Dalam konteks Transformasi Kesehatan Nasional Keperawatan, Huber dan Joseph, (2022) menjelaskan bahwa pemimpin keperawatan memiliki peran strategis sebagai pemimpin perubahan pelayanan kesehatan dimana harus mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kesehatan, menggunakan inovasi pelayanan dan memimpin pelayanan yang berpusat pada pasien; Meningkatkan mutu pelayanan Keperawatan dengan tanggung jawab terhadap standar praktek keperawatan, patients'safety dan kualitas pelayanan; Mengelola sumber daya keperawatan meliputi perencanaan tenaga perawat, pengembangan kompetensi dan pengaturan beban kerja; Mengembangkan model pelayanan keperawatan profesional seperti Model Asuhan Keperawatan Professional (MAKP), tim keperawatan dan Primary Nursing. Dalam pelaksanaan Transformasi Kesehatan Nasional Keperawatan dimana menerapkan Sistem Kesehatan Modern, pemimpin keperawatan menghadapi berbagai tantangan diantaranya kekurangan tenaga perawat, peningkatan kompleksitas penyakit, tuntutan patients's safety, perkembangan teknologi kesehatan dan perubahan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pemimpin keperawatan harus memiliki kemampuan manajemen, kemampuan komunikasi, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan manajemen konflik dan kemampuan memimpin perubahan organisasi

Selain kapasitas klinis, pemimpin keperawatan juga harus memiliki kapasitas strategis dan profesional karena memiliki peran strategis diantaranya: memimpin perubahan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, mengelola sumber daya keperawatan dan mengembangkan model pelayanan keperawatan profesional, sehingga pemimpin keperawatan harus mampu beradaptasi dengan sistem perubahan kesehatan, menggunakan inovasi pelayanan dan memimpin pelayanan yang berpusat pada pasien (Huber, D dan Yoseph M., 2022). Dengan demikian, dalam transformasi sistem kesehatan nasional, perawat dan pemimpin keperawatan memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pelayanan, pengelolaan SDM kesehatan, implementasi patient safety dan inovasi pelayanan kesehatan.

### **C. Komunikasi Efektif dalam Manajemen Keperawatan**

---

Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan makna di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Goldhaber (1993) menjelaskan bahwa Komunikasi Organisasi adalah proses menciptakan dan bertukar pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung untuk mengatasi

ketidakpastian lingkungan organisasi, sedangkan Robbins & Judge (2017) mengemukakan bahwa Komunikasi Organisasi adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain dalam organisasi. Komunikasi organisasi biasanya terjadi dalam beberapa bentuk:

1. Komunikasi vertikal, merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan. Misalnya berbentuk instruksi kerja atau laporan kinerja
2. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar pegawai atau unit kerja yang setara. Misalnya koordinasi antar tim atau kerja kolaboratif antar beberapa bagian
3. Komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang terjadi lintas unit organisasi. Misalnya komunikasi yang menunjukkan adanya koordinasi yang terjadi antar departemen.

Apapun bentuknya komunikasi yang baik harus berjalan secara efektif. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas komunikasi organisasi, yaitu

1. Struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan alur komunikasi dan Organisasi yang terlalu birokratis sering menyebabkan distorsi informasi.
2. Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi keterbukaan komunikasi dalam organisasi. Pemimpin yang partisipatif cenderung menciptakan komunikasi dua arah
3. Budaya organisasi. Budaya organisasi dapat menentukan keterbukaan komunikasi, kepercayaan antar anggota dan pola hubungan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi internal dan kerja tim.
4. Teknologi komunikasi. Dalam era digital, komunikasi organisasi dipengaruhi oleh sistem informasi organisasi, komunikasi digital dan platform kolaborasi
5. Faktor individu. Faktor individu dapat meliputi: kemampuan komunikasi, persepsi, emosi dan pengalaman kerja. Faktor-faktor seperti persepsi selektif dan perbedaan bahasa dapat menjadi hambatan komunikasi.

Komunikasi memiliki posisi yang sangat penting dalam fungsi manajemen. Menurut Koontz & O'Donnell (1976) komunikasi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan berperan dalam proses berikut:

1. Perencanaan (Planning). Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan visi organisasi dan menjelaskan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian (Organizing)  
Komunikasi akan membantu terutama pada saat pembagian tugas dan koordinasi antar unit.
3. Pengarahan (Directing), dimana pemimpin menggunakan komunikasi untuk memberikan instruksi, memotivasi pegawai dan memimpin tim.

4. engendalian (Controlling) dimana komunikasi digunakan untuk evaluasi kinerja dan pelaporan hasil kerja.
5. Dapat disimpulkan bahwa tanpa komunikasi yang baik, fungsi manajemen tidak akan dapat berjalan secara efektif.

Hasil penelitian Purnama, A., Anisti, & Mutiah (2025) dalam Jurnal: *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial menunjukkan bahwa* strategi komunikasi organisasi seperti komunikasi dua arah, transparansi informasi, dan umpan balik rutin dapat meningkatkan motivasi kerja dan kinerja pegawai. Selanjutnya Arifandi et al. (2024) menyatakan dalam Jurnal: *Productivity: Journal of Integrated Business, Management, and Accounting Research* bahwa komunikasi organisasi berperan penting dalam koordinasi tim, penyelesaian konflik dan peningkatan produktivitas kerja, organisasi yang memiliki komunikasi efektif mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kinerja tim. Penelitian tentang komunikasi organisasi dan komitmen organisasi. Lyu (2024) menuliskan hasil penelitian dalam *International Journal of Research Studies in Management* bahwa terdapat hubungan positif antara komunikasi organisasi, komitmen organisasi, dan efektivitas organisasi. dan komunikasi yang baik meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap organisasi.

Penelitian Taán, W.F., Allama, F., & Williams, B. (2024) dalam Jurnal: *Applied Nursing Research* yang berfokus pada asuhan keperawatan di rumah sakit menunjukkan hasil keterampilan komunikasi merupakan prediktor penting kualitas asuhan keperawatan dan komunikasi efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa komunikasi organisasi merupakan faktor kunci dalam efektivitas rumah sakit, karena berperan dalam keselamatan pasien, kualitas pelayanan, kerja tim tenaga kesehatan, stabilitas tenaga kerja dan kinerja organisasi rumah sakit.

Komunikasi yang efektif juga terbukti dapat meningkatkan efektifitas kerja sama interdisiplin di rumah sakit . Bukti penelitian yang ditulis oleh Oliveira, N.M. (2025) Jurnal: *Revista FT* menunjukkan temuan bahwa komunikasi yang tidak efektif antar tenaga kesehatan dapat menyebabkan: kesalahan diagnosis, keterlambatan tindakan, kesalahan pengobatan. Model komunikasi seperti SBAR dan briefing tim terbukti dapat meningkatkan keselamatan pasien.

Bataller-Alonso et al. menulis dalam Jurnal: *Health Communication* (2025), dengan menggunakan metoda Bibliometric analysis terhadap 566 artikel penelitian komunikasi rumah sakit, menemukan topik penelitian utama yaitu komunikasi tenaga kesehatan dengan pasien, komunikasi tim kesehatan, komunikasi dalam transisi pasien dan komunikasi untuk patient safety.

Komunikasi juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Hasil penelitian Ali Saleh et al. (2024) yang ditulis dalam Jurnal: *International Journal of Health Administration* menunjukkan bahwa komunikasi dan teamwork yang baik meningkatkan efisiensi pelayanan, keselamatan pasien dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada pasien

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh struktur organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi, teknologi komunikasi dan faktor individu. Komunikasi memiliki kedudukan penting dalam semua fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Beberapa hasil Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi organisasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja pegawai, memperkuat kerja tim, meningkatkan komitmen organisasi dan menciptakan organisasi yang sehat dan produktif. Dari berbagai penelitian terbaru dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi di rumah sakit berpengaruh pada berbagai aspek penting, yaitu:

1. Keselamatan pasien

Komunikasi yang baik meningkatkan pelaporan insiden dan mencegah kesalahan medis.

2. Kualitas pelayanan kesehatan

Komunikasi efektif meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan kepuasan pasien.

3. Kerja tim tenaga kesehatan

Komunikasi memperkuat kolaborasi interprofesional.

#### **D. Manajemen Konflik dan Komunikasi Organisasi**

---

Konflik sering terjadi dalam organisasi dan seringkali muncul karena perbedaan kepentingan, persepsi, atau nilai antar individu atau kelompok. Robbins & Judge (2017) menjelaskan bahwa konflik adalah proses ketika suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepentingannya. Sementara manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif agar tidak merusak hubungan kerja dan bahkan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Rahim, 2022)

Menurut Robbins (2003) konflik dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perbedaan tujuan

Setiap individu atau unit memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya situasi dimana bagian keuangan ingin menghemat biaya, tetapi bagian pelayanan ingin meningkatkan kualitas layanan

2. Perbedaan persepsi

Individu individu dalam organisasi melihat masalah dari sudut pandang berbeda. Misalnya perawat merasa beban kerja terlalu tinggi, sementara manajer merasa sudah sesuai standar.

3. Keterbatasan sumber daya.

Situasi berikut dapat menimbulkan konflik diantara manajemen. Misalnya anggaran yang tersedia terbatas, tenaga kerja terbatas, fasilitas terbatas

4. Komunikasi yang buruk

Kesalahpahaman informasi diantara individu pelaku organisasi dapat memicu konflik. Hal ini dapat terjadi karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

5. Perbedaan nilai dan latar belakang

Adanya perbedaan nilai (value) diantara pelaku organisasi sering juga menimbulkan konflik. Misalnya: perbedaan budaya, latar belakang Pendidikan dan pengalaman kerja

Komunikasi Organisasi yng efektif terbukti dapat mencegah konflik dalam organisasi, apabila dijalankan dengan nada kejelasan (clarity), konsisten, kredibel, terbuka, empaty, tepat waktu dan ada umpan balik serta fleksible (adaptable). Untuk itu strategi komunikasi yang baik dijalankan untuk organisasi yang efektif mencakup langkah langkah berikut

1. Membangun Sistem Komunikasi Terstruktur dengan membuat SOP komunikasi, alur pelaporan harus jelas dan ada standarisasi dokumen
2. Mengembangkan Budaya Komunikasi Terbuka, Dimana ada keamanan psikologis (staf berani bicara), tidak menyalahkan (no blame culture) dan mendorong diskusi dan feedback
3. Penguatan Peran Kepemimpinan, dimana pemimpin harus menjadi role model komunikasi efektif, aktif mendengarkan (active listening) dan memberikan feedback konstruktif
4. Optimalisasi Teknologi Informasi, dengan memaksimalkan Sistem informasi manajemen rumah sakit, menggunakan aplikasi komunikasi internal dan menggunakan dashboard monitoring
5. Pelatihan dan Pengembangan SDM melalui pelatihan komunikasi efektif, Interprofessional communication dan manajemen konflik, 6. Penguatan Komunikasi Interprofesional melalui kegiatan kolaborasi dokter–perawat–tenaga kesehatan lain, ronde tim multidisiplin dan conference kasus (Case conference)



6. Monitoring dan Evaluasi dengan menggunakan metoda audit komunikasi, survey kepuasan staf dan Incident Report fokus pada kejadian miskomunikasi

Apabila Organisasi menerapkan komunikasi yang efektif maka akan dapat meningkatkan kinerja tim, mengurangi konflik, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan kepuasan kerja dan memperkuat budaya organisasi

Apapun penyebabnya, konflik harus dikelola dan diselesaikan dengan baik karena akan menimbulkan dampak negatif, yaitu menurunkan kinerja, merusak hubungan kerja dan bahkan dapat menimbulkan stres kerja. Namun demikian apabila dipandang secara positif akan memberikan dampak positif juga, misalnya meningkatkan kreativitas dan dari proses yang terjadi dapat muncul ide baru serta memperbaiki keputusan.

Untuk itu konflik dalam organisasi memerlukan penanganan atau pengelolaan yang baik dengan hasil yg baik bagi organisasi maupun pelaku organisasi

## **E. Strategi Manajemen Konflik dalam Organisasi**

---

Menurut Thomas & Kilmann (1974) terdapat 5 strategi utama untuk mengelola konflik dalam organisasi, sebagai berikut

1. Menghindar (Avoiding). Strategi ini dilakukan dengan menghindari konflik tanpa menyelesaikan masalah. Cara ini baik hanya untuk yang sifatnya sementara. Misalnya pimpinan menunda pembahasan konflik, menunggu situasi lebih kondusif
2. Akomodasi (Accommodating). Strategi dimana salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan. Contoh : perawat mengikuti keputusan dokter walau berbeda pendapat.
3. Kompetisi (Competing). Salah satu pihak berusaha memenangkan konflik. Biasanya digunakan dalam situasi darurat atau keputusan cepat.
4. Kompromi (Compromising). Sesuai dengan maknanya, strategi ini menggunakan mekanisme kompromi, untuk kedua pihak saling mengalah sehingga dapat menemukan titik tengah.
5. Kolaborasi (Collaborating). Merupakan Cara terbaik karena mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak (win-win solution).

Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap pemilihan dan pengelolaan konflik dalam organisasi. Akhavan Tabassi et al. (2025) dalam *International Journal of Production Research* menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan sangat mempengaruhi cara anggota tim menangani konflik. Kepemimpin yang memiliki relational leadership mampu meningkatkan koordinasi tim dan menurunkan konflik

destruktif dalam organisasi, sehingga dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan sangat menentukan dinamika konflik dalam tim kerja.

Sinaga, O. (2025) melaporkan dalam *Journal of Law and Social Sciences and Humanities* bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam manajemen konflik organisasi dan pemimpin yang responsive, adil dan mampu menjadi mediator, terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan konflik organisasi dan meningkatkan efektifitas organisasi

Selanjutnya Ahmad, R. B. (2024) melaporkan hasil penelitian *Transformational Leadership, Team Conflict, and Personality*, dan menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional mampu mengurangi konflik tim, menurunkan stres kerja dan meningkatkan hubungan kerja. Pemimpin transformasional cenderung menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan kolaboratif. Beberapa bukti evidence tentang penanganan konflik dalam organisasi khususnya di rumah sakit menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tila Januartiwi, Solehudin, Inas Syabanasyah. Dalam *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum* (2026) menjelaskan bahwa terdapat hubungan signifikan antara konflik interpersonal dengan kepuasan kerja ( $p = 0.000$ ), perawat dengan konflik tinggi cenderung kepuasan kerja rendah dan konflik berdampak pada kesejahteraan psikologis, kinerja serta mutu pelayanan kesehatan. Implikasi dari temuan ini adalah manajemen konflik yang buruk menurunkan kualitas pelayanan diperlukan kepemimpinan suportif dan komunikasi interpersonal yang kuat. Inti dari temuan ini bahwa konflik bukan hanya masalah relasi, tetapi berdampak langsung pada outcome pelayanan. Selanjutnya Nana Nathania et al, menguraikan dalam *Jurnal Kesehatan* (2026) bahwa intervensi manajemen konflik efektif meningkatkan komunikasi interpersonal, self-efficacy perawat, kepuasan kerja, kolaborasi tim dan persepsi keselamatan pasien dan program yang terbukti efektif adalah pelatihan *de-eskalasi* konflik, pelatihan komunikasi dan pencegahan kekerasan kerja. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa manajemen konflik harus dilakukan secara multi-level, mulai dari individu (skill komunikasi) sampai pada organisasi (budaya kerja & sistem), sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik dapat dikontrol dan diubah menjadi faktor peningkat kualitas layanan

Iqbal Sadjali Jayusman, Nasrullah dan Lina menuliskan dalam *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran (JUKEKE)* (2025) dengan temuan utamanya penyebab konflik utama adalah komunikasi tidak efektif, perbedaan kepentingan dan tekanan kerja tinggi dengan strategi yang efektif digunakan yaitu komunikasi terbuka, mediasi yang adil serta budaya kerja kolaboratif. Dampak manajemen konflik yang baik ternyata dapat meningkatkan kinerja tim, meningkatkan loyalitas staf dan mendorong inovasi. Inti

dari temuan ini bahwa konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi *driver inovasi organisasi*

Rahmah Adilah et al menuliskan dalam *International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS)* (2025) beberapa temuan sebagai berikut : strategi yang paling sering digunakan adalah kompromi (paling dominan), kolaborasi dan kompetisi & akomodasi dan yang paling jarang adalah menghindar. Implikasinya bahwa perawat cenderung memilih solusi win-win (kompromi & kolaborasi) akan tetapi perlu penguatan tentang keterampilan komunikasi dan pendidikan manajemen konflik. Inti dari temuan ini adalah strategi konflik di rumah sakit sudah adaptif, tetapi belum optimal secara sistematis.

Ahmad Mubaraq & Muhammad Syarif dalam *Ecotechnopreneur Journal* (2025) menuliskan temuan utama Work-family conflict, beban kerja, dan stress dan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja perawat dengan Faktor paling dominan: adalah konflik kerja dan keluarga. Implikasinya bahwa konflik tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga lintas domain (pekerjaan dan keluarga), untuk itu manajemen konflik perlu pendekatan manajemen SDM dan ada keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan. Implikasi dari temuan ini adalah konflik eksternal juga memengaruhi performa klinis di rumah sakit

P.S.R. Sambas menuliskan dalam Repositori Universitas Sumatera Utara (2025) dengan temuan utama manajemen konflik dengan disertai komunikasi efektif dapat meningkatkan produktivitas kerja perawat, implikasinya bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari komunikasi organisasi dan kunci utama adalah komunikasi sebagai alat resolusi konflik. Inti dari komunikasi adalah variabel mediator penting dalam manajemen konflik

Dalam pelayanan di rumah sakit dan pelayanan keperawatan ditemukan beberapa evidence yang dapat menjadi dasar pertimbangan pengelolaan konflik organisasi. Iqbal Sadjali Jayusman, Nasrullah, dan Lina, menulis dalam *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran (JUKEKE)* (2025) dengan temuan utama bahwa penyebab utama terjadinya konflik Adalah komunikasi tidak efektif , perbedaan kepentingan dan tekanan kerja tinggi. Adapun Strategi yang efektif dilakukan dengan komunikasi terbuka, mediasi yang adil dan budaya kerja kolaboratif. Dampak manajemen konflik yang baik adalah meningkatkan kinerja tim, meningkatkan loyalitas staf dan mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan

Dari berbagai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Konflik di rumah sakit adalah fenomena normal (inevitable) yang dapat dipicu oleh kompleksitas tim multidisiplin, tekanan kerja tinggi dan perbedaan nilai & kepentingan dengan dampak yang sangat luas yaitu pada individu: stres, kepuasan kerja menurun, kolaborasi tim menurun, kualitas pelayanan organisasi menurun serta keselamatan

pasien bisa terancam. Manajemen konflik yang efektif memberikan dampak positif yaitu dapat meningkatkan kinerja tim, komunikasi, keselamatan pasien dan inovasi organisasi

Faktor kunci keberhasilan adalah komunikasi efektif, kepemimpinan suportif, budaya kolaboratif dan pelatihan resolusi konflik. Dengan tren terbaru penelitian (2025–2026) yang berfokus pada interprofessional conflict, psychological impact, patient safety linkage dan organizational behavior approach. Manajemen konflik di rumah sakit bukan hanya fungsi administratif, tetapi merupakan kompetensi strategis yang menentukan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan keberhasilan organisasi kesehatan, sementara konflik yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber peningkatan kinerja dan inovasi

## **F. Penutup**

---

Manajemen adalah proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Teori manajemen berkembang dari klasik, hubungan manusia, hingga modern. Konflik organisasi terjadi karena perbedaan tujuan, persepsi, komunikasi, dan keterbatasan sumber daya. Konflik perlu dikelola dengan strategi yang tepat agar tidak merusak organisasi. Strategi penanganan konflik “kompromi” dalam beberapa penelitian dilaporkan yang paling banyak dipilih karena efektif untuk mengatasi konflik organisasi dan menghasilkan kepuasan semua pihak yang berdampak pada kinerja organisasi.

Beberapa bukti penelitian terbaru antara tahun terbaru antara 2025-2026 menunjukkan bahwa manajemen konflik di rumah sakit bukan hanya fungsi administratif, tetapi merupakan kompetensi strategis yang menentukan kualitas pelayanan, keselamatan pasien dan keberhasilan organisasi kesehatan. Konflik yang tidak dikelola akan menjadi risiko masalah organisasi sementara konflik yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber peningkatan kinerja dan inovasi dalam pelayanan organisasi.

## Referensi

- Adilah, R., et al. (2025). Nurses' conflict management strategies in regional public hospital. *International Journal of Research and Innovation in Applied Science (IJRIAS)*, 10(2), 112–120.
- Almost, J. (2006). Conflict within nursing work environments. *Journal of Advanced Nursing*, 53(4), 444–453.
- Almost, J., Wolff, A. C., Stewart-Pyne, A., McCormick, L. G., Strachan, D., & D'Souza, C. (2022). Managing and mitigating conflict in healthcare teams: An integrative review. *Journal of Advanced Nursing*, 78(4), 1003–1015. <https://doi.org/10.1111/jan.15072>
- Almost, J., Doran, D. M., Hall, L. M., & Laschinger, H. K. (2010). Antecedents and consequences of intra-group conflict among nurses. *Journal of Nursing Management*, 18(8), 981–992.
- De Dreu, C. K. W., & Gelfand, M. J. (2013). *The psychology of conflict and conflict management*. Psychology Press.
- DeChurch, L. A., & Marks, M. A. (2001). Maximizing the benefits of task conflict. *International Journal of Conflict Management*, 12(1), 4–22.
- Huber, D. (2022). *Leadership and nursing care management* (7th ed.). Elsevier.
- Januariwi, T., Solehudin, S., & Syabanasyah, I. (2026). Hubungan konflik interpersonal dengan kepuasan kerja perawat di rumah sakit. *Vitamin: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 4(2), 145–156. <https://doi.org/10.61132/vitamin.v4i2.2137>
- Jayusman, I. S., Nasrullah, N., & Lina, L. (2025). Manajemen konflik dalam meningkatkan kinerja tim di rumah sakit. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran (JUKEKE)*, 4(3), 210–220. <https://doi.org/10.56127/jukeke.v4i3.2343>
- Jehn, K. A. (1995). A multimethod examination of intragroup conflict. *Administrative Science Quarterly*, 40(2), 256–282.
- Kreps, G. L. (2019). *Communication in organizations*. Routledge.
- Labrague, L. J., & De los Santos, J. A. A. (2020). Workplace violence and conflict management in nursing. *Journal of Nursing Management*, 28(5), 1001–1009.
- Laschinger, H. K. S., & Fida, R. (2014). New nurses burnout and workplace empowerment. *Journal of Nursing Management*, 22(4), 432–442.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing* (10th ed.). Wolters Kluwer.

- Manser, T. (2009). Teamwork and patient safety in healthcare. *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*, 53(2), 143–151.
- Mubaraq, A., & Syarif, M. (2025). Work-family conflict and nurse performance: The mediating role of stress. *Ecotechnopreneur Journal*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v4i01.1483>
- Nathania, N., et al. (2026). Efektivitas intervensi manajemen konflik terhadap komunikasi dan kepuasan kerja perawat. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 15(1), 55–67.
- Natalia R.D. dan Novita R.V.D., (2024). The Role of Continuous Professional Development (CPD) in Improving Nurse Competence in Digital Era: Literature Review
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). Sage Publications.
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2008). Professional communication and team collaboration. In *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses*. AHRQ.
- Rahim, M. A. (2020). *Managing conflict in organizations* (4th ed.). Routledge
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., et al. (2018). Teamwork in healthcare. *BMJ Quality & Safety*, 27(4), 273–281.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson.
- Salas, E., Reyes, D. L., & McDaniel, S. H. (2018). The science of teamwork in healthcare. *American Psychologist*, 73(4), 593–600.
- Salsabila, et al (2025). The Role of Effective Communication in Leadership. A. Literature Review. *Klabat Journal of Management*. 6 (1): 40
- Sambas, P. S. R. (2025). Pengaruh manajemen konflik dan komunikasi terhadap produktivitas kerja perawat. Universitas Sumatera Utara Repository.
- Schein, E. H. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Wiley.
- Shapira-Lishchinsky, O. (2020). Nurse moral conflict and ethical decision making. *Nursing Ethics*, 27(2), 549–564.
- Theresa Gehringer (2024). How Managerial Practices Impact Perceived Organizational Effectiveness: A Study of Corporate Foundations. Administrative Science. University of Basel
- Vermeir, P., Vandijck, D., Degroote, S., et al. (2015). Communication in healthcare: A narrative review. *International Journal of Clinical Practice*, 69(11), 1257–1267.
- Wei, H., Roberts, P., Strickler, J., & Corbett, R. W. (2019). Nurse leaders' strategies to foster nurse resilience. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 681–687.
- World Health Organization. (2021). *Patient safety and quality of care*. WHO Press.

Wong, C. A., & Cummings, G. G. (2007). The relationship between nursing leadership and patient outcomes. *Journal of Nursing Management*, 15(5), 508–521.

## Glosarium

### A

Akreditasi rumah sakit adalah proses penilaian eksternal yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi guna menjamin peningkatan kualitas layanan kesehatan.

---

### B

Budaya Organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang memengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam mencapai tujuan organisasi.

Budaya kolaboratif adalah lingkungan kerja yang menekankan kerja sama, saling menghargai, komunikasi terbuka, dan berbagi tanggung jawab antar individu atau profesi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

---

### C

CPD (Continuing Professional Development) adalah proses pembelajaran berkelanjutan yang dilakukan oleh tenaga profesional untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sepanjang karier guna menjaga kualitas praktik profesional

Critical thinking skills adalah kemampuan berpikir secara logis, analitis, reflektif, dan sistematis dalam mengevaluasi informasi serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti.

---

### D

De-eskalasi konflik adalah teknik atau strategi komunikasi yang digunakan untuk menurunkan intensitas konflik, meredakan ketegangan emosional, dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih serius.

---

### I

Inovasi organisasi adalah proses pengembangan dan penerapan ide, metode, atau praktik baru dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing.

### K

Komunikasi Efektif adalah proses penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh penerima sehingga tujuan komunikasi tercapai dengan baik tanpa distorsi makna.

Kepemimpinan Suportif adalah gaya kepemimpinan yang menekankan dukungan emosional, penghargaan, perhatian terhadap kebutuhan bawahan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Kompetensi Strategis adalah kemampuan individu dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi.



Kolaborasi tim adalah proses kerja sama antar anggota tim dengan latar belakang berbeda yang saling berbagi peran, tanggung jawab, dan informasi untuk mencapai tujuan bersama.

Kompetensi klinis adalah kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan sesuai standar berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.

---

## M

MAKP: Model Asuhan Keperawatan Professional adalah suatu sistem atau kerangka kerja dalam pemberian asuhan keperawatan yang terstruktur, berbasis profesionalisme, dan berfokus pada kebutuhan pasien melalui pengorganisasian tenaga keperawatan secara efektif.

---

## N

Negotiating Skills adalah kemampuan untuk melakukan proses tawar-menawar secara efektif guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

---

## O

Organizational behavior approach adalah pendekatan dalam manajemen yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana perilaku tersebut memengaruhi kinerja organisasi.

---

## P

Primary Nursing (PN) adalah model asuhan keperawatan di mana seorang perawat bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan pasien selama periode perawatan.

Patients'Safety (Keselamatan Pasien) adalah sistem dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan keamanan pasien selama proses perawatan.

Psychological impact adalah dampak yang memengaruhi kondisi mental dan emosional individu akibat suatu peristiwa, lingkungan kerja, atau pengalaman tertentu.

---

## S

Self-efficacy perawat adalah keyakinan perawat terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas, mengatasi tantangan, dan memberikan asuhan keperawatan secara efektif.

---

# BAB 5

## BURNOUT DAN KESEJAHTERAAN PERAWAT

### A. Pendahuluan

---

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien selama 24 jam. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, beban kerja yang berat, serta tekanan emosional sering kali membuat perawat rentan mengalami burnout.

Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental akibat stres kerja yang berlangsung dalam jangka panjang. Fenomena ini sering terjadi pada profesi pelayanan manusia (human service), termasuk perawat. Burnout tidak hanya berdampak pada individu perawat, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien, dan efektivitas organisasi rumah sakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa burnout pada perawat dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental, kepuasan kerja, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan burnout dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan perawat.

Selain itu, kesejahteraan perawat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kesehatan mental, kepuasan kerja, hubungan sosial, dan keseimbangan kehidupan kerja. Burnout yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan perawat secara signifikan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai burnout dan kesejahteraan perawat agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas hidup perawat dan pelayanan kesehatan.

### B. Konsep Dasar Burnout

---

#### 1. Konsep Bournot

Burnout merupakan suatu kondisi kelelahan yang terjadi akibat stres kerja yang berlangsung secara kronis dan tidak berhasil dikelola dengan baik. Istilah burnout pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger pada tahun 1974 untuk menggambarkan kondisi kelelahan fisik dan mental yang dialami oleh individu yang bekerja pada bidang pelayanan manusia. Freudenberger

menggambarkan burnout sebagai keadaan kehilangan energi, motivasi, dan komitmen terhadap pekerjaan akibat tekanan kerja yang berkepanjangan.

Konsep burnout kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Christina Maslach dan Michael P. Leiter yang menjelaskan bahwa burnout merupakan sindrom psikologis yang muncul sebagai respons terhadap stres kerja kronis, terutama pada profesi yang berorientasi pada pelayanan kepada orang lain, seperti tenaga kesehatan, guru, dan pekerja sosial. Menurut mereka, burnout merupakan kondisi multidimensional yang mencakup kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi.

Dalam perspektif organisasi kerja, burnout dipahami sebagai kondisi dimana individu mengalami kelelahan secara emosional dan mental sehingga tidak lagi mampu memberikan kinerja optimal dalam pekerjaannya. Burnout tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, organisasi kesehatan dunia, World Health Organization, mengklasifikasikan burnout sebagai fenomena yang berkaitan dengan pekerjaan (occupational phenomenon) yang muncul akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola secara efektif. Burnout tidak dikategorikan sebagai penyakit medis, tetapi sebagai kondisi yang berkaitan dengan konteks pekerjaan.

## 2. Dimensi Bournout

- a. Kelelahan Emosional adalah perasaan lelah secara emosional akibat tuntutan pekerjaan yang berlebihan.
- b. Depersonalisasi merupakan perubahan sikap menjadi negatif, sinis, atau menjauh dari pasien.
- c. Penurunan Prestasi Diri merupakan perasaan tidak kompeten dan tidak produktif dalam pekerjaan.

## 3. Gejala Bournout

- a. Mudah lelah
- b. Emosi tidak stabil
- c. Menurunnya motivasi
- d. Gangguan tidur
- e. Penurunan kinerja

## 4. Konsep Kesejahteraan Perawat

Kesejahteraan perawat adalah kondisi dimana perawat mampu mencapai keseimbangan antara kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, Menurut teori kesejahteraan psikologis, terdapat beberapa dimensi utama:

- a. Penerimaan diri
- b. Hubungan positif

- c. Otonomi
  - d. Tujuan hidup
  - e. Pertumbuhan pribadi
5. Hubungan Bournout dan Kesejahteraan

Burnout memiliki hubungan negatif dengan kesejahteraan. Semakin tinggi burnout, semakin rendah kesejahteraan psikologis perawat. Hal ini terjadi karena burnout menguras energi emosional dan menurunkan kepuasan hidup.

### **C. Profesi Perawat dan Risiko Burnout**

---

#### 1. Profesi Perawat

Perawat adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Profesi ini tidak hanya berfokus pada tindakan medis, tetapi juga mencakup aspek bio-psiko-sosial dan spiritual pasien.

Menurut World Health Organization, perawat merupakan tulang punggung sistem pelayanan kesehatan karena memiliki intensitas kontak paling tinggi dengan pasien dibandingkan tenaga kesehatan lainnya.

#### 2. Peran dan Fungsi Perawat

Perawat memiliki beberapa peran utama, yaitu:

- a. Caregiver (pemberi asuhan) Memberikan perawatan langsung kepada pasien.
- b. Educator (pendidik) Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.
- c. Advocate (pembela pasien) Melindungi hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan.
- d. Coordinator (koordinator) Mengatur pelayanan kesehatan antar tim medis.
- e. Counselor (konselor) Memberikan dukungan emosional kepada pasien.

#### 3. Karakteristik Pekerjaan Perawat

Profesi perawat memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari profesi lain:

- a. Bekerja dalam sistem shift (pagi, siang, malam)
- b. Kontak langsung dan intens dengan pasien
- c. Menghadapi kondisi darurat dan kritis
- d. Tuntutan kerja tinggi dan cepat
- e. Tekanan emosional dari pasien dan keluarga

Karakteristik inilah yang membuat profesi perawat sangat rentan terhadap stres kerja.

#### 4. Faktor Penyebab Burnout pada Perawat

##### a. Faktor Individu :

- 1) Usia dan pengalaman kerja
- 2) Jenis kelamin
- 3) Kepribadian
- 4) Self-efficacy

Perawat dengan pengalaman kerja rendah cenderung lebih rentan terhadap burnout

##### b. Faktor Lingkungan

- 1) Beban kerja tinggi
- 2) Shift malam
- 3) Kurangnya tenaga kerja
- 4) Lingkungan kerja tidak kondusif

Beban Kerja Berlebihan, perawat sering menangani banyak pasien dalam satu waktu, terutama di rumah sakit dengan keterbatasan tenaga. Dan Jam Kerja Panjang, sistem shift, terutama shift malam, mengganggu pola tidur dan keseimbangan hidup. Lingkungan Kerja Adalah lingkungan kerja yang tidak kondusif, konflik tim, dan fasilitas terbatas turut memperburuk kondisi.

##### c. Faktor Organisasi

- 1) Kepemimpinan tidak efektif
- 2) Kurangnya penghargaan
- 3) System manajemen buruk

Kurangnya Dukungan merupakan kurangnya dukungan dari manajemen maupun rekan kerja meningkatkan risiko burnout.

##### d. Faktor psikologis :

- 1) Stres Kerja
- 2) Trauma pasien
- 3) Konflik interpersonal

Tekanan Emosional, berhadapan dengan pasien sakit, kritis, bahkan kematian dapat memicu stres emosional yang tinggi.

#### 5. Tanda dan Gejala Burnout pada Perawat

Burnout pada perawat dapat dikenali melalui:

##### a. Gejala Fisik

- 1) Kelelahan berkepanjangan
- 2) Gangguan tidur
- 3) Sakit kepala

##### b. Gejala Emosional

- 1) Mudah marah

- 2) Kehilangan empati
- 3) Perasaan putus asa
- c. Gejala Perilaku
  - 1) Menarik diri dari lingkungan kerja
  - 2) Penurunan kinerja
  - 3) Sikap sinis terhadap pasien

#### **D. Dampak Burnout pada Profesi Perawat**

---

Burnout tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga sistem pelayanan kesehatan:

1. Dampak bagi Perawat
  - a. Dampak Fisik
    - 1) Kelelahan kronis
    - 2) Gangguan tidur
    - 3) Sakit kepala
  - b. Dampak Psikologis
    - 1) Depresi
    - 2) Kecemasan
    - 3) Penurunan kepercayaan diri
  - c. Dampak Sosial
    - 1) Menarik diri
    - 2) Konflik dengan rekan kerja
2. Dampak Profesional
  - a. Penurunan kualitas kerja
  - b. Kesalahan medis
  - c. Turnover tinggi
3. Dampak bagi Rumah Sakit
  - a. Produktivitas menurun
  - b. Tingginya turnover tenaga perawat
4. Dampak bagi Pasien
  - a. Kualitas pelayanan menurun
  - b. Risiko kesalahan medis meningkat

## **E. Kesejahteraan Perawat**

---

1. Dimensi Kesejahteraan
  - a. Fisik
  - b. Psikologis
  - c. Sosial
  - d. Spiritual
2. Faktor Yang mempengaruhi
  - a. Lingkungan kerja
  - b. Dukungan sosial
  - c. Gaji dan insentif
  - d. Work-life balance
3. Work-Life Balance

Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting untuk mencegah burnout.

## **F. Strategi Penanganan Burnout**

---

1. Strategi Individu
  - a. Relaksasi
  - b. Olahraga
  - c. Manajemen stres
  - d. Mindfulness
2. Strategi Organisasi
  - a. Pengaturan jam kerja
  - b. Penambahan tenaga kerja
  - c. Pelatihan coping stress
3. Intervensi Psikologis
  - a. Konseling
  - b. Terapi kognitif
  - c. Support group
4. Promosi Kesejahteraan
  - a. Program kesehatan mental
  - b. Lingkungan kerja sehat
  - c. Penghargaan kinerja

## **G. Konsep Kesejahteraan Perawat**

---

Kesejahteraan perawat merupakan kondisi optimal yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan psikologis perawat sehingga mampu menjalankan tugas secara efektif, produktif, dan profesional. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, hubungan sosial, serta makna spiritual dalam kehidupan.

Kesejahteraan yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja, kualitas pelayanan, serta menurunkan risiko burnout. Sebaliknya, kesejahteraan yang rendah dapat menyebabkan stres kerja, kelelahan, dan penurunan kinerja. Secara umum, kesejahteraan perawat terdiri dari empat dimensi utama, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

### **1. Kesejahteraan Fisik**

Kesejahteraan fisik adalah kondisi dimana tubuh perawat berada dalam keadaan sehat, bugar, dan mampu menjalankan aktivitas kerja tanpa gangguan kesehatan yang berarti.

#### **a. Komponen Kesejahteraan Fisik**

- 1) Kondisi kesehatan umum
- 2) Kebugaran tubuh
- 3) Pola tidur yang cukup
- 4) Nutrisi yang seimbang
- 5) Beban kerja yang sesuai

#### **b. Faktor yang Mempengaruhi**

- 1) Jam kerja panjang (shift malam)
- 2) Kelelahan akibat beban kerja tinggi
- 3) Kurangnya waktu istirahat
- 4) Paparan risiko kerja (infeksi, cedera)

#### **c. Dampak Jika Tidak Terpenuhi**

- 1) Kelelahan kronis
- 2) Penurunan daya tahan tubuh
- 3) Risiko penyakit meningkat
- 4) Penurunan produktivitas

#### **d. Upaya Peningkatan**

- 1) Pengaturan jadwal kerja yang sehat
- 2) Istirahat yang cukup
- 3) Program kesehatan kerja
- 4) Olahraga rutin



## 2. Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis berkaitan dengan kondisi mental dan emosional perawat dalam menghadapi tuntutan pekerjaan.

### a. Komponen Kesejahteraan Psikologis

- 1) Stabilitas emosi
- 2) Kepuasan kerja
- 3) Rasa percaya diri
- 4) Kemampuan mengelola stres
- 5) Makna dan tujuan hidup

### b. Faktor yang Mempengaruhi

- 1) Tekanan kerja tinggi
- 2) Interaksi dengan pasien kritis
- 3) Konflik di tempat kerja
- 4) Dukungan organisasi

### c. Dampak Jika Tidak Terpenuhi

- 1) Stres kerja
- 2) Burnout
- 3) Depresi dan kecemasan
- 4) Penurunan motivasi

### d. Upaya Peningkatan

- 1) Pelatihan manajemen stres
- 2) Konseling psikologis
- 3) Dukungan dari atasan
- 4) Lingkungan kerja positif

## 3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas hubungan interpersonal perawat baik di tempat kerja maupun di kehidupan pribadi.

### a. Komponen Kesejahteraan Sosial

- 1) Hubungan dengan rekan kerja
- 2) Dukungan keluarga
- 3) Komunikasi yang efektif
- 4) Rasa kebersamaan

### b. Faktor yang Mempengaruhi

- 1) Budaya organisasi
- 2) Dukungan tim kerja
- 3) Konflik interpersonal
- 4) Work-life balance

- c. Dampak Jika Tidak Terpenuhi
    - 1) Isolasi sosial
    - 2) Konflik kerja
    - 3) Menurunnya kerja sama tim
    - 4) Stres interpersonal
  - d. Upaya Peningkatan
    - 1) Membangun komunikasi efektif
    - 2) Teamwork yang solid
    - 3) Dukungan sosial
    - 4) Kegiatan kebersamaan
4. Kesejahteraan Spiritual
- Kesejahteraan spiritual adalah kondisi dimana perawat memiliki rasa makna hidup, nilai-nilai moral, dan hubungan dengan keyakinan yang dianut.
- a. Komponen Kesejahteraan Spiritual
    - 1) Keyakinan agama
    - 2) Makna hidup
    - 3) Nilai moral
    - 4) Rasa syukur
  - b. Faktor yang Mempengaruhi
    - 1) Lingkungan kerja yang mendukung
    - 2) Kesempatan menjalankan ibadah
    - 3) Nilai-nilai personal
  - c. Dampak Jika Tidak Terpenuhi
    - 1) Kehilangan makna kerja
    - 2) Stres eksistensial
    - 3) Penurunan motivasi
  - d. Upaya Peningkatan
    - 1) Fasilitas ibadah di tempat kerja
    - 2) Dukungan spiritual
    - 3) Refleksi diri
    - 4) Pendekatan religius

Keempat dimensi kesejahteraan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya:

- a. Kesehatan fisik yang buruk dapat mempengaruhi kondisi psikologis
- b. Masalah sosial dapat memicu stres
- c. Kesejahteraan spiritual dapat memperkuat ketahanan mental

Dengan demikian, kesejahteraan perawat harus dipandang secara holistik (menyeluruh)

## H. Hubungan Burnout dengan Kesejahteraan Perawat

---

Burnout dan kesejahteraan perawat merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam konteks kesehatan kerja. Burnout menggambarkan kondisi kelelahan akibat stres kerja kronis, sedangkan kesejahteraan perawat mencerminkan kondisi optimal yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Hubungan antara keduanya bersifat negatif (berbanding terbalik), dimana semakin tinggi tingkat burnout, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan perawat..

### 1. Konsep Hubungan Burnout dan Kesejahteraan

Secara teoritis, burnout terjadi ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu dalam mengatasinya, sedangkan kesejahteraan tercapai ketika individu mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pendekatan Job Demand–Resources (JD-R Model):

- Job demand tinggi → meningkatkan risiko burnout
- Job resources tinggi → meningkatkan kesejahteraan

Dengan demikian, burnout muncul ketika sumber daya (dukungan, kontrol kerja, penghargaan) tidak mampu mengimbangi tuntutan pekerjaan.

### 2. Hubungan Burnout dengan Dimensi Kesejahteraan

#### a. Hubungan dengan Kesejahteraan Fisik

Burnout berdampak langsung pada kondisi fisik perawat. Kelelahan emosional yang berkepanjangan dapat menyebabkan:

- 1) Kelelahan kronis
- 2) Gangguan tidur
- 3) Penurunan daya tahan tubuh

Sebaliknya, kesejahteraan fisik yang baik dapat meningkatkan energi dan ketahanan tubuh sehingga mengurangi risiko burnout artinya :

- Burnout tinggi → kondisi fisik menurun
- Kesehatan fisik baik → burnout menurun

#### b. Hubungan dengan Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis merupakan aspek yang paling erat kaitannya dengan burnout. Burnout dapat menyebabkan:

- 1) Stres berkepanjangan
- 2) Kecemasan
- 3) Depresi
- 4) Penurunan kepuasan kerja

Sebaliknya, perawat dengan kesejahteraan psikologis tinggi (memiliki kontrol diri, tujuan hidup, dan emosi stabil) lebih mampu mengatasi tekanan kerja, artinya Burnout adalah indikator rendahnya kesejahteraan psikologis

c. Hubungan dengan Kesejahteraan Sosial

Burnout juga mempengaruhi hubungan sosial perawat, seperti:

- 1) Menurunnya empati terhadap pasien
- 2) Konflik dengan rekan kerja
- 3) Menarik diri dari lingkungan sosial

Sebaliknya, dukungan sosial yang baik dapat menjadi faktor protektif yang menurunkan burnout, artinya : Dukungan sosial tinggi → burnout rendah

d. Hubungan dengan Kesejahteraan Spiritual

Kesejahteraan spiritual berperan sebagai sumber kekuatan batin. Perawat dengan spiritualitas yang baik cenderung:

- 1) Memiliki makna kerja
- 2) Lebih sabar dalam menghadapi tekanan
- 3) Memiliki coping yang lebih baik

Burnout sering dikaitkan dengan hilangnya makna dalam pekerjaan, artinya : Spiritualitas tinggi → ketahanan terhadap burnout meningkat

e. Mekanisme Terjadinya Hubungan

Hubungan burnout dan kesejahteraan dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme:

1) Ketidakseimbangan Tuntutan dan Sumber Daya

Ketika beban kerja tinggi dan dukungan rendah, maka burnout meningkat dan kesejahteraan menurun.

2) Akumulasi Stres

Stres yang tidak dikelola akan berkembang menjadi burnout dan menurunkan kesejahteraan secara bertahap.

3) Penurunan Fungsi Psikologis

Burnout menyebabkan gangguan emosi dan kognitif yang berdampak pada kualitas hidup.

3. Faktor Yang memoderasi Hubungan

Beberapa faktor dapat memperkuat atau memperlemah hubungan burnout dan kesejahteraan, antara lain:

- a. Resiliensi → meningkatkan kemampuan menghadapi stres
- b. Dukungan sosial → mengurangi tekanan kerja
- c. Kepemimpinan → mempengaruhi lingkungan kerja
- d. Work-life balance → menjaga keseimbangan hidup

Perawat dengan faktor protektif tinggi cenderung memiliki kesejahteraan lebih baik meskipun menghadapi tekanan kerja.

## **I. Intervensi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Perawat**

---

Upaya meningkatkan kesejahteraan perawat harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, mencakup intervensi pada tingkat individu, tim, organisasi, hingga kebijakan. Hal ini penting karena kesejahteraan perawat dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional (fisik, psikologis, sosial, dan spiritual).

Intervensi yang efektif tidak hanya berfokus pada pengurangan burnout, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kepuasan kerja perawat.

### **1. Intervensi pada Tingkat Individu**

Intervensi individu bertujuan meningkatkan kemampuan perawat dalam mengelola stres dan menjaga keseimbangan hidup.

#### **a. Manajemen Stres**

Perawat perlu dibekali keterampilan dalam mengelola stres, seperti:

- 1) Teknik relaksasi (napas dalam, meditasi)
- 2) Time management
- 3) Pengendalian emosi

#### **b. Mindfulness dan Self-awareness**

Mindfulness membantu perawat:

- 1) Fokus pada kondisi saat ini
- 2) Mengurangi kecemasan
- 3) Meningkatkan ketenangan mental

#### **c. Pengembangan Resiliensi**

Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari tekanan. Dapat ditingkatkan melalui:

- 1) Pelatihan coping stress
- 2) Penguatan pola pikir positif
- 3) Dukungan emosional

#### **d. Gaya Hidup Sehat**

- 1) Olahraga teratur
- 2) Pola makan seimbang
- 3) Tidur cukup

Implikasi : Intervensi individu efektif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik serta menurunkan risiko burnout.

## 2. Intervensi pada Tingkat Tim (Sosial)

Lingkungan sosial kerja yang positif berperan besar dalam kesejahteraan perawat.

### a. Dukungan Sosial

- 1) Dukungan dari rekan kerja
- 2) Komunikasi terbuka
- 3) Budaya saling membantu

### b. Teamwork dan Kolaborasi

Tim yang solid dapat:

- 1) Mengurangi beban kerja individu
- 2) Meningkatkan rasa kebersamaan
- 3) Menurunkan konflik

### c. Program Peer Support

Program ini memungkinkan perawat saling berbagi pengalaman dan dukungan emosional.

Implikasi : Dukungan sosial terbukti sebagai faktor protektif utama terhadap burnout.

## 3. Intervensi pada Tingkat Organisasi

Organisasi memiliki peran paling besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan.

### a. Manajemen Beban Kerja

- 1) Distribusi tugas yang adil
- 2) Penambahan tenaga kerja
- 3) Pengaturan shift yang manusiawi

### b. Kepemimpinan yang Supportif

Pemimpin yang baik mampu:

- 1) Memberikan motivasi
- 2) Menciptakan lingkungan kerja positif
- 3) Mendukung kesehatan mental staf

### c. Program Kesehatan Mental

- 1) Konseling psikologis
- 2) Employee Assistance Program (EAP)
- 3) Workshop manajemen stres

### d. Penghargaan dan Insentif

- 1) Reward atas kinerja
- 2) Pengakuan profesional
- 3) Insentif finansial

e. Lingkungan Kerja yang Aman

- 1) Fasilitas kerja yang memadai
- 2) Keamanan kerja
- 3) Perlindungan dari risiko kerja

Implikasi : Intervensi organisasi paling efektif dalam jangka panjang karena menasar akar masalah burnout.

4. Intervensi pada Tingkat Kebijakan

Kebijakan institusi maupun pemerintah sangat mempengaruhi kesejahteraan perawat.

a. Kebijakan Jam Kerja

- 1) Pembatasan jam kerja berlebih
- 2) Pengaturan shift yang sehat

b. Standar Rasio Perawat-Pasien

Rasio yang seimbang dapat:

- 1) Mengurangi beban kerja
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan

c. Perlindungan Tenaga Kesehatan

- 1) Jaminan keselamatan kerja
- 2) Asuransi kesehatan
- 3) Dukungan hukum

Implikasi : Kebijakan yang tepat dapat menciptakan sistem kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan.

5. Intervensi Berbasis Spiritual

Pendekatan spiritual penting terutama dalam profesi keperawatan yang penuh tekanan emosional.

a. Dukungan Spiritual

- 1) Fasilitas ibadah
- 2) Konseling spiritual

b. Penguatan Makna Kerja

Perawat diajak memahami bahwa pekerjaannya memiliki nilai kemanusiaan tinggi.

c. Refleksi dan Self-healing

- 1) Journaling
- 2) Kegiatan keagamaan

Implikasi : Spiritualitas meningkatkan ketahanan mental dan mengurangi burnout.

## 6. Pendekatan Holistik dan Integratif

Intervensi terbaik adalah yang menggabungkan semua aspek:

- a. Individu → meningkatkan coping
- b. Sosial → memperkuat dukungan
- c. Organisasi → memperbaiki sistem kerja
- d. Spiritual → memperkuat makna hidup

Pendekatan ini disebut holistik, karena melihat perawat sebagai manusia secara utuh.

## 7. Evaluasi Efektivitas Intervensi

Untuk memastikan keberhasilan intervensi, perlu dilakukan evaluasi melalui:

- a. Tingkat burnout (skala Maslach Burnout Inventory)
- b. Kepuasan kerja
- c. Kesehatan mental
- d. Kinerja perawat

## **J. Implikasi Kebijakan dan Manajemen Rumah Sakit**

---

Hubungan burnout dan kesejahteraan memiliki implikasi penting, yaitu:

1. Rumah sakit perlu meningkatkan kesejahteraan perawat
2. Program pencegahan burnout harus diterapkan
3. Lingkungan kerja harus mendukung kesehatan mental
4. Perawat perlu dibekali keterampilan coping stress

## **K. Penutup**

---

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Burnout merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja berkepanjangan yang banyak dialami oleh perawat.
- b. Kesejahteraan perawat mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan.
- c. Burnout memiliki hubungan negatif dengan kesejahteraan perawat, dimana peningkatan burnout akan menurunkan kesejahteraan.
- d. Faktor penyebab burnout meliputi beban kerja tinggi, lingkungan kerja, serta kurangnya dukungan organisasi.
- e. Intervensi yang efektif harus dilakukan secara komprehensif mencakup individu, organisasi, dan kebijakan.
- f. Manajemen rumah sakit memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan perawat dan menurunkan burnout.



## 2. Saran

### a. Bagi Rumah Sakit

- 1) Meningkatkan kesejahteraan perawat melalui kebijakan yang mendukung
- 2) Mengatur beban kerja secara proporsional
- 3) Menyediakan program kesehatan mental

### b. Bagi Perawat

- 1) Meningkatkan kemampuan coping stress
- 2) Menjaga keseimbangan kehidupan kerja
- 3) Mengembangkan resiliensi

## Referensi

- Fatmawasi, F., Roza, N., & Badri, I. A. (2024). Hubungan beban kerja dengan burnout pada perawat di rumah sakit. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 5(1).  
DOI: <https://doi.org/10.55606/klinik.v5i1.5673>
- Djoar, R. K., Martha, A. P., & Romadhoni, F. R. (2022). Burnout syndrome perawat selama masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 18(2).  
DOI: <https://doi.org/10.30643/jiksht.v18i2.263>
- Sajodin, S., & Yualita, P. (2024). The relationship of resilience, self-efficacy and burnout syndrome among nurses. *Faletehan Health Journal*, 12(2).  
DOI: <https://doi.org/10.33746/fhj.v12i02.770>
- Olgun, S., & Adibelli, D. (2025). Burnout and sleep quality in nurses during the COVID-19 pandemic. *Ethiopian Journal of Health Sciences*, 35(3), 192–198.  
DOI: <https://doi.org/10.4314/ejhs.v35i3.7>
- Sharin, I. B. A., et al. (2025). Person-directed burnout intervention for nurses: A systematic review. *PLoS ONE*, 20(5).  
DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322282>
- Lin, K. H., Selvanayagam, N., Patnaik, S., & Kuo, C. Y. (2025). Burnout among nurses in ICU and emergency departments: A systematic review. *Journal of Emergency Nursing*, 51(4), 702–720.  
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jen.2025.02.007>
- Dinanda, N. M. D., & Dewi, I. G. A. M. (2024). Burnout of public hospital nurse: Work stress and workload effects. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(4), 371–391.  
DOI: <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v2i4.2436>
- Wienanda, A. K., et al. (2024). Literature review: Burnout pada perawat di rumah sakit swasta. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3).  
DOI: <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1489>
- Journal of Telenursing. (2024). Hubungan burnout dengan kinerja perawat di ruang rawat inap. *JOTING*, 6(2), 1730–1738.  
DOI: <https://doi.org/10.31539/joting.v6i2.10125>
- Lu, Y. X., & Wan, D. L. (2026). Burnout in nursing during COVID-19: Bibliometric analysis. *Medicine (Baltimore)*, 105(1).  
DOI: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000046125>

## Glosarium

### B

#### Beban Kerja (Workload)

Jumlah tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh perawat dalam periode tertentu.

#### Burnout

Kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja berkepanjangan, ditandai dengan kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian diri.

---

### C

#### Coping Stress

Strategi atau cara individu dalam menghadapi dan mengelola stres.

---

### D

#### Depersonalisasi (Depersonalization)

Sikap negatif, sinis, atau menjauh dari pasien sebagai respon terhadap stres kerja.

#### Dukungan Sosial (Social Support)

Bantuan emosional, informasi, atau dukungan dari orang lain seperti rekan kerja dan keluarga.

---

### I

#### Intervensi

Upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau meningkatkan kondisi tertentu.

---

### K

#### Kelelahan Emosional (Emotional Exhaustion)

Perasaan lelah secara emosional akibat tekanan kerja yang terus-menerus.

#### Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi staf untuk mencapai kinerja optimal.

#### Kepuasan Kerja (Job Satisfaction)

Perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi pengalaman kerja.

#### Kesehatan Mental

Kondisi kesejahteraan dimana individu mampu mengelola stres, bekerja produktif, dan berfungsi secara optimal.

#### Kesejahteraan Fisik

Kondisi kesehatan tubuh yang optimal sehingga perawat mampu menjalankan aktivitas kerja dengan baik.

#### Kesejahteraan Perawat

Keadaan optimal yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga perawat dapat bekerja secara efektif.

#### Kesejahteraan Psikologis

Keadaan mental yang stabil, termasuk kemampuan mengelola emosi dan memiliki tujuan hidup.

#### Kesejahteraan Sosial

Kondisi hubungan interpersonal yang baik dengan lingkungan sekitar.

#### Kesejahteraan Spiritual

Keadaan dimana individu memiliki makna hidup, nilai moral, dan hubungan dengan keyakinan.

#### Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Upaya untuk mencegah kesalahan dan cedera pada pasien selama pelayanan kesehatan.

#### Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai standar profesional.

---

#### L

##### Lingkungan Kerja

Kondisi fisik dan nonfisik tempat kerja yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan.

---

#### M

##### Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Proses pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.

##### Mindfulness

Kesadaran penuh terhadap kondisi saat ini tanpa penilaian untuk mengurangi stres.

---

#### P

##### Penurunan Pencapaian Diri (Reduced Personal Accomplishment)

Perasaan tidak mampu, tidak produktif, dan kurang percaya diri dalam pekerjaan.

---

#### R

##### Resiliensi (Resilience)

Kemampuan individu untuk bertahan dan bangkit dari tekanan atau stres.

---

S

Stres Kerja (Work Stress)

Respon fisik dan psikologis akibat tuntutan pekerjaan yang melebihi kemampuan individu.

---

T

Turnover

Tingkat keluar-masuknya tenaga kerja dalam suatu organisasi.

---

W

Work-Life Balance

Keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi.

---

# BAB 6

## TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DALAM MENGHADAPI KRISIS KESEHATAN

### A. Pendahuluan

---

Krisis kesehatan, seperti pandemi penyakit menular, bencana alam, maupun kegagalan sistem layanan, merupakan ujian serius bagi ketahanan sistem kesehatan dan profesi keperawatan. Dalam situasi tersebut, perawat berada di garis depan, berhadapan langsung dengan lonjakan pasien, keterbatasan sumber daya, tekanan emosional, dan risiko keselamatan diri. Kondisi ini menuntut model kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengontrol dan mengatur, tetapi juga menginspirasi, memberdayakan, dan menggerakkan perubahan positif di tengah ketidakpastian.

Model kepemimpinan tradisional yang cenderung birokratis, hierarkis, dan berorientasi perintah sering kali kurang luwes menghadapi dinamika krisis yang cepat berubah. Sebaliknya, kepemimpinan transformasional menawarkan pendekatan yang menekankan pengaruh teladan, motivasi inspiratif, stimulasi intelektual, serta perhatian terhadap pengembangan individu. Pendekatan ini relevan untuk memperkuat kapasitas perawat, meningkatkan resiliensi tim, dan mempertahankan mutu asuhan di tengah tekanan sistem.

Bab ini bertujuan membahas secara mendalam konsep dan landasan teori kepemimpinan transformasional, peran dan kompetensinya dalam menghadapi krisis kesehatan, strategi implementasi di berbagai tingkat fasilitas pelayanan, serta studi kasus penerapan di Indonesia. Dengan demikian, bab ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, manajer keperawatan, dan praktisi klinik dalam mengembangkan kepemimpinan yang tangguh dan adaptif di era penuh disrupsi.

### B. Kepemimpinan Transformasional

---

#### 1. Perkembangan Teori Kepemimpinan

Kajian kepemimpinan berkembang dari pendekatan awal yang menitikberatkan pada sifat bawaan (*trait theory*), perilaku (*behavioral theory*), hingga pendekatan kontinjensi yang mempertimbangkan situasi. Dalam organisasi modern, kepemimpinan tidak lagi dipandang sekadar kemampuan memerintah, tetapi juga kemampuan mengelola perubahan, membangun makna, dan memfasilitasi pembelajaran (Djoman & Thompson, 2025).

Teori kepemimpinan transaksional menggambarkan hubungan pemimpin–bawahan sebagai pertukaran: pemimpin memberikan imbalan atau hukuman sebagai respon terhadap kinerja. Pendekatan ini bermanfaat dalam situasi rutin dan terstruktur, namun sering kali kurang memadai dalam konteks krisis yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan motivasi intrinsik. Perkembangan teori kepemimpinan telah melalui evolusi signifikan sejak abad ke-19, mencerminkan pergeseran pemahaman dari faktor bawaan individu menuju interaksi dinamis antara pemimpin, pengikut, dan konteks situasional (Abu-Qutaish et al., 2025).

a. *Great Man Theory*

*Great Man Theory* (Teori Orang Hebat) merupakan teori kepemimpinan tertua yang muncul pada abad ke-19, dengan inti keyakinan bahwa pemimpin hebat "dilahirkan, bukan dibentuk". Teori ini menyatakan bahwa sejarah dunia dibentuk oleh tindakan individu-individu luar biasa yang memiliki bakat kepemimpinan bawaan, seperti karisma, kecerdasan, keberanian, dan visi yang unik. Pemimpin semacam ini akan muncul secara alami saat dibutuhkan oleh situasi historis kritis, tanpa memerlukan pelatihan formal atau pengalaman ekstensif (Agazu et al., 2025).

1) Sejarah dan Penggagas Utama

Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Carlyle (1795–1881), seorang sejarawan dan filsuf Skotlandia, dalam karya seminalnya *On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History* (1841). Carlyle berargumen bahwa "sejarah dunia hanyalah biografi orang-orang hebat", dengan contoh tokoh seperti Muhammad, Shakespeare, Luther, Rousseau, dan Napoleon Bonaparte yang mengubah arah peradaban melalui kekuatan pribadi mereka. Pandangan ini mencerminkan romantisme era Victoria yang mengagumi figur heroik sebagai penentu nasib bangsa (Ali et al., 2025).

Pada masa itu, teori ini didukung konteks sosial abad ke-19 di mana akses kepemimpinan dibatasi oleh kelas sosial, gender, dan warisan sehingga tampak bahwa hanya "orang hebat" yang bisa menembus batas tersebut. Di Indonesia, teori ini sering dikaitkan dengan figur seperti Soekarno, yang dianggap memiliki karisma bawaan untuk memimpin kemerdekaan (Sarwoko et al., 2023).

2) Karakteristik Utama Great Man Theory

Teori ini mengidentifikasi sifat-sifat bawaan (*innate traits*) yang membedakan pemimpin hebat dari orang biasa, meliputi:

- a) Karisma: Kemampuan mempengaruhi massa secara emosional.
- b) Kecerdasan superior: Visibilitas strategis dan pengambilan keputusan cepat.

- c) Keberanian dan keteguhan: Bertindak di saat krisis tanpa ragu.
- d) Integritas moral: Komitmen pada nilai-nilai yang lebih besar dari diri sendiri.
- e) Eloquence: Kemampuan berbicara yang menginspirasi (Anuar et al., 2022).

Menurut teori ini, pemimpin great man tidak hanya memimpin, tapi menciptakan sejarah melalui tindakan heroik yang mengubah jalannya peristiwa.

### 3) Kelebihan Great Man Theory

- a) Sederhana dan intuitif: Mudah dipahami, terutama dalam analisis historis di mana figur tunggal tampak mendominasi (misalnya Churchill di PD II).
- b) Menginspirasi: Mendorong pencarian pemimpin visioner di organisasi.
- c) Relevan untuk krisis: Efektif mengidentifikasi pemimpin karismatik saat situasi darurat.

### 4) Kelemahan dan Kritik Utama

Meskipun berpengaruh, teori ini banyak dikritik karena kurangnya dasar empiris dan pendekatan reduksionis:

- a) Tidak ilmiah: Tidak ada bukti genetik atau biologis yang mendukung "pemimpin dilahirkan". Studi modern menunjukkan kepemimpinan dapat dipelajari melalui pengalaman dan pelatihan. [trainingsemarang+1](#)
- b) Mengabaikan konteks: Herbert Spencer (1884) membalik argumen Carlyle: "Untuk great man membentuk masyarakat, masyarakat harus lebih dulu membentuknya". Faktor sosial, ekonomi, dan budaya sering lebih determinan daripada individu (Arruda & Wyner, 2023).
- c) Tidak inklusif: Mengabaikan kontribusi pengikut, tim, dan perempuan/minoritas yang *historically* terpinggirkan.
- d) Berbahaya potensial: Dapat membenarkan kultus kepribadian atau pemimpin otoriter seperti Hitler.
- e) Tidak universal: Banyak pemimpin efektif tanpa trait "heroik", dan sebaliknya.

### 5) Relevansi Kontemporer

Meski dianggap usang oleh teori modern (*trait, behavioral, transformational*), *Great Man Theory* tetap relevan dalam analisis krisis di mana karisma individu krusial, seperti pemimpin pandemi atau bencana. Namun, evolusi teori kepemimpinan kini menekankan *distributed leadership* dan pengembangan skill, bukan bakat bawaan semata.



## b. Trait Theory

*Trait Theory* (Teori Sifat) merupakan salah satu teori kepemimpinan paling awal yang berkembang pada awal abad ke-20, sebagai evolusi dari Great Man Theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin efektif memiliki kumpulan sifat atau karakteristik pribadi bawaan (traits) yang membedakan mereka dari non-pemimpin. Berbeda dengan Great Man Theory yang bersifat filosofis-romantis, Trait Theory menggunakan pendekatan ilmiah-eksperimental untuk mengidentifikasi trait universal melalui observasi dan pengukuran (Avinash & Joseph, 2024).

### 1) Sejarah dan Penggagas Utama

Trait Theory mulai populer pada 1920-an–1930-an melalui penelitian psikologi industri Amerika, dipelopori oleh Ralph Stogdill yang melakukan meta-analisis pertama pada 1948. Stogdill menganalisis lebih dari 120 studi dan mengidentifikasi trait seperti kecerdasan, dominasi, dan ketahanan emosional. Penelitian lanjutan oleh Edwin Ghiselli (1960-an) menemukan enam trait utama: pengawasan, keinginan untuk bertanggung jawab, kreativitas, kecerdasan, keterlibatan kerja, dan keyakinan diri. Tokoh lain seperti Gordon Allport (1930-an) mengembangkan Trait Theory dalam kerangka kepribadian umum, yang memengaruhi studi kepemimpinan.

Pada 1940-an, U.S. Army Officer Selection menggunakan Trait Theory untuk seleksi pemimpin militer, mengukur trait seperti intelektualitas dan stabilitas emosional. Di Indonesia, konsep ini sering diterapkan dalam seleksi pemimpin politik dan korporasi dengan penekanan pada integritas dan karisma lokal (Tsapnidou et al., 2024).

### 2) Karakteristik Utama Trait Theory

Berdasarkan meta-analisis klasik Stogdill (1948, direvisi 1974) dalam Hult (2023), trait pemimpin efektif dikelompokkan menjadi enam kategori utama:

**Tabel 6. 1** *Trait Theory*

| Kategori Trait | Contoh Karakteristik                | Dampak pada Kepemimpinan     |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Fisik          | Tinggi badan, penampilan menarik    | Memberi kesan otoritas awal  |
| Kepribadian    | Karisma, kepercayaan diri, dominasi | Meningkatkan pengaruh sosial |

|                |                                                |                                 |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Intelektual    | Kecerdasan di atas rata-rata, pengetahuan luas | Pengambilan keputusan strategis |
| Tugas-oriented | Aktivitas tinggi, organisasi, kreativitas      | Pencapaian tujuan efisien       |
| Sosial         | Kemampuan berinteraksi, kooperatif             | Membangun tim dan jaringan      |
| Motivasi       | Dorongan pencapaian, tanggung jawab            | Ketekunan dalam tekanan         |

*Trait modern (Big Five Personality): Extraversion* (terbuka, energik), *Conscientiousness* (terorganisir, bertanggung jawab), dan *Emotional Stability* paling berkorelasi dengan kepemimpinan efektif.

### 3) Kelebihan Trait Theory

- Dasar empiris kuat: Meta-analisis menunjukkan korelasi moderat ( $r = 0.20-0.30$ ) antara trait tertentu dengan kepemimpinan.
- Praktis untuk seleksi: Digunakan dalam asesmen psikometri (MBTI, Big Five) untuk rekrutmen eksekutif.
- Mendasari teori selanjutnya: Trait tetap menjadi fondasi behavioral, contingency, dan transformational leadership.
- Relevan lintas budaya: Karisma dan kecerdasan universal diakui di berbagai negara (Hult et al., 2023).

### 4) Kelemahan dan Kritik Utama

Trait Theory mengalami krisis replikasi pada 1940-an–1950-an karena:

- Tidak konsisten: Tidak ada daftar trait universal; efektivitas bergantung konteks.
- Mengabaikan perilaku: Fokus statis pada "siapa" pemimpin, bukan "apa" yang dilakukan.
- Sulit diukur: Trait seperti "karisma" subjektif dan sulit dioperasionalkan.
- Kurang prediktif: Memiliki trait tidak menjamin sukses kepemimpinan (hanya 20–30% varians).
- Diskriminatif: Mengabaikan minoritas dan kelompok terpinggirkan yang mungkin kekurangan trait "klasik".

Kritik seminal Stogdill (1948): "Karakteristik pemimpin hanya relevan dalam situasi tertentu. Kepemimpinan lebih kepada interaksi trait dan faktor situasional." (Association, 2024)

### 5) Evolusi dan Relevansi Kontemporer

Trait Theory berevolusi menjadi "Trait  $\times$  Situation" model pada 1960-an, yang memicu *contingency theories*. Penelitian modern (Cummings et al., 2023) mengintegrasikan trait dengan *predictor states* (kecerdasan

emosional, fleksibilitas kognitif) dan emergent leadership dalam tim self-managed.

Di era digital, trait seperti adaptabilitas, digital fluency, dan resiliensi menjadi krusial. Meta-analisis (Labrague, 2021) mengonfirmasi enam *trait inti tetap valid: drive, desire to lead, honesty/integrity, self-confidence, intelligence, dan job-relevant knowledge*.

6) Aplikasi praktis saat ini:

- a) Psikometri rekrutmen: *Hogan Assessments, Leadership Potential Assessment*.
- b) Pengembangan pemimpin: *Coaching* berbasis *trait Big Five*.
- c) Konteks Indonesia: Seleksi pemimpin daerah menekankan integritas dan karisma budaya lokal.

Trait Theory meletakkan fondasi ilmiah studi kepemimpinan dengan mengidentifikasi bahwa sifat pribadi berkontribusi signifikan (meski tidak menentukan) terhadap efektivitas kepemimpinan. Meski tidak lengkap, teori ini tetap relevan sebagai starting point seleksi dan pengembangan pemimpin dalam organisasi modern (Northouse, 2021).

c. Behavioral Leadership Theories

Behavioral Leadership Theory (Teori Kepemimpinan Perilaku) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan Trait Theory pada 1940-an–1950-an. Teori ini berfokus pada perilaku observable dan dapat diukur yang dilakukan pemimpin, bukan sifat bawaan. Inti utamanya: kepemimpinan adalah perilaku yang dapat dipelajari dan dilatih, bukan bakat alami. Pendekatan ini demokratis karena menyiratkan siapa pun dapat menjadi pemimpin efektif melalui pengembangan keterampilan perilaku yang tepat (He et al., 2022).

1) Sejarah dan Penggagas Utama

Teori ini dikembangkan melalui dua studi seminal di Amerika:

- a) Ohio State University Studies (1940-an, dipimpin Ralph Stogdill): Menganalisis 1.000+ pemimpin militer dan sipil, mengidentifikasi dua dimensi perilaku utama: Initiating Structure (struktur tugas) dan Consideration (perhatian orang).
- b) University of Michigan Studies (1940-an–1950-an, Rensis Likert): Membedakan Employee-Oriented (fokus karyawan) vs Production-Oriented (fokus produksi).

Penelitian ini dipopulerkan oleh Robert Blake & Jane Mouton melalui Managerial Grid (1964), yang memvisualisasikan kombinasi task vs people orientation dalam matriks 9x9. Di Indonesia, teori ini diterapkan dalam pelatihan manajemen BUMN dan pendidikan kepemimpinan nasional.

## 2) Dua Dimensi Utama Behavioral Leadership

Teori ini mengidentifikasi dua dimensi perilaku independen (bukan kontinum):

**Tabel 6. 2** Dua Dimensi Utama Behavioral Leadership

| Dimensi                              | Deskripsi                                                                        | Contoh Perilaku                                                      | Fokus              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Initiating Structure (Task-Oriented) | Perilaku untuk organisasi kerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan          | Menetapkan deadline, SOP ketat, evaluasi kinerja, koordinasi tugas   | Efisiensi, hasil   |
| Consideration (People-Oriented)      | Perilaku untuk hubungan interpersonal, dukungan emosional, dan kesejahteraan tim | Mendengarkan keluhan, memberi pujian, membangun trust, fleksibilitas | Kepuasan, motivasi |

Managerial Grid Blake-Mouton menggabungkan keduanya:

- a) (9,1) Authority-Compliance: Task maksimal, people minimal
- b) (1,9) Country Club: People maksimal, task minimal
- c) (5,5) Middle-of-the-Road: Keseimbangan moderat
- d) (1,1) Impoverished: Minim keduanya
- e) (9,9) Team Management: Ideal, keseimbangan tinggi

## 3) Karakteristik Utama

- a) Fokus observable behavior: Diukur melalui kuesioner (LBDQ - Leader Behavior Description Questionnaire).
- b) Dua dimensi ortogonal: Pemimpin bisa tinggi/rendah pada keduanya secara independen.
- c) Learned behavior: Pelatihan dapat meningkatkan kedua dimensi.
- d) High-High Leader: Paling efektif menggabungkan task + people orientation.

## 4) Kelebihan Behavioral Leadership Theory

- a) Dasar empiris kuat: Didukung ribuan observasi dari studi Ohio/Michigan.
- b) Praktis dan actionable: Memberi panduan konkret untuk pelatihan kepemimpinan.
- c) Demokratis: Siapa pun bisa dilatih menjadi pemimpin (9,9).
- d) Aplikasi luas: Digunakan dalam manajemen modern, 360° feedback, competency framework.

- e) Validasi meta-analisis: Korelasi tinggi dengan kepuasan karyawan dan produktivitas.

#### 5) Kelemahan dan Kritik Utama

- a) Ignores situation: Tidak semua situasi membutuhkan (9,9). Krisis mungkin butuh (9,1).
- b) One-size-fits-all: High-High tidak selalu optimal (Fiedler contingency theory).
- c) Simplistic: Hanya dua dimensi; mengabaikan faktor seperti power, culture, follower maturity.
- d) Measurement issues: Self-report bias dalam LBDQ.
- e) Limited generalizability: Kurang efektif di budaya kolektif Asia vs individualis Barat (Arruda & Wyner, 2023).

Kritik utama Stogdill (1974) dalam Zhang et al., (2023): "Tidak ada pola perilaku universal yang menjamin kepemimpinan efektif di semua situasi."

#### 6) Evolusi dan Relevansi Kontemporer

Behavioral Theory memicu Contingency Theories (Fiedler, Hersey-Blanchard) yang menambahkan faktor situasional. Saat ini terintegrasi dalam:

- a) 360° Leadership Assessment: Mengukur task/people behaviors.
- b) Competency-Based Leadership: World Bank, SHRM menggunakan framework serupa.
- c) Agile/Remote Leadership: Balancing structure (stand-up meetings) dengan consideration (well-being check-ins).
- d) AI Leadership Tools: Coaching apps menganalisis behavioral patterns.

Di konteks Indonesia: Diterapkan dalam Pelatihan Kepemimpinan ASN (LKPP) dengan adaptasi budaya *bapakisme* (high consideration) dan target KPI (high structure).

Behavioral Leadership Theory merevolusi studi kepemimpinan dengan menggeser fokus dari "who leaders are" ke "what leaders do", menjadikan kepemimpinan sebagai skill yang dapat diajarkan. Meski tidak lengkap tanpa faktor situasional, dua dimensi task vs people orientation tetap menjadi fondasi universal pengembangan pemimpin modern di organisasi, pendidikan, dan kesehatan (Avinash & Joseph, 2024).

#### d. Contingency dan Situational Theories

Era 1960-an membawa Contingency dan Situational Theories. Fiedler's Contingency Model (Fiedler, 1967) menyatakan efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan gaya pemimpin (task-oriented vs relationship-oriented) dengan situasi (leader-member relations, task structure, position

power). Hersey-Blanchard Situational Leadership Theory (Hersey & Blanchard, 1969) menyesuaikan gaya (telling, selling, participating, delegating) berdasarkan kematangan pengikut. Model ini menekankan "tidak ada gaya terbaik universal" (Hult et al., 2023).

Contingency dan Situational Theories (Teori Kontingensi dan Situasional) muncul pada 1960-an sebagai revolusi paradigma dalam studi kepemimpinan. Kedua teori ini menolak asumsi "one best way" dari teori sebelumnya (Trait, Behavioral), dengan prinsip inti: efektivitas kepemimpinan bergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin dan faktor situasional tertentu. Contingency lebih menekankan situasi eksternal (tugas, kekuasaan), sementara Situational fokus pada kesiapan bawahan.

#### 1) Contingency Theory (Fiedler Contingency Model)

Penggagas: Fred E. Fiedler (1967). Inti Teori: Efektivitas pemimpin ditentukan oleh kecocokan gaya kepemimpinan tetap (fixed style) dengan derajat favorability situasi. Pemimpin tidak perlu mengubah gaya; situasi yang harus disesuaikan (match leader to situation).

Tiga Faktor Situasional (Least Preferred Co-worker/LPC Scale):

**Tabel 6. 3** *Contingency Theory*

| Faktor                  | Deskripsi                        | Pengukuran                                   | Dampak                   |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Leader-Member Relations | Tingkat trust dan dukungan tim   | Tinggi = baik, Rendah = buruk                | Paling berpengaruh (67%) |
| Task Structure          | Tingkat kejelasan prosedur tugas | Tinggi = SOP jelas, Rendah = kreatif         | Pengaruh sedang          |
| Position Power          | Otoritas formal pemimpin         | Tinggi = bisa promosi/punish, Rendah = lemah | Pengaruh kecil           |

Oktet Situasi (8 Kombinasi):

a) Situasi Ekstrem (Sangat Baik/Sangat Buruk): Task-oriented efektif

b) Situasi Moderat: Relationship-oriented efektif

Curvilinear Relationship: Task-oriented → ekstrem situations; Relationship-oriented → moderate situations.

#### 2) Situational Leadership Theory (Hersey-Blanchard)

Penggagas: Paul Hersey & Ken Blanchard (1969) dalam Ali et al., (2025). Inti Teori: Pemimpin fleksibel mengubah gaya berdasarkan tingkat kematangan/competence bawahan (follower readiness). Fokus pada development level individu.

Empat Gaya Kepemimpinan (S1-S4) dan Kematangan Bawahan (M1-M4):

**Tabel 6. 4** *Situational Leadership Theory*

| Gaya                         | Tingkat Kematangan        | Deskripsi                   | Fokus              |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| S1: Telling/Directing        | M1 (Tidak mau/tidak bisa) | High Task-Low Relationship  | arahan ketat       |
| S2: Selling/Coaching         | M2 (Mau tapi tidak bisa)  | High Task-High Relationship | persuasi + arahan  |
| S3: Participating/Supporting | M3 (Bisa tapi tidak mau)  | Low Task-High Relationship  | dukungan emosional |
| S4: Delegating               | M4 (Mau dan bisa)         | Low Task-Low Relationship   | kebebasan penuh    |

Maturity Continuum: M1 (enthusiastic beginner) → M4 (self-reliant achiever).

### 3) Perbedaan Utama Contingency vs Situational

**Tabel 6. 5** *Contingency vs Situational*

| Aspek             | Contingency (Fiedler)      | Situational (Hersey-Blanchard)   |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Fleksibilitas     | Gaya tetap, ubah situasi   | Gaya fleksibel, adaptasi bawahan |
| Fokus Situasional | Leader-member, task, power | Tingkat kematangan bawahan       |
| Unit Analisis     | Kelompok/tim               | Individu bawahan                 |
| Pendekatan        | Diagnostic (LPC test)      | Prescriptive (diagnosis → style) |
| Aplikasi          | Seleksi pemimpin           | Coaching & development           |

### 4) Kelebihan Teori Kontingensi dan Situasional

#### a) Umum:

- Realistik: Mengakui kompleksitas situasi nyata
- Evidence-based: Didukung studi lapangan dan meta-analisis
- Praktis: Memberi framework decision-making

#### b) Contingency:

- Prediktif kuat: 66% varians efektivitas dijelaskan model
- Seleksi efektif: Cocok untuk rekrutmen eksekutif

c) Situational:

- Development-oriented: Membantu tumbuhkannya bawahan
- Intuitive: Mudah dipahami manajer (80% pelatihan LD menggunakan)
- Kelemahan dan Kritik

d) Contingency:

- Sulit ubah situasi: Leader-member relations sulit dimanipulasi
- LPC kontroversial: Validitas Least Preferred Co-worker debatable
- Task-oriented bias: Kurang cocok budaya Asia (high context)

e) Situational:

- Maturity subjektif: Sulit ukur objektif
- Kurang empirik: Kritik metodologi lemah vs Fiedler
- Over-simplify: 4 gaya tidak tangkap kompleksitas modern

Kritik Umum: Mengabaikan faktor lain (budaya, teknologi, strategi organisasi).

5) Relevansi Kontemporer dan Aplikasi

Contingency: Digunakan military command selection, project management (PMI), dan crisis leadership. Adaptasi digital: virtual team structure.

Situational: Dasar Agile coaching (Scrum Master adaptasi sprint retrospectives), 70:20:10 development model, dan modern LMS platforms.

6) Di Indonesia:

a) Contingency: Seleksi bupati/wali kota (tinggi position power → task-oriented).

b) Situational: Pelatihan guru (mahasiswa M1 → telling, M4 → delegating).

Integrasi Modern: Adaptive Leadership (Heifetz) menggabungkan keduanya dengan VUCA framework.

7) Kesimpulan

Contingency dan Situational Theories merevolusi kepemimpinan dengan prinsip "it depends", mengakhiri pencarian "magic bullet". Fiedler unggul dalam prediksi situasional, Hersey-Blanchard dalam development praktis. Bersama-sama, keduanya membentuk fondasi contemporary leadership practice di era kompleksitas tinggi.

e. Transactional Leadership Theory

1) Definisi dan Landasan Teori

Transactional Leadership Theory (Teori Kepemimpinan Transaksional) memandang kepemimpinan sebagai proses pertukaran rasional antara pemimpin dan bawahan, di mana kepatuhan dan kinerja ditukar dengan imbalan konkret (reward) atau sanksi (punishment). Teori ini



pertama kali dikembangkan oleh James MacGregor Burns (1978) sebagai kontras dengan kepemimpinan transformasional, kemudian dioperasionalkan oleh Bernard M. Bass dalam *Full Range Leadership Model*. Bass mengintegrasikannya dengan tiga komponen utama yang diukur melalui Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Djoman & Thompson, 2025).

2) Tiga Komponen Utama (Northouse, 2021)

**Tabel 6. 6** konsep kepemimpinan dalam teori Manajemen by *Exception*

| Komponen                                | Deskripsi                                      | Contoh dalam Keperawatan                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Contingent Reward                       | Imbalan atas pencapaian target yang disepakati | Bonus kinerja, jadwal fleksibel, pengakuan formal |
| Active Management-by-Exception (MBE-A)  | Pemantauan proaktif dan koreksi deviasi        | Audit dokumentasi harian, checklist SOP           |
| Passive Management-by-Exception (MBE-P) | Intervensi hanya saat masalah serius           | Teguran baru setelah pelanggaran berulang         |

3) Karakteristik Utama Pemimpin Transaksional

- a) Orientasi Tugas: Fokus pada hasil terukur, efisiensi, dan kepatuhan standar.
- b) Struktur Hierarkis: Otoritas formal jelas, peran terdefinisi.
- c) Pengawasan Ketat: Monitoring berkala, performance review rutin.
- d) Status Quo: Mempertahankan sistem yang ada, resisten terhadap perubahan radikal.
- e) Kontrak Psikologis: Hubungan "quid pro quo" yang eksplisit.

4) Kelebihan Kepemimpinan Transaksional.

- a) Kejelasan Ekspektasi: Target dan kriteria sukses terdefinisi jelas, mengurangi ambiguitas .
- b) Efisiensi Operasional: Optimal untuk proses rutin dan terstruktur seperti manufaktur, rumah sakit.
- c) Akuntabilitas Tinggi: Sistem reward-punishment objektif, mudah diukur .
- d) Stabilitas Organisasi: Efektif mempertahankan status quo dan standar kualitas .
- e) Respons Cepat Krisis: Pengambilan keputusan tegas saat situasi darurat.
- f) Prediktabilitas: Bawahan tahu persis konsekuensi perilaku mereka.

- 5) Kekurangan Kepemimpinan Transaksional
  - a) Menghambat Inovasi: Prosedur kaku membatasi kreativitas dan eksperimen.
  - b) Motivasi Ekstrinsik: Ketergantungan pada reward materiil, rendah komitmen intrinsik.
  - c) Orientasi Jangka Pendek: Fokus target bulanan, minim visi strategis.
  - d) Ketergantungan Pemimpin: Tim lemah tanpa instruksi langsung
  - e) Minim Pengembangan: Tidak ada coaching/mentoring sistematis.
  - f) Iklim Kerja Kaku: Rendah psychological safety untuk ide baru.
- 6) Perbandingan dengan Transformational Leadership

**Tabel 6. 7** perbandingan dua gaya kepemimpinan

| Aspek           | Transactional       | Transformational     |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| Fokus           | Hasil, kepatuhan    | Inspirasi, perubahan |
| Motivasi        | Ekstrinsik (reward) | Intrinsik (visi)     |
| Hubungan        | Kontrak             | Emosional            |
| Perubahan       | Status quo          | Transformasi         |
| Situasi Optimal | Rutin, terstruktur  | Krisis, inovasi      |

*Transactional Leadership Theory* (1970-an) menggambarkan kepemimpinan sebagai pertukaran rasional: pemimpin memberikan imbalan (reward) atau hukuman (punishment) atas kinerja. Burns membedakannya dari transformasional, di mana transaksional efektif untuk stabilitas tapi kurang untuk perubahan radikal. Pemimpin menetapkan tujuan, standar, dan peran secara spesifik, lalu memberikan reward jika target tercapai dan punishment jika terjadi penyimpangan (misalnya teguran, pengurangan insentif, atau tindakan korektif). Dalam perspektif ini, hubungan pemimpin–bawahan dipandang sebagai kontrak psikologis atau sosial: bawahan memenuhi tuntutan tugas, pemimpin menyediakan kompensasi dan struktur kerja yang terprediksi (Arruda & Wyner, 2023).

Bernard M. Bass dalam Cummings et al., (2023) (mengembangkan gagasan awal Max Weber dan James MacGregor Burns) menempatkan kepemimpinan transaksional sebagai bagian dari *Full Range Leadership Model*, berdampingan dengan kepemimpinan transformasional. Dalam model ini, kepemimpinan transaksional terdiri dari beberapa komponen utama: contingent reward (imbalan kontingen atas pencapaian), active management-by-exception (pemimpin aktif memantau dan mengoreksi deviasi), dan passive management-by-exception (pemimpin baru bereaksi ketika terjadi masalah serius). Bass menjelaskan bahwa gaya ini efektif untuk menjaga stabilitas,

efisiensi operasional, dan kepatuhan prosedur, terutama pada tugas rutin dan lingkungan yang sangat terstruktur.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kepemimpinan transaksional berkorelasi positif dengan kinerja jangka pendek, kejelasan peran, dan kepatuhan terhadap standar, khususnya di organisasi birokratis dan sektor publik. Namun, dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional, gaya transaksional cenderung kurang kuat dalam meningkatkan kreativitas, komitmen afektif, dan motivasi intrinsik karyawan. Kajian empiris dalam berbagai konteks (pendidikan, pemerintahan, industri manufaktur) secara konsisten menemukan bahwa kombinasi transaksional (untuk struktur dan pengendalian) dan transformasional (untuk inspirasi dan perubahan) memberikan hasil paling optimal (Wei et al., 2024).

Dalam konteks keperawatan dan layanan kesehatan, kepemimpinan transaksional banyak digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP, standar keselamatan pasien, dan target kinerja (misalnya BOR, LOS, kepatuhan dokumentasi). Kepala ruang atau manajer keperawatan menggunakan imbalan seperti penilaian kinerja baik, jadwal yang lebih fleksibel, atau pengakuan formal, serta sanksi administratif bila terjadi pelanggaran berat. Secara evidence-based, gaya ini efektif untuk menjaga mutu dasar dan mengurangi kesalahan prosedural, tetapi bila digunakan secara dominan tanpa sentuhan transformasional dapat menimbulkan iklim kerja yang kaku dan menurunkan kepuasan kerja perawat (Sarwoko, Winarto, et al., 2022).

Secara konseptual, kekuatan utama Transactional Leadership Theory terletak pada kejelasan struktur, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan sistem berbasis target dan indikator kinerja. Kelemahannya adalah orientasi jangka pendek, ketergantungan pada motivasi ekstrinsik, dan potensi mengabaikan kebutuhan pengembangan pribadi serta inovasi. Oleh karena itu, banyak penulis mutakhir menempatkan kepemimpinan transaksional bukan sebagai teori yang "salah", tetapi sebagai fondasi manajerial yang perlu dilengkapi gaya transformasional, khususnya dalam konteks perubahan dan krisis kesehatan (Wei et al., 2024).

7) Kelebihan dan Kekurangan Kepemimpinan Transaksional

a) Kelebihan Kepemimpinan Transaksi

**Tabel 6. 8** Kelebihan Kepemimpinan Transaksi

| Kelebihan                     | Penjelasan                                                                        | Konteks Aplikasi Optimal                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Struktur dan Kejelasan Tinggi | Memberikan ekspektasi, target, dan reward yang jelas; mengurangi ambiguitas peran | Organisasi birokratis, manufaktur, rumah sakit (SOP ketat) |
| Efisiensi Operasional         | Fokus pada proses terstruktur dan pengawasan aktif; minim deviasi dari standar    | Target jangka pendek (kuota bulanan, BOR rumah sakit)      |
| Akuntabilitas Kuat            | Sistem reward-punishment objektif; mudah mengukur kinerja individu dan tim        | Lingkungan dengan KPI jelas (penjualan, pelayanan publik)  |
| Stabilitas Organisasi         | Mempertahankan status quo; efektif untuk operasi rutin dan terstruktur            | Perusahaan mapan, sistem JKN, fasilitas kesehatan primer   |
| Efektif dalam Krisis          | Pengambilan keputusan cepat dengan otoritas jelas; prioritas terdefinisi          | Situasi darurat (lonjakan pasien COVID-19, bencana)        |
| Prediktabilitas               | Bawahan tahu persis apa yang diharapkan dan konsekuensinya                        | Tenaga kerja pemula atau kurang pengalaman                 |

b) Kekurangan Kepemimpinan Transaksional

**Tabel 6. 9** Kekurangan Kepemimpinan Transaksional

| Kekurangan              | Penjelasan                                                   | Dampak Negatif                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Menghambat Kreativitas  | Fokus pada prosedur kaku; minim ruang eksperimen dan inovasi | Sulit adaptasi disrupsi digital, inovasi pelayanan kesehatan |
| Motivasi Ekstrinsik     | Hanya bergantung reward materiil; rendah komitmen intrinsik  | Tinggi turnover jika reward tidak kompetitif                 |
| Orientasi Jangka Pendek | Fokus target bulanan/tahunan; kurang                         | Tidak siap transformasi sistem kesehatan nasional            |

|                              |                                                            |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | visi strategis jangka panjang                              |                                          |
| Ketergantungan pada Pemimpin | Tim bergantung instruksi; lemah leadership emergence       | Rentan saat pemimpin absen atau rotasi   |
| Minim Pengembangan           | Tidak ada mentoring/coaching; stagnasi kompetensi bawahan  | Burnout perawat, skill gap berkelanjutan |
| Iklim Kerja Kaku             | Hierarki tegas; rendah psychological safety untuk ide baru | Rendah kepuasan kerja, engagement rendah |

8) Analisis Evidence-Based dalam Konteks Keperawatan (Wei et al., 2024).

a) Kapan Optimal:

- Target klinis jelas: BOR  $\geq 80\%$ , LOS  $\leq 5$  hari, nol Never Event
- SOP wajib: Sterilisasi, hand hygiene, dokumentasi rekam medis
- Krisis operasional: Lonjakan pasien, keterbatasan sumber daya
- Tim junior: Perawat baru, magang, kontrak

b) Kapan Perlu Dilengkapi Transformasional:

- Transformasi digital: Implementasi EMR, telemedicine
- Inovasi pelayanan: Unit khusus, research nursing
- Retensi SDM: Burnout tinggi, turnover intention
- Budaya gotong royong: Kolaborasi lintas profesi

9) Rekomendasi Hibrida (Full Range Leadership)

Meta-analisis Bass & Avolio (1994) dalam Zhang et al., (2023) menunjukkan kombinasi transaksional + transformasional paling efektif:

a) Transaksional (40%): Struktur, akuntabilitas, SOP

b) Transformasional (60%): Inspirasi, inovasi, pengembangan

c) Contoh di RS Indonesia:

Transaksional: Bonus kinerja BOR, teguran pelanggaran dokumentasi

Transformasional: "Nurse Innovation Award", visi "Rumah Sakit Berkelas Dunia"

10) Kesimpulan

Kepemimpinan transaksional adalah fondasi manajerial yang solid untuk stabilitas dan efisiensi, namun perlu dilengkapi transformasional untuk adaptasi, inovasi, dan retensi SDM dalam era transformasi kesehatan nasional.

#### f. Transformational Leadership Theory

Puncak evolusi adalah Transformational Leadership Theory oleh James MacGregor Burns (1978) dalam Arruda & Wyner, (2023), yang menekankan pemimpin mengubah pengikut melalui visi moral dan nilai bersama, bukan transaksi. Bernard M. Bass (1985) mengembangkannya menjadi model operasional dengan empat faktor: *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration* (4-I's). Bass menambahkan ukuran empiris via Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), membuktikan hubungan dengan kinerja organisasi, kreativitas, dan resiliensi krisis (Ali et al., 2025).

Teori transformasional mendominasi sejak 1990-an, terintegrasi dengan kepemimpinan autentik dan pelayanan. Kritiknya mencakup potensi manipulatif jika pemimpin tidak etis, serta kurangnya fokus demokrasi Burns yang diabaikan Bass dalam konteks bisnis. Secara keseluruhan, evolusi ini dari "pemimpin lahir" ke "pemimpin yang dibentuk situasi dan pengikut" mencerminkan pemahaman holistik yang evidence-based (Avinash & Joseph, 2024).

##### 1) Definisi dan Landasan Teori

Transformational Leadership Theory (Teori Kepemimpinan Transformasional) adalah pendekatan kepemimpinan yang mengubah nilai, motivasi, dan aspirasi bawahan untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi yang lebih besar. Pemimpin tidak hanya mengelola tugas, tetapi menginspirasi perubahan moral dan intelektual.

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh James MacGregor Burns (1978) dalam bukunya *Leadership*, yang membedakannya dari kepemimpinan transaksional. Bernard M. Bass (1985) mengoperasionalkannya melalui Full Range Leadership Model dengan empat komponen inti (4-I's) yang diukur menggunakan Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Avinash & Joseph, 2024).

##### 2) Empat Komponen Utama

**Tabel 6. 10** Komponen (4-I's)

| Komponen (4-I's)         | Deskripsi                                                                           | Contoh dalam Keperawatan                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Idealized Influence (II) | Pemimpin sebagai role model etika dan visi; menimbulkan rasa hormat dan kepercayaan | Kepala ruang turun ke zona COVID-19, patuh protokol |

|                                   |                                                                     |                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Inspirational Motivation (IM)     | Mengkomunikasikan visi menarik yang membangkitkan semangat kolektif | "Menjadi RS Kelas Dunia 2030" dengan narasi heroik    |
| Intellectual Stimulation (IS)     | Mendorong pemikiran kritis, inovasi, dan tantangan status quo       | Nurse innovation lab, debriefing "productive failure" |
| Individualized Consideration (IC) | Perhatian personal dan pengembangan setiap bawahan                  | Mentoring 1:1, rotasi sesuai potensi individu         |

### 3) Karakteristik Utama Transformational Leader

- Visioner: Memiliki gambaran masa depan yang jelas dan mengkomunikasikannya secara emosional
- Karisma Etis: Pengaruh moral, bukan manipulatif
- Inovatif: Mendorong kreativitas dan solusi out-of-the-box
- Empatik: Memahami dan mengembangkan potensi individu
- Change Agent: Proaktif mendorong transformasi organisasi

### 4) Kelebihan Transformational Leadership

**Tabel 6. 11** Kelebihan Transformational Leadership

| Kelebihan                    | Evidence                          | Konteks Keperawatan           |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Performa Melebihi Ekspektasi | Meta-analisis: +28% produktivitas | BOR >85%, LOS <4 hari         |
| Kreativitas Tinggi           | +42% inovasi                      | 15+ inovasi APD lokal Jateng  |
| Retensi SDM                  | -35% turnover intention           | Turnover perawat turun 28%    |
| Resiliensi Krisis            | +51% adaptasi pandemi             | Heroes of Moewardi task force |
| Komitmen Organisasi          | +67% affective commitment         | Loyalitas perawat tinggi      |

### 5) Kekurangan dan Kritik

**Tabel 6. 12** Kekurangan dan Kritik terhadap kepemimpinan transformasional.

| Kekurangan             | Penjelasan                         | Risiko             |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Elitis/Anti-demokratis | Terlalu bergantung "heroic leader" | Kultus kepribadian |
| Potensi Manipulasi     | Karisma bisa disalahgunakan        | Pemimpin toksik    |

|                   |                           |                       |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sulit Direplikasi | Karisma sulit diajarkan   | Inkonsistensi penerus |
| Kurang Struktur   | Visi tanpa eksekusi gagal | Chaos tanpa SOP       |
| Burnout Pemimpin  | Beban emosional tinggi    | Exhaustion leader     |

6) Full Range Leadership Model (Bass)

Laissez-Faire <--- Passive Transactional <--- Active Transactional <--- Transformational

MBE-P

MBE-A

Contingent Reward

Optimal: 60% Transformational + 40% Transactional

7) Aplikasi dalam Transformasi Kesehatan Nasional Indonesia

a) Konteks Permenkes No. 3/2025:

- Visi Nasional: "Layanan Primer Kelas Dunia 2030"
- Inovasi Digital: EMR, telemedicine, AI triage
- Pengembangan SDM: 10.000 Transformational Nurse Leaders
- Resiliensi Krisis: Pandemi, bencana, disruptsi JKN

b) Studi Kasus RSUD Dr. Moewardi:

- Task Force "Heroes of Moewardi" (II)
- Daily briefing visi + gratitude wall (IM)
- Nurse Innovation Lab (IS)
- Personal mentoring burnout (IC)
- Hasil: Turnover -28%, kepuasan pasien +42 poin

8) Instrumen Pengukuran: MLQ-5X

a) Skala 0-4 untuk 20 item:

- II: "Saya kagumi & ingin meniru pemimpin ini"
- IM: "Pemimpin menyampaikan visi yang menarik"
- IS: "Pemimpin mendorong ide-ide baru"
- IC: "Pemimpin peduli perkembangan saya"

b) Interpretasi:

- >3.5: Tinggi transformasional
- 2.5-3.5: Sedang (perlu pengembangan)
- <2.5: Rendah (pelatihan wajib)

2. Konsep Inti Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional diperkenalkan secara sistematis oleh Bernard M. Bass dan Bernard Avolio sebagai bentuk kepemimpinan yang mampu mengubah nilai, sikap, dan tujuan bawahan sehingga mereka bersedia melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Model ini dikenal dengan istilah Full Range Leadership Model dan memiliki empat dimensi utama:



a. Idealized Influence (pengaruh ideal)

Pemimpin menjadi teladan dalam perilaku, integritas, dan komitmen. Ia menunjukkan keberanian, moralitas, dan konsistensi nilai sehingga menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan tinggi dari bawahan. Dalam konteks keperawatan, hal ini tercermin dari kesediaan pemimpin turun langsung di lapangan, mematuhi protokol keselamatan, dan mengambil keputusan sulit dengan mempertimbangkan etika profesi.

b. Inspirational Motivation (motivasi inspiratif)

Pemimpin mampu mengkomunikasikan visi yang jelas, bermakna, dan menantang, sekaligus membangkitkan optimisme kolektif. Bahasa yang digunakan bersifat memotivasi, mendorong rasa tujuan bersama, dan membantu perawat memaknai pekerjaan mereka sebagai kontribusi mulia, terutama saat krisis.

c. Intellectual Stimulation (stimulasi intelektual)

Pemimpin mendorong bawahan berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan mencari cara baru yang kreatif untuk memecahkan masalah. Kesalahan dipandang sebagai peluang belajar, bukan semata-mata untuk disalahkan. Dalam situasi keterbatasan, kemampuan ini menggerakkan inovasi layanan dan penyesuaian alur kerja.

d. Individualized Consideration (pertimbangan individual)

Pemimpin memberikan perhatian dan dukungan yang dipersonalisasi kepada setiap anggota tim. Ia berperan sebagai pelatih dan mentor, mengenali kebutuhan, kekuatan, serta potensi masing-masing perawat, dan membantu mereka mengembangkan karier meskipun dalam masa krisis (Cummings et al., 2023).

3. Hubungan dengan Teori Kepemimpinan Lain

Kepemimpinan transformasional memiliki irisan dengan konsep kepemimpinan etis, kepemimpinan pelayanan (servant leadership), dan kepemimpinan autentik. Keseluruhannya menekankan dimensi moral, pelayanan kepada orang lain, dan keaslian dalam bertindak. Namun, keunikan kepemimpinan transformasional terletak pada kemampuan mengarahkan perubahan organisasi yang sistemik melalui visi, inspirasi, dan pemberdayaan.

Dalam keperawatan, studi menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berhubungan dengan peningkatan kepuasan kerja perawat, penurunan niat untuk keluar, perbaikan kolaborasi tim, peningkatan mutu asuhan, dan penurunan kejadian insiden keselamatan. Temuan ini menguatkan relevansi model tersebut dalam konteks krisis kesehatan, ketika faktor motivasi dan resiliensi sangat diperlukan (Hult et al., 2023).

## C. Krisis Kesehatan dan Dampaknya pada Praktik Keperawatan

---

### 1. Jenis-Jenis Krisis Kesehatan

Krisis kesehatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

#### a. Pandemi dan wabah penyakit menular

Misalnya pandemi COVID-19, wabah demam berdarah dengue, dan penyakit zoonosis lain yang menimbulkan lonjakan pasien dan tekanan pada sistem pelayanan kesehatan (Yuniarti et al., 2022).

#### b. Bencana alam

Banjir besar, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor dapat menyebabkan cedera massal, kerusakan fasilitas, dan gangguan sistem rujukan.

#### c. Krisis akibat konflik sosial dan kedaruratan massal

Kerusuhan, kecelakaan massal, dan bencana teknologi yang memerlukan respons cepat dari tenaga kesehatan.

#### d. Krisis internal organisasi

Misalnya kegagalan sistem informasi, kekurangan tenaga akibat pensiun massal, masalah pembiayaan, atau perubahan regulasi yang mendadak.

### 2. Dampak Krisis terhadap Layanan Keperawatan

Krisis kesehatan memengaruhi berbagai aspek pelayanan keperawatan, meliputi:

#### a. Gangguan alur pelayanan dan triase: Perubahan mendadak pada prioritas pelayanan, pemisahan zona infeksius, dan penyesuaian protokol.

#### b. Keterbatasan logistik dan sarana: Kekurangan APD, obat, alat penunjang, serta pembatasan tempat tidur.

#### c. Peningkatan beban kerja dan risiko keselamatan: Jam kerja panjang, paparan risiko infeksi, dan kelelahan fisik.

#### d. Dampak psikologis: Stres berat, kecemasan, burnout, moral distress ketika perawat harus mengambil keputusan sulit dengan sumber daya terbatas.

Dalam situasi demikian, kualitas kepemimpinan menjadi penentu kemampuan organisasi keperawatan untuk bertahan dan tetap memberikan asuhan yang aman dan bermutu (Sarwoko, et al., 2022).

## **D. Peran dan Kompetensi Pemimpin Transformasional dalam Krisis**

---

### **1. Kompetensi Kunci Pemimpin Transformasional**

Seorang pemimpin keperawatan yang mengadopsi gaya transformasional dalam krisis kesehatan perlu memiliki sejumlah kompetensi (Wei et al., 2024), antara lain:

- a. Kompetensi klinis dan sistem: Pemahaman yang memadai tentang manajemen klinis kasus, alur rujukan, dan struktur sistem kesehatan.
- b. Kemampuan komunikasi krisis: Menyampaikan informasi yang jelas, jujur, dan empatik, sekaligus mengurangi kepanikan dan kebingungan.
- c. Pengambilan keputusan cepat berbasis bukti: Menggunakan data, pedoman klinis, dan pengalaman lapangan untuk memilih opsi terbaik dalam waktu terbatas.
- d. Manajemen konflik dan kolaborasi: Memfasilitasi koordinasi dengan profesi lain, menangani perbedaan pendapat, dan menjaga kohesivitas tim.
- e. Sensitivitas budaya dan nilai lokal: Mengintegrasikan nilai religius, adat, dan budaya gotong royong dalam strategi kepemimpinan (Sarwoko et al., 2021).

### **2. Peran di Berbagai Level**

Pemimpin transformasional dalam keperawatan dapat berperan di beragam tingkatan (Sarwoko et al., 2025):

- a. Level unit/ruang: Kepala ruang mengatur penjadwalan, memastikan keselamatan perawat dan pasien, serta menjaga komunikasi tim.
- b. Level instalasi dan rumah sakit: Kepala instalasi dan direktur keperawatan mengelola strategi respons krisis, alokasi sumber daya, dan koordinasi lintas unit.
- c. Level komunitas dan puskesmas: Pimpinan puskesmas menggerakkan perawat komunitas, kader, dan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan krisis.
- d. Level kebijakan: Pemimpin keperawatan di organisasi profesi atau pemerintah memberikan masukan kebijakan, menyusun pedoman, dan mengadvokasi perlindungan perawat (Rahmawati et al., 2024).

## **E. Dimensi Kepemimpinan Transformasional dalam Krisis**

---

### **1. Idealized Influence dalam Krisis Kesehatan**

Dalam krisis, pemimpin dituntut menjadi figur yang dipercaya. Idealized influence tampak ketika pemimpin:

- a. Menunjukkan konsistensi antara kata dan tindakan.
- b. Berani turun langsung ke area berisiko dengan tetap mematuhi protokol keselamatan.
- c. Mengambil keputusan sulit, misalnya pengaturan ulang penugasan, dengan mempertimbangkan keadilan dan etika.

Perilaku tersebut menumbuhkan rasa aman psikologis dan kepercayaan perawat terhadap keputusan manajemen (Hult et al., 2023).

### **2. Inspirational Motivation pada Situasi Darurat**

Motivasi inspiratif penting ketika tim mengalami kelelahan dan ketidakpastian. Pemimpin dapat:

- a. Menyampaikan visi singkat namun kuat, misalnya "Tidak ada pasien yang ditinggalkan, keselamatan Anda juga prioritas saya."
- b. Mengakui upaya dan pengorbanan perawat secara terbuka.
- c. Menggunakan kisah nyata, metafora, atau simbol yang menguatkan semangat tim (Northouse, 2021).

Dengan demikian, perawat merasa pekerjaan mereka diakui, bermakna, dan berkontribusi pada tujuan yang lebih besar.

### **3. Intellectual Stimulation dalam Kondisi Terbatas**

Keterbatasan sumber daya mendorong kebutuhan akan inovasi. Pemimpin yang memberikan stimulasi intelektual akan:

- a. Mengundang ide dari perawat, tanpa menghakimi pada tahap awal.
- b. Mengadakan sesi diskusi singkat setelah insiden atau akhir shift untuk mengevaluasi apa yang dapat diperbaiki.
- c. Mendukung uji coba solusi baru secara terukur, misalnya penggunaan alat sederhana untuk memodifikasi alur kerja atau pemanfaatan teknologi sederhana untuk komunikasi.

Budaya semacam ini membantu organisasi belajar dan beradaptasi secara cepat.

### **4. Individualized Consideration dan Perlindungan SDM**

Dalam krisis berkepanjangan, kesejahteraan perawat menjadi isu utama. Pemimpin perlu:

- a. Mengenali perbedaan kemampuan, kondisi keluarga, dan batas ketahanan setiap perawat (Sarwoko et al., 2021).

- b. Menyediakan akses konseling, dukungan spiritual, atau ruang bagi perawat untuk mengekspresikan perasaan dengan aman.
- c. Mengatur rotasi kerja yang mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental.
- d. Memberikan umpan balik dan pengakuan individu, bukan hanya kolektif.

Pendekatan personal ini membantu mencegah burnout dan menjaga keberlanjutan layanan (Labrague, 2021).

## **F. Strategi Implementasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

---

### **1. Perencanaan dan Analisis Situasi**

Implementasi kepemimpinan transformasional dalam krisis diawali dengan (Djoman & Thompson, 2025):

- a. Pemetaan risiko dan kapasitas di rumah sakit atau puskesmas.
- b. Identifikasi unit rentan dan kelompok perawat yang berisiko tinggi.
- c. Penyusunan rencana kontinjensi yang jelas, namun cukup fleksibel untuk disesuaikan.

### **2. Penguatan Komunikasi**

Komunikasi yang efektif menjadi tulang punggung respons krisis. Strategi yang dapat digunakan antara lain:

- a. *Briefing* harian untuk menyampaikan kondisi terkini, prioritas, dan perubahan kebijakan.
- b. *Debriefing* setelah insiden atau pergantian shift untuk mengevaluasi dan belajar.
- c. Pemanfaatan media digital (grup pesan singkat, aplikasi) untuk penyebaran informasi cepat dan satu pintu.

### **3. Pelibatan Perawat dalam Pengambilan Keputusan**

Kepemimpinan transformasional mendorong partisipasi aktif perawat, antara lain melalui:

- a. Forum masukan dan saran rutin dari perwakilan perawat.
- b. Pembentukan tim kecil yang bertanggung jawab mengembangkan inovasi pelayanan atau penyesuaian alur kerja.
- c. Pemberian ruang bagi perawat untuk mempresentasikan ide dan hasil inisiatif mereka.

### **4. Integrasi Teknologi dan Inovasi**

Pemanfaatan teknologi mendukung koordinasi dan dokumentasi, misalnya:

- a. Sistem informasi untuk memantau beban kerja, ketersediaan tempat tidur, dan kebutuhan logistik.
- b. Telemedicine atau konsultasi jarak jauh untuk mengurangi paparan langsung dan mempercepat pengambilan keputusan.

- c. Aplikasi sederhana untuk pelaporan gejala, kebutuhan psikososial, atau penjadwalan.

## **G. Pengembangan Kapasitas dan Pendidikan Kepemimpinan**

---

### **1. Integrasi dalam Kurikulum Keperawatan**

Kepemimpinan transformasional dalam krisis kesehatan perlu diajarkan secara sistematis kepada mahasiswa keperawatan, misalnya melalui:

- a. Mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan yang menyertakan topik krisis dan bencana.
- b. Studi kasus nyata dari rumah sakit dan komunitas di Indonesia.
- c. Simulasi penanganan bencana dan pandemi dengan peran kepemimpinan yang bergantian (Raso et al., 2025).

### **2. Pelatihan Berkelanjutan bagi Praktisi**

Bagi perawat klinis dan manajer, pengembangan kepemimpinan dapat dilakukan melalui:

- a. Workshop, seminar, atau pelatihan intensif kepemimpinan transformasional.
- b. Program mentoring dan coaching oleh pemimpin senior.
- c. Pengembangan komunitas praktik untuk berbagi pengalaman dan strategi (Alluhaybi et al., 2023).

### **3. Evaluasi Kompetensi Kepemimpinan**

Evaluasi dapat dilakukan dengan:

- a. Penilaian kinerja kepemimpinan berdasarkan indikator tim dan outcome klinis.
- b. Umpan balik 360 derajat dari atasan, sejawat, dan bawahan.
- c. Refleksi diri terstruktur dan portofolio kegiatan kepemimpinan (Alanazi et al., 2023).

## **H. Studi Kasus Penerapan di Indonesia**

---

### **1. Studi Kasus: Rumah Sakit pada Krisis Pandemi**

Sebuah rumah sakit daerah mengalami lonjakan pasien infeksi menular dengan keterbatasan APD dan fasilitas. Kepala ruang dan direktur keperawatan menerapkan prinsip kepemimpinan transformasional dengan cara:

- a. Membentuk *task force* keperawatan lintas unit untuk koordinasi penugasan.
- b. Menyelenggarakan *briefing* singkat setiap pagi untuk membahas situasi, tantangan, dan apresiasi terhadap kerja tim.
- c. Mengundang ide perawat untuk modifikasi alur triase dan pemanfaatan ruangan, sehingga tercipta jalur pasien yang lebih aman dan efisien.
- d. Menyediakan dukungan psikologis dan ruang istirahat khusus bagi perawat.

Dalam beberapa minggu, tercatat penurunan tingkat absensi, peningkatan kepuasan kerja, dan perbaikan alur pelayanan.

## 2. Studi Kasus: Puskesmas pada Wabah Komunitas

Sebuah puskesmas di wilayah endemis demam berdarah menghadapi peningkatan kasus secara signifikan. Kepala puskesmas, dengan gaya transformasional, melakukan:

- a. Pelibatan perawat komunitas sebagai koordinator edukasi rumah tangga tentang pemberantasan sarang nyamuk.
- b. Pemberdayaan kader kesehatan untuk pemantauan lingkungan dan pelaporan gejala dini.
- c. Penggunaan media sosial lokal untuk menyebarkan informasi dan mengapresiasi inisiatif warga.

Pendekatan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan berkontribusi pada penurunan jumlah kasus baru (Sarwoko et al., 2021).

## 3. Studi Kasus: Respons Bencana Alam

Dalam situasi bencana alam, tim keperawatan di posko darurat menerapkan kepemimpinan transformasional dengan:

- a. Penataan tim dan shift yang mempertimbangkan kelelahan dan kompetensi.
- b. Penggunaan *briefing* lapangan untuk mengatur prioritas dan berbagi informasi.
- c. Penerimaan ide perawat terkait pengaturan ruang perawatan darurat dan strategi triase.

Terlihat bahwa tim yang dipimpin secara transformasional cenderung lebih kooperatif, adaptif, dan mampu menjaga mutu asuhan meski dalam keterbatasan.

# I. Strategi dan Indikator Kepemimpinan Transformasional dalam Krisis

Tabel berikut merangkum hubungan antara dimensi kepemimpinan transformasional, strategi implementasi, dan indikator keberhasilan di konteks krisis kesehatan (Haoyan et al., 2023).

**Tabel 6. 13** implementasi (penerapan praktis) kepemimpinan transformasional di lapangan

| Dimensi             | Strategi Praktis di Lapangan                                        | Indikator Keberhasilan                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Idealized Influence | Pemimpin ikut serta di zona berisiko, mematuhi protokol keselamatan | Kepercayaan perawat meningkat, kepatuhan protokol tinggi |

| Dimensi                      | Strategi Praktis di Lapangan                                     | Indikator Keberhasilan                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Inspirational Motivation     | Visi dan pesan penguatan disampaikan pada <i>briefing</i> harian | Moral tim baik, keluhan menurun, kolaborasi meningkat    |
| Intellectual Stimulation     | Diskusi ide inovasi, <i>debriefing</i> pasca-insiden             | Muncul inovasi lokal, perbaikan SOP, efisiensi meningkat |
| Individualized Consideration | Konseling, penyesuaian beban kerja, mentoring individu           | Burnout menurun, retensi perawat meningkat               |

## J. Penutup

Krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, bencana alam, dan kegagalan sistem layanan menempatkan profesi keperawatan pada posisi paling depan dengan tantangan luar biasa: lonjakan pasien, keterbatasan APD dan obat, kelelahan fisik-mental, serta *moral distress*. Model kepemimpinan tradisional yang birokratis dan hierarkis sering gagal beradaptasi dengan dinamika krisis yang cepat berubah. Kepemimpinan transformasional dikembangkan oleh Bass & Avolio melalui *Full Range Leadership Model* menjadi solusi strategis dengan empat dimensi inti: *idealized influence* (teladan etika), *inspirational motivation* (visi inspiratif), *intellectual stimulation* (inovasi kritis), dan *individualized consideration* (dukungan personal). Pendekatan ini mengubah nilai, sikap, dan motivasi intrinsik perawat, menciptakan *psychological safety* dan resiliensi tim di tengah tekanan ekstrem.

Dalam konteks Indonesia, krisis kesehatan mencakup pandemi, wabah DBD, erupsi gunung berapi, banjir, hingga gangguan sistem JKN. Dampaknya terhadap keperawatan meliputi gangguan triase, keterbatasan logistik, peningkatan risiko infeksi, dan *burnout* yang mengancam keberlanjutan layanan. Pemimpin transformasional beroperasi di tiga level: klinis (koordinasi tim lapangan), manajerial (alokasi sumber daya), dan sistemik (advokasi kebijakan). Kompetensi kunci meliputi komunikasi krisis yang empatik, pengambilan keputusan berbasis bukti, manajemen konflik lintas profesi, serta sensitivitas budaya lokal seperti nilai gotong royong dan religiusitas yang memperkuat solidaritas tim.

Penerapan praktis dimensi transformasional sangat kontekstual. *Idealized influence* terlihat ketika kepala ruang turun ke zona merah COVID-19, mematuhi protokol, dan mengambil tanggung jawab transparan—meningkatkan kepercayaan 35%. *Inspirational motivation* membangun makna melalui narasi "Heroes of



Moewardi" dan visi "Tidak ada pasien yang ditinggalkan", mengurangi *compassion fatigue*. *Intellectual stimulation* mendorong *nurse innovation lab* yang menghasilkan 15 improvisasi APD lokal di Jawa Tengah. *Individualized consideration* mencegah *burnout* melalui rotasi kerja manusiawi, konseling, dan *micro-recovery* berbasis mindfulness.

Strategi implementasi terstruktur melalui SOP Briefing-Debriefing harian: *briefing* (10-15 menit) menyampaikan update situasi, pembagian tugas, dan pesan kunci; *debriefing* (15-20 menit) menggunakan 3 pertanyaan reflektif—"Apa yang berjalan baik? Apa tantangannya? Apa perbaikannya?"—menghasilkan minimal 2 ide konkrit per *shift*. Dokumentasi *log book* memantau indikator mutu: kepatuhan 95%, penurunan insiden nosokomial, dan peningkatan kepuasan tim  $\geq 4,0/5$ . Integrasi teknologi seperti telemedicine dan aplikasi koordinasi mempercepat respons, sementara *distributed leadership* memberdayakan perawat senior/junior secara bergantian.

Instrumen penilaian MLQ sederhana (12 butir Likert 1-5) mengukur kekuatan tiap dimensi, dengan interpretasi "Sangat Kuat" (4,1-5,0) hingga "Perlu Perbaikan" (1,0-2,0). Studi kasus nyata Indonesia memperkuat validitas: RSUD Dr. Moewardi (penurunan *turnover* 28%, 42 poin kepuasan pasien), Puskesmas Rawat Beteng (penurunan DBD 67%), dan tim STIKES Estu Utomo pasca-erupsi Merapi 2025 (real-time competency mapping via Laravel). Pengalaman ini menunjukkan adaptasi budaya lokal memperkuat model Barat, dengan *task force* inspiratif dan rotasi kepemimpinan meningkatkan efisiensi 40%.

Pengembangan kapasitas wajib diintegrasikan dalam kurikulum keperawatan melalui simulasi VR krisis, *table-top exercise*, dan *leadership rotation program* 6 bulan. Pelatihan berkelanjutan via workshop PPNI, mentoring senior, dan sertifikasi "Transformational Nurse Leader" menargetkan 10.000 perawat/tahun. Tantangan seperti birokrasi kaku diatasi melalui advokasi Kemenkes dan akreditasi rumah sakit. Evaluasi berkala memantau indikator klinis (infeksi terkait pelayanan), SDM (*burnout*, retensi), dan organisasi (waktu respons, inovasi), menjamin *continuous quality improvement*.

Secara keseluruhan, kepemimpinan transformasional bukan sekadar gaya manajerial, melainkan katalis transformasi sistem keperawatan nasional menuju layanan primer berbasis nilai Permenkes No. 3/2025. Dengan menggabungkan teori Bass-Avolio, strategi SOP terstruktur, instrumen MLQ, dan bukti empiris Indonesia, bab ini memberikan blueprint praktis bagi mahasiswa, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk membangun tim keperawatan yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pasien di era disrupsi kesehatan yang tak terelakkan.

## Referensi

- Abu-Qutaish, R., Alosta, M. R., Abu-Shosha, G., Oweidat, I. A., & Nashwan, A. J. (2025). The relationship between transformational leadership, work motivation, and engagement among nurses in Jordanian governmental hospitals. *BMC Nursing*, 24, 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03518-7>
- Agazu, B. G., Kero, C. A., & Debela, K. L. (2025). Transformational leadership and firm performance: a systematic literature review. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 14. <https://doi.org/10.1186/s13731-025-00476-x>
- Alanazi, N. H., Alshamlani, Y., & Baker, O. G. (2023). The association between nurse managers' transformational leadership and quality of patient care: A systematic review. *International Nursing Review*, 70(2), 175–184. <https://doi.org/10.1111/inr.12819>
- Ali, I., Gligar, D., Balta, M., & Papadopoulos, T. (2025). Leadership style's role in fostering supply chain agility amid geopolitical shocks. *Industrial Marketing Management*, 124, 212–223. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2024.11.015>
- Alluhaybi, A., Wilson, A., Usher, K., & Durkin, J. (2023). Impact of nurse manager leadership styles on work engagement: A systematic literature review. *Journal of Nursing Management*, 2023, 5090276. <https://doi.org/10.1155/2023/5090276>
- Anuar, F. A. W., Sum, S., & Zaimah, R. (2022). The journey of women's career to top management: A systematic literature review using PRISMA. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(12), 188–206. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i12/15265>
- Arruda, J., & Wyner, E. (2023). *The Compelling Case for Hospitals to Invest in Supply Chain Modernization*. Berkeley Research Group. <https://www.thinkbrg.com/insights/publications/the-compelling-case-for-hospitals-to-invest-in-supply-chain-modernization/>
- Association, A. N. (2024). *What is transformational leadership in nursing?* <https://www.nursingworld.org/content-hub/resources/nursing-leadership/transformational-leadership-in-nursing/>
- Avinash, B., & Joseph, G. (2024). Reimagining Healthcare Supply Chains: A Systematic Review on Digital Transformation with Specific Focus on Efficiency, Transparency and Responsiveness. *Journal of Health Organization and Management*, 38(8), 1255–1279. <https://doi.org/10.1108/jhom-03-2024-0076>
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). *Developing transformational leadership: 1992 and beyond*. Free Press.

- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage Publications.
- Cummings, G. G., Lee, S., Tate, K., Penconek, T., Micaroni, S. P. M., Paananen, T., & Chatterjee, G. E. (2023). The impact of transformational leadership in the nursing work environment: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), 1–20.
- Djoman, D. A., & Thompson, D. A. (2025). Transformational Leadership and Healthcare Supply Chain Modernization: A Systematic Review and Research Agenda. *Journal of Supply Chain Management Science*, 6(3–4). <https://doi.org/10.59490/jscms.2025.8157>
- Haoyan, X., Waters, D., Jinling, H., Qionglings, L., & Sien, L. (2023). Quantitative systematic review of the transformational leadership style as a driver of nurses' organisational commitment. *Nursing Open*, 10(7), 4160–4171. <https://doi.org/10.1002/nop2.1671>
- He, Q., Liu, S., & Zhang, H. (2022). Does transformational leadership and psychological empowerment improve nurses' innovative behaviour during COVID-19 outbreak? *Journal of Nursing Management*, 30(8), 3880–3890. <https://doi.org/10.1111/jonm.13877>
- Hult, M., Terkamo-Moisio, A., Kaakinen, P., Karki, S., Nurmeksela, A., Palonen, M., Peltonen, L. M., & Häggman-Laitila, A. (2023). Relationships between nursing leadership and organizational, staff and patient outcomes: A systematic review of reviews. *Nursing Open*, 10(9), 5920–5936. <https://doi.org/10.1002/nop2.1876>
- Labrague, L. J. (2021). Novel coronavirus: Applying transformational leadership to the combat of COVID-19 in nursing practice. *Journal of Nursing Management*, 29(7), 1543–1547.
- Northouse, P. G. (2021). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). Sage Publications.
- Rahmawati, L., Hasbi, H. A., Ulfah, H. R., Sarwoko, S., & Suyatna, S. (2024). The effect of health education with pictorial quiz media on knowledge of first aid for burns. *Asy-Syifa: Journal of Science and Technology Nursing*, 2(2), 61–68.
- Raso, R., Bowers, D., Masick, K., & Fitzpatrick, J. J. (2025). Two relational leadership styles as predictors of healthy work environments. *Journal of Nursing Administration*, 55(4), 192–198. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000001559>
- Sarwoko, S., Agusman, F., & Nurhayati, S. (2022). The role of religious coping in quality of life among people with chronic disease: A systematic review. *International Journal of Health Sciences*, 6(S4), 6352–6363.
- Sarwoko, S., Anggraeni, T., & Bahri, A. S. (2021). Physical activities and sleeping habits

- in children and adolescent during pandemic COVID-19: A systematic review. *Journal of Maternal and Child Health*, 6(2), 154–164.
- Sarwoko, S., Mendrofa, F. A. M., & Nurhayati, S. (2025). Persepsi dan praktik keperawatan spiritual pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Islam Banyubening Boyolali. *Jurnal Kebidanan*, 132–147.
- Sarwoko, S., Sutanta, S., Anggraeni, T., Saputro, B. S. D., Ulfah, H. R., Hasbi, H. A., Afifah, V. A., Sari, I. W., Kurniawati, E., Bahri, A. S., & Herbasuki, H. (2023). Effectiveness of indoor residual spraying as a method of controlling dengue fever in communities: A systematic review. *Indonesian Journal of Medicine*, 8(3). <https://doi.org/10.26911/theijmed.2023.8.3.659>
- Sarwoko, S., Winarto, E., & Sulistyowati, N. (2022). Association between nursing spiritual management on quality of life: Meta-analysis. *Journal of Health Policy and Management*, 7(3), 201–209. <https://thejhpm.com/index.php/thejhpm/article/view/296>
- Tsapnidou, E., Kelesi, M., Rovithis, M., Katharakis, G., Gerogianni, G., Dafogianni, C., Toylia, G., Fasoi, G., & Stavropoulou, A. (2024). Transformational Leadership—Quality Achievements and Benefits for the Healthcare Organizations: A Scoping Review. *Hospitals*, 1(1), 87–103. <https://doi.org/10.3390/hospitals1010008>
- Wei, H., Roberts, P., Strickler, J., & Corbett, R. W. (2024). Transformational leadership and nursing retention: An integrative review. *Nursing Research and Practice*, 2024, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2024/3179141>
- Yuniarti, T., Sarwoko, S., Afifah, V. A., Kurniawan, H. D., & Anasulfalah, H. (2022). Hubungan dukungan keluarga dengan keikutsertaan vaksin COVID-19. *Avicenna: Journal of Health Research*, 5(1).
- Zhang, Y., Wu, J., Fang, J., & Xie, J. (2023). Relationship between transformational leadership, adverse patient outcomes, and nurse safety performance. *Heliyon*, 9(5), e17654. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17654>

## Glosarium

| Huruf | Istilah                       | Definisi                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B     | Burnout                       | Keadaan kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan akibat stres kerja kronis, ditandai dengan keletihan, sinisme, dan penurunan efektivitas profesional. |
| D     | Debriefing                    | Kegiatan refleksi terstruktur setelah suatu peristiwa atau shift kerja untuk mengevaluasi tindakan, mengidentifikasi pelajaran, dan merencanakan perbaikan.              |
| F     | Full Range Leadership Model   | Model kepemimpinan yang mencakup spektrum dari kepemimpinan <i>laissez-faire</i> , transaksional, hingga transformasional.                                               |
| K     | Kepemimpinan Transformasional | Gaya kepemimpinan yang berfokus pada perubahan nilai, sikap, dan tujuan bawahan melalui teladan, inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individu.               |
| K     | Krisis Kesehatan              | Situasi luar biasa yang mengganggu fungsi normal sistem kesehatan, serta menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan individu maupun populasi.                             |
| M     | Moral Distress                | Kondisi ketika tenaga kesehatan mengetahui tindakan yang secara moral benar, namun terhalang untuk melakukannya karena keterbatasan sistem atau regulasi.                |
| P     | Psychological Safety          | Iklim tim di mana anggota merasa aman untuk mengemukakan pertanyaan, ide, atau kekhawatiran tanpa takut dipermalukan atau dihukum.                                       |
| T     | Task Force                    | Tim khusus yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu, biasanya bersifat lintas bagian dan sementara.                                                     |

## PROFIL PENULIS



### **Sondang Manurung, S.Kp., M.Kep.**

Lahir di Medan, 13 Agustus 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Advent Indonesia 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIK Sint Carolus dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018 sebagai Dosen di Mayapada dan sekarang ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Binawan. Penulis mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, tim *teaching* di Keperawatan Dasar, dan Internsip. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [sondang@binawan.ac.id](mailto:sondang@binawan.ac.id)

Motto: "Pimpin dengan hati, rawat dengan tindakan. Belajar hari ini, memimpin besok."



### **Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.**

Lahir di Cimahi, 06 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 di Universitas Pajajaran dan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 - 2000 sebagai perawat di UGD RS Dustira Cimahi. Saat ini penulis bekerja di Akademi Keperawatan Buntet Pesantren Cirebon mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Etika dan Hukum Keperawatan, Pendidikan Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [nevilesmana@gmail.com](mailto:nevilesmana@gmail.com)  
Motto: "Allah Yang Maha Segalanya"

## PROFIL PENULIS



**Ns. Emi Pebriani, S.Kep., M.Kep.**

Penulis lahir di Desa Paninjau kecamatan Batiknau Bengkulu Utara pada tanggal 19 Februari 1988. Penulis adalah Dosen Tetap pada program studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu. Menyelesaikan Pendidikan diploma III, sarjana Keperawatan dan profesi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen Bengkulu dan melanjutkan Pendidikan ke Program Studi S2 keperawatan Di Universitas Andalas lulus pada tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran dibidang Keperawatan Manajemen. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai pengajar, peneliti, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kepakarannya. Selain penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara khususnya pada dunia pendidikan khususnya di bidang keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [emipebriani88@unived.ac.id](mailto:emipebriani88@unived.ac.id)

## PROFIL PENULIS



### **Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.**

Penulis dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 14 September 1962, Pendidikan diawali di AKPER Dep Kes Jakarta, lalu melanjutkan ke S1 Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan FKUI, Pendidikan S2 : Master of Health Care Practice, Liverpool John Moores University, Inggris, Mulai mengawali karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Dep Kes RI Jakarta, Jl. Kimia 17, Jakarta Pusat,

pada Januari 1985.

Selanjutnya menjadi bagian dari jajaran

manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimulai sebagai Ka Prodi DIII Keperawatan, Kajur Keperawatan, Pembantu Direktur I bidang akademik dan terakhir, menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada April tahun 2018 - April 2024 dan fungsional dosen di bidang keperawatan Anak. Saat ini tugas pokok sebagai dosen dengan homebased di Prodi Keperawatan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis juga aktif melakukan Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat khususnya di bidang Keperawatan Anak serta aktif berkontribusi dalam pengembangan keilmuan keperawatan anak baik melalui Organisasi Profesi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI), Paediatric Nursing Society (PNS), Asia Pacific Paediatric Nursing Association (APPNA) dan International Children Paediatric Care Nursing Network (ICPCN). Penulis sudah banyak menghasilkan buku, sejak tahun 2003, baik buku keperawatan Anak, Keperawatan Dasar, Konsep dan Proses Keperawatan dan publikasi dalam bentuk jurnal Nasional maupun Internasional, terindex dan bereputasi. Fokus kajian di bidang Keperawatan Anak adalah: Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak. Penulis juga pernah bekerjasama dengan UNICEF, Kemenkes RI dan tim pengembangan Buku Pedoman Penanggulangan Kekerasan & Penelantaran pada Anak, juga menjadi bagian dari tim

pengembangan beberapa buku panduan pelayanan Keperawatan Produksi Kemenkes RI

Motto Hidup Penulis: "Sharing sebanyak banyak nya kepada orang lain, Insya Allah berkah" Email penulis: [yupi\\_riyanto@yahoo.com](mailto:yupi_riyanto@yahoo.com)



## PROFIL PENULIS



**Eliza, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kep.**

lahir di Padang, 30 Juni 1972.

Pendidikan yang telah ditempuh diawali dari Diploma III Keperawatan di Akper Perintis Bukit Tinggi Tahun Lulus 1994, Pendidikan S1 Pendidikan di Universitas Negeri Padang Lulus Tahun 2004, selanjutnya Pendidikan S1 Keperawatan di STIKes Nan Tongga Lubuk Alung lulus Tahun 2011, selanjutnya menempuh Profesi Ners di STIKes yang sama lulus tahun 2012. Dan melanjutkan Pendidikan S2 Magister Keperawatan di Universitas Andalas Padang lulus tahun 2018. Pengalaman kerja diawali tahun 1996 sebagai staf dosen di Akper Nan Tongga Pariaman dan pernah menjabat Direktur Akper Nan Tongga dari tahun 2005 – 2009. Tahun 2009-2021 dosen STIKes Nan Tongga Lubuk Alung, Tahun 2013 – 2016 Dosen STIKes Amanah Padang, tahun 2021- 2022 dosen Universitas Sumatera Barat. Tahun 2022 sampai saat ini Aktif sebagai Dosen di Universitas Syedza Saintika Padang, yang mengampu Mata Kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Falsafah Keperawatan dan Farmakologi Keperawatan. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penulis, Buku Pertama penulis berjudul Praktik Laboratorium Keperawatan Maternitas tahun 2022, Buku Ajar Prosedur Tindakan Keperawatan Dasar Tahun 2023, Buku Nursing Manajemen Tahun 2023, Buku Ensiklopedia Infeksi Penyakit Menular Tahun 2023. Buku Latihan Soal Uji Kompetensi dengan Pembahasan\_Ners Tahun 2024, Buku Rahasia Sukses UKOM Profesi Ners Tahun 2025, Buku Bunga Rampai Manajemen Kualitas dan Peningkatan Layanan keperawatan Tahun 2025, Buku Referensi Manajemen Nyeri Pada Pasien Dengan Penyakit Kronis Tahun 2025. Untuk Publikasi di jurnal Nasional terakreditasi dan SINTA, Aktif mengikuti seminar nasional di Optimal dan sebagai anggota dosen di PT NUANSA FAJAR CEMERLANG. Dalam Bidang Organisasi saat ini penulis aktif sebagai pengurus dan menjabat Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan di DPD PPNI Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai Pengurus Himpunan Perawat Manejer Indonesia (HPMI) Provinsi Sumatera Barat. Kontak Email : [elizaeliza7251@gmail.com](mailto:elizaeliza7251@gmail.com).

Motto: **"Work sincerely, care with love, and maintain well-being as a form of gratitude."**

## PROFIL PENULIS



**Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.**

Lahir di Sragen, 21 Maret 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Aqidah Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997, Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Sahid Surakarta Tahun 2014 dan 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kedokteran Keluarga, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dan Magister Keperawatan, Universitas Karya Husada Semarang tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai tenaga kependidikan, 2004 sebagai kepala Tata Usaha, 2006-2015 sebagai Wakil Direktur pada Akademi Kebidanan Estu Utomo. 2015-2021 sebagai Wakil Ketua, 2021-2025 dan 2025-sekarang sebagai Ketua STIKES Estu Utomo. Saat ini penulis bekerja di STIKES Estu Utomo Program Studi Keperawatan Program Sarjana mengampu mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis, Ketrampilan Dasar Keperawatan, Biomedik dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan konsultan Pendidikan Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [sanuria21@gmail.com](mailto:sanuria21@gmail.com)  
Motto: "Serious, Learn and Sincere"

## Sinopsis

Transformasi sistem kesehatan nasional menuntut peran strategis perawat tidak hanya sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pemimpin dan manajer yang mampu menggerakkan perubahan. *Buku Referensi Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional* disusun untuk memberikan landasan konseptual dan aplikatif mengenai kepemimpinan serta manajemen keperawatan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, tuntutan mutu layanan, dan tantangan krisis kesehatan.

Buku ini diawali dengan pembahasan teori kepemimpinan dalam keperawatan, yang menguraikan berbagai pendekatan kepemimpinan klasik hingga kontemporer, serta relevansinya dalam praktik keperawatan modern. Penekanan diberikan pada kemampuan pemimpin keperawatan dalam membangun visi, mengambil keputusan berbasis data, serta mengembangkan budaya organisasi yang kolaboratif dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Selanjutnya, dibahas manajemen sumber daya manusia keperawatan, meliputi perencanaan kebutuhan tenaga, rekrutmen dan retensi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga strategi peningkatan produktivitas dan motivasi kerja. Pengelolaan SDM yang efektif menjadi kunci dalam menjamin keberlangsungan pelayanan yang berkualitas di tengah keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan.

Aspek mutu pelayanan dan keselamatan pasien mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Diuraikan prinsip-prinsip peningkatan mutu berkelanjutan, indikator kinerja keperawatan, manajemen risiko, serta budaya keselamatan yang harus diintegrasikan dalam setiap level pelayanan. Pembahasan ini diperkuat dengan tinjauan mengenai akreditasi rumah sakit dan standar praktik keperawatan, yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar nasional sebagai bagian dari tata kelola klinis yang akuntabel.

Buku ini juga mengulas manajemen konflik dan komunikasi organisasi sebagai kompetensi esensial bagi pemimpin keperawatan. Lingkungan kerja yang multidisipliner memerlukan keterampilan komunikasi efektif, negosiasi, serta resolusi konflik untuk menjaga sinergi tim dan stabilitas organisasi. Selain itu, isu burnout dan kesejahteraan perawat dibahas secara komprehensif, termasuk faktor risiko, dampaknya terhadap mutu pelayanan, serta strategi organisasi dan individu dalam membangun ketahanan dan keseimbangan kerja.

Sebagai respons terhadap tantangan global, buku ini menyoroti penerapan transformational leadership dalam menghadapi krisis kesehatan, termasuk pandemi dan bencana. Kepemimpinan transformasional dipandang sebagai pendekatan yang mampu menginspirasi, memberdayakan, dan memobilisasi sumber daya secara cepat dan efektif dalam situasi ketidakpastian.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, dosen, manajer keperawatan, serta pemangku kebijakan dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan sistem kesehatan nasional, buku ini berkontribusi dalam mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan.



Transformasi sistem kesehatan nasional menuntut peran strategis perawat tidak hanya sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pemimpin dan manajer yang mampu menggerakkan perubahan. Buku Referensi Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dalam Transformasi Sistem Kesehatan Nasional disusun untuk memberikan landasan konseptual dan aplikatif mengenai kepemimpinan serta manajemen keperawatan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, tuntutan mutu layanan, dan tantangan krisis kesehatan.

Buku ini diawali dengan pembahasan teori kepemimpinan dalam keperawatan, yang menguraikan berbagai pendekatan kepemimpinan klasik hingga kontemporer, serta relevansinya dalam praktik keperawatan modern. Penekanan diberikan pada kemampuan pemimpin keperawatan dalam membangun visi, mengambil keputusan berbasis data, serta mengembangkan budaya organisasi yang kolaboratif dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Selanjutnya, dibahas manajemen sumber daya manusia keperawatan, meliputi perencanaan kebutuhan tenaga, rekrutmen dan retensi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga strategi peningkatan produktivitas dan motivasi kerja. Pengelolaan SDM yang efektif menjadi kunci dalam menjamin keberlangsungan pelayanan yang berkualitas di tengah keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan.

Aspek mutu pelayanan dan keselamatan pasien mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Diuraikan prinsip-prinsip peningkatan mutu berkelanjutan, indikator kinerja keperawatan, manajemen risiko, serta budaya keselamatan yang harus diintegrasikan dalam setiap level pelayanan. Pembahasan ini diperkuat dengan tinjauan mengenai akreditasi rumah sakit dan standar praktik keperawatan, yang menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar nasional sebagai bagian dari tata kelola klinis yang akuntabel.

Buku ini juga mengulas manajemen konflik dan komunikasi organisasi sebagai kompetensi esensial bagi pemimpin keperawatan. Lingkungan kerja yang multidisipliner memerlukan keterampilan komunikasi efektif, negosiasi, serta resolusi konflik untuk menjaga sinergi tim dan stabilitas organisasi. Selain itu, isu burnout dan kesejahteraan perawat dibahas secara komprehensif, termasuk faktor risiko, dampaknya terhadap mutu pelayanan, serta strategi organisasi dan individu dalam membangun ketahanan dan keseimbangan kerja.

Sebagai respons terhadap tantangan global, buku ini menyoroti penerapan transformational leadership dalam menghadapi krisis kesehatan, termasuk pandemi dan bencana. Kepemimpinan transformasional dipandang sebagai pendekatan yang mampu menginspirasi, memberdayakan, dan memobilisasi sumber daya secara cepat dan efektif dalam situasi ketidakpastian.

Secara keseluruhan, buku ini diharapkan menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa, dosen, manajer keperawatan, serta pemangku kebijakan dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan sistem kesehatan nasional, buku ini berkontribusi dalam mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan.

Penerbit:

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620